



Diplôme d'Etat Ambulancier



Etablir une communication adaptée
pour informer et accompagner le
patient et son entourage

Table des matières

LES BASES DE LA COMMUNICATION : La théorie	4
LES BASES DE LA COMMUNICATION : Les outils.....	15
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE LORS DES STAGES.....	22
COMMUNICATION DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL	24
L'INTERROGATOIRE DU PATIENT	25
LA TRANSMISSION DU BILAN	29
LES DROITS DU PATIENT	34
LA BIENTRAITANCE AU QUOTIDIEN.....	42
DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE	52
SITUATIONS DE COMMUNICATION ALTEREE	60
Gériatrie	60
Le patient atteint d'Alzheimer	61
La crise suicidaire.....	62
LA PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE	64
VIOLENCE, BURN OUT, SYNDROME STRESS POST TRAUMATIQUE ET GESTION DE CONFLIT	78
Contexte de violence	78
Syndrome Stress Post-Traumatique.....	86
Burn out : syndrome d'épuisement professionnel	87
Comment réagir face à un conflit.....	88
LA FIN DE VIE/ CONCEPT DE MORT	94
SITUATIONS DE HANDICAP.....	97
Handicap mental	98
Handicap moteur.....	98
Handicap psychique (psychiatrique)	98
Handicap auditif	99
Handicap visuel.....	101
Difficultés d'élocution verbale	101

Les techniques de communication adaptées aux publics

LES BASES DE LA COMMUNICATION : La théorie

Qu'est-ce que la communication ?

L'étymologie du mot communiquer signifie mettre en commun. A l'origine, c'est un synonyme de communier, ou mettre en communauté, et progressivement il va prendre le sens de transmettre et d'échanger. La notion de communication est plus large et plus complexe que celle de l'information.

Au-delà d'un message à transmettre. **C'est établir une relation entre deux ou plusieurs personnes.**

La transmission d'informations représente seulement une partie du processus de la communication.

En effet, elle ne se limite pas à des paroles car c'est tout notre être qui communique, à travers une attitude, un comportement, un geste, un sourire, un regard, les vêtements que nous portons. En fait tout ce que nous sommes, ce que nous faisons communique avec le monde extérieur.

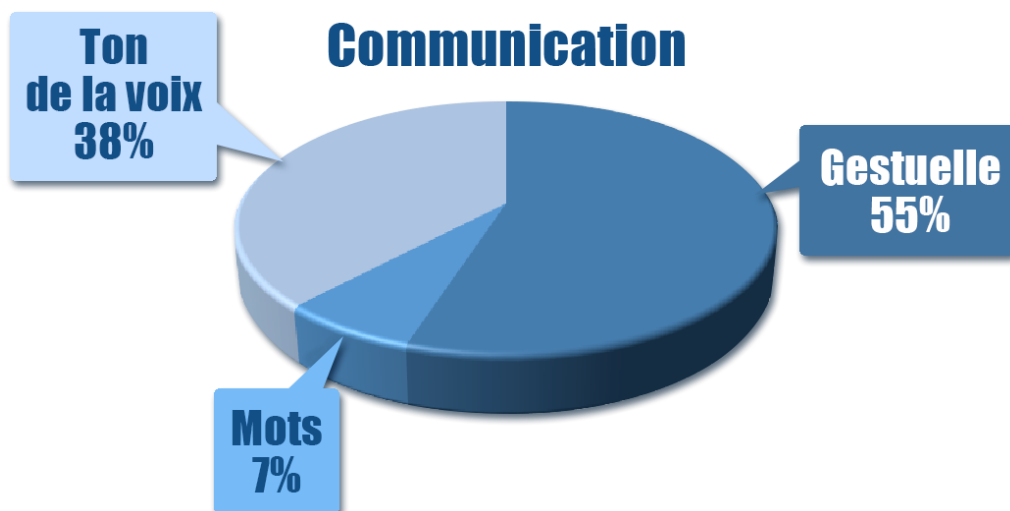
De plus, des mémoires inconscientes vont également intervenir bien malgré nous au cours d'une rencontre et peuvent amener à des réactions parfois incontrôlables. Communiquer c'est à la fois **partager ce que l'on a en commun et gérer les différences qui nous séparent.**

« La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit »

D'après Peter DRUCKER : 93% du message ne passe PAS par les mots.

- La communication peut être Verbale : écrite ou orale (CONSCIENTE)
- Non verbale : gestuelle, attitudes, mimiques (INCONSCIENTE)
- Paraverbale (intonation de voix, rythme). (SEMI CONSCIENT)

Faire pratiquer un exercice de déambulation dans la salle avec pour seule consigne de ne pas communiquer. Laisser les apprenants déambuler 1 à 2 minutes et les laisser constater les échanges de regards, de sourires complices ou les efforts pour ne pas croiser de regard.

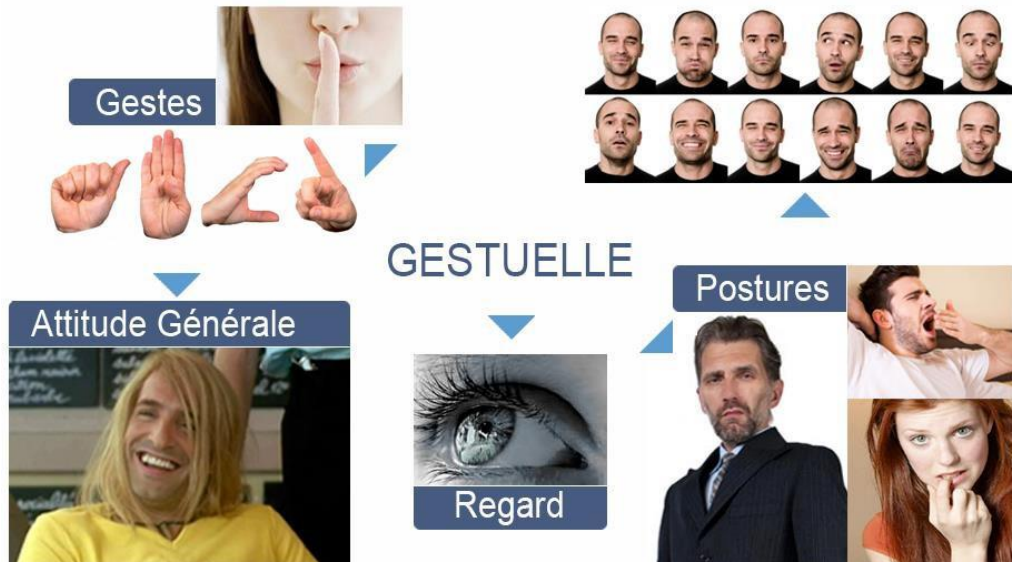


La communication non verbale : Le langage du corps

C'est la transmission et le partage entre deux personnes d'éléments signifiants (ayant un sens) sans l'emploi de la parole.

La communication non verbale est le premier mode de communication dans l'instauration de la relation mère-bébé, au travers du toucher ou des gestes, du regard, des odeurs...

Communication Non Verbale



1° Attitude générale

La première impression est importante dans la confiance que le patient souhaitera accorder d'emblée à l'ambulancier : hygiène et tenue impeccable sont gages de sérieux et reflètent l'image de l'entreprise. Une hygiène corporelle douteuse, une tenue négligée ou une posture nonchalante suscitent la méfiance et compliquent la communication avant même qu'elle ait pu s'instaurer.

2° Posture

La posture du patient peut traduire la douleur, la peur, le refus de communiquer....

Une attitude positive, ouverte, d'écoute, de disponibilité favorisent l'échange. A l'inverse, le téléphone portable dans la main, les yeux sur la montre, d'ostensibles bâillements sont autant de messages non verbaux qui signifient à l'interlocuteur le peu d'intérêt qu'on lui porte.

Dans une attitude d'écoute ou d'empathie, un mimétisme des attitudes favorise la relation. Il ne s'agit pas de singer l'interlocuteur mais d'adopter des postures similaires. C'est un processus naturel qui fait appel aux neurones miroirs découverts en 1990 par *Giacomo RIZZOLATTI*, physiologiste neurologue. Les neurones miroirs commandent inconsciemment l'imitation des postures et de la gestuelle d'une personne avec qui on est en accord. En terme plus scientifique, on appelle cela la synchronisation ou l'effet miroir. Et comme « on aime ce qui nous ressemble », le fait d'être imité par quelqu'un a un effet rassurant et favorise l'échange.

Certaines études non-verbales ont également montré que le fait d'acquiescer par de légers mouvements de tête, montrait inconsciemment son accord pendant une interaction.

La première impression et le jugement qu'un individu se fait au cours d'une nouvelle rencontre ont tendance à influencer ses sentiments futurs à l'égard de l'autre. Son opinion initiale demeure et même se consolide par la suite. Le visage et ses expressions jouent donc un rôle essentiel dans l'établissement d'un lien, puisqu'ils sont les premiers éléments observés.

3° Les gestes

Il y a les gestes **volontaires** ou *intentionnels*. Ils sont produits pour renforcer le discours, l'embellir ou le préciser. Le fameux : « c'est grand comme ça ! ». Un message dénué de tout geste est moins facile à comprendre. Il arrive cependant le langage corporel soit en contradiction avec les mots.

Exemple : « Tout va bien » dans une posture ou avec une intonation qui suggère le contraire.

La gestuelle constitue un **langage à part entière**. Pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer quelques gestes à la signification commune : un index sur la bouche demande le silence, des applaudissements approuvent et acclament, un poing levé se révolte, une main tendue fait la paix et le langage des signes permet aux malentendants de tenir une conversation.

Et puis il y a Les gestes **involontaires** ou *accidentels*. Ce sont ceux qui expriment nos émotions et nos intentions. Ces formes de communication non verbale sont probablement biologiquement ou génétiquement déterminées et sont communes à de nombreuses cultures, restant temporellement tout à fait stables (par exemple, les expressions faciales).

4° Visage et mimiques

Comme DARWIN, le psychologue Paul EKMAN, l'un des pionniers de l'**étude des expressions faciales**, affirme que les expressions du visage ne sont pas déterminées par la culture, mais qu'elles sont universelles. Il a publié « *Programme Génies* », une étude qui traite de la capacité naturelle des individus à détecter les mensonges, par l'interprétation des micro-expressions et d'autres expressions non-verbales. En 1972, EKMAN dresse une première version de sa liste des émotions de base : la colère, le dégoût, la haine, la surprise, la tristesse, la joie et la peur. Il élargit sa liste en 1990 par l'ajout de nouvelles émotions : l'amusement, le mépris, la satisfaction, la gêne, l'excitation, la culpabilité, la fierté dans la réussite, le soulagement, le plaisir sensoriel et la honte.

Ses travaux, utilisés par la police américaine, ont donné lieu à des séries télévisées bien connues comme « *Lie to me* », qui ont une réalité scientifique.

Le soignant n'a pas la maîtrise de ses micro-expressions furtives et involontaires. Cependant, un air de dégoût ou de désapprobation sont naturellement repérés par le patient et peuvent altérer irrémédiablement la relation de communication.

L'appréciation et les préjugés peuvent être influencés par l'état de santé (qui affecte les expressions du visage, comme l'anxiété ou la douleur) ou l'apport de certains artifices :

- ▶ Lunettes/ Accorder un niveau d'intelligence supérieur à celui qu'il est en réalité.
- ▶ Barbe/ Interpréter que la personne a un esprit rebelle.
- ▶ Excès de maquillage/ Entrevoir une moralité douteuse.

Les expressions du visage expriment les émotions. Être sincère et observer le patient dont le visage exprime ce qu'il ne dit pas.

Le patient ne doit pas lire sur le visage de l'ambulancier les festivités de la veille, le manque de sommeil, le dégoût ou la désapprobation. Au contraire, un sourire encouragera la confiance et l'échange.

4° Le regard

Dans l'interaction, le regard peut être fuyant, focalisé sur les détails de l'environnement. Cela peut révéler un manque de capacité relationnelle, de réflexion, une recherche de mots ou d'idées.

Le contact visuel permet d'être présent pour l'autre et de détecter ses réactions.

Même en l'absence de mots, le regard peut transmettre des émotions : de la compassion, du soutien ou du désespoir.

5° Les signes vocaux : le para-verbal

Le langage doit être adapté à la compréhension du patient et de son entourage. La voix est calme, douce et rassurante. Le rythme doit être lent et posé. Le silence fait aussi partie de la communication.

La gestuelle du patient

Il y a une interaction réciproque puissante entre le corps, la pensée et les émotions. Ainsi, ce qui se passe au niveau de l'esprit se répercute en contrepartie sur le physique de la personne.

Les manifestations comportementales sont donc très révélatrices de ce qui se vit à l'intérieur. Cette constatation est la base de la PNL (Programmation Neuro Linguistique).

Il faut porter une attention marquée aux manifestations comportementales de la personne, c'est-à-dire au langage de son apparence extérieure, afin d'en saisir ses représentations intérieures. L'étude du comportement nécessite une phase d'**observation** du patient.

- Au préalable, **savoir écouter, première habileté nécessaire à toute communication**. Écouter suppose une bonne qualité d'attention à l'autre. Malheureusement, même chez les soignants avertis, on observe souvent une certaine inattention, préoccupés qu'ils sont par la réponse à fournir à la personne. Au contraire, il faut être à l'affût de ce qu'elle exprime par le langage du corps.
- **Percevoir l'image d'ensemble**. La personne apparaît dans un ensemble réunissant une foule de détails, mais ce qui frappe d'abord est l'impression générale qu'elle nous transmet : elle a, par exemple, l'air abattue ou fermée et méfiante. Une fois cette perception globale saisie, on peut s'intéresser aux détails.
- **Observer l'expression faciale**. La figure est un miroir aux émotions qui se manifestent par la tension des traits, (les muscles crispés ou détendus lui confèrent une expression de dureté, de fatigue ou de détente), par le sourire ou par un front soucieux.
- **Saisir l'expression des yeux**. Les yeux nous renseignent sur l'état d'esprit de la personne qu'ils manifestent sérénité, douleur, tristesse, peur ou anxiété. Les sourcils froncés expriment la tension, ou même la colère.

En PNL on peut aller beaucoup plus loin dans l'observation des yeux. La calibration, processus de repérage des indicateurs oculaires permet en effet de saisir et d'analyser les représentations internes que la personne se fait du réel.

- **Noter l'expression de la bouche**. La bouche et la partie basse du visage sont très révélatrices de ce que vit la personne intérieurement. Les lèvres crispées peuvent indiquer la gêne, le stress ou la douleur physique. Un léger tremblement des lèvres montre une émotion positive ou négative. Le sourire indique la détente et le plaisir. S'il s'accompagne d'un regard dur, il indique plutôt le sarcasme.
- **Bien écouter la voix**. La voix est révélatrice de son état d'esprit. Une voix forte et gutturale traduit l'esprit de décision de la personne ou son exaspération. Par ailleurs, une voix tremblante est plutôt le signe de l'indécision, de la gêne et du stress.
- **Repérer la respiration**. La respiration est un indicateur précieux d'un état d'esprit. Lorsqu'elle se fait rapide et saccadée, mobilisant surtout le thorax, elle traduit la tension, l'anxiété, la douleur et la peur. Lente et calme, se manifestant par un soulèvement de l'abdomen, elle indique la détente ou la volonté de contrôle de la situation.
- **La technique de synchronisation** propre à la PNL permet d'agir sur la respiration de la personne à aider : en se calquant sur la respiration de la personne à aider, puis en ralentissant progressivement son rythme de respiration. Par mimétisme, la personne va progressivement se calmer. On accompagne un retour au calme par sa propre sérénité.
- **Remarquer le port du torse**. La personne confiante en elle-même arbore un torse droit, tonique, parfois même bombé, qui lui confère une expression de force. Celle qui est triste et défaitiste présente un torse un peu rentré avec des épaules tombantes.
Les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes présentent souvent des épaules basses, dans une attitude un peu voutée, la tête penchée vers l'avant.

- **Prendre connaissance de la position et du mouvement des membres.** Les membres expriment aussi, à leur façon, le ressenti émotionnel de la personne. Le tremblement des mains peut être révélateur d'un état de stress. Des bras croisés dans une attitude de protection peuvent traduire la fermeture à l'intervention d'un soignant. A l'encontre, des bras croisés et la détente du reste de son corps peuvent exprimer la décontraction chez un sujet qui se sent à l'aise. Toute posture s'interprète dans un contexte. C'est un ensemble de signes cohérents qui peuvent nous amener à confirmer ou non notre première impression.

La position des jambes est aussi révélatrice. Les jambes croisées de manière serrée traduisent la nervosité et même l'anxiété ; des mouvements répétés des jambes sont souvent symptomatiques du stress ou de l'envie de sortir d'une situation. Cependant, l'inclinaison du torse vers l'arrière dans une position de confort indique plutôt une volonté de détente.

- **Remarquer les changements dans les manifestations comportementales.**

La gestuelle peut se superposer au langage verbal. La complémentarité ou l'opposition entre langage verbal et langage non-verbal renforce et crédibilise ce qui est dit ou, au contraire, trahit une incohérence qui discrédite le discours.

S'améliorer en communication non verbale

S'entraîner à observer et se taire

Prendre conscience de son langage corporel

S'entraîner à observer et se taire

Prendre conscience de son langage corporel : accordez-vous quelques instants pendant vos échanges pour prendre conscience de vos propres postures et gestuelles.

Le sourire

Les enfants en pré-scolarité sourient 400 fois par jour. Les adultes seulement 15 fois. Le sourire n'a pas seulement un effet positif sur l'interlocuteur, il encourage aussi confiance et échange. Une étude de *Rick WILSON* de l'université de RICE (USA) démontre que « les personnes qui sourient dégagent des expressions amicales et sont spontanément perçues comme agréables ». Le sourire est un signe d'ouverture et de disponibilité envers l'interlocuteur (patient, collègue...)

Le sourire facilite le contact et la connexion. Inconsciemment, l'interlocuteur calque son attitude sur le visage source (souriant). C'est « l'effet Miroir » (avec intervention des neurones miroirs cités précédemment).

De la même manière, un comportement négatif, agacé, stressé, contrarié va, par mimétisme, entraîner un comportement similaire de la part de l'interlocuteur. Au lieu de se dire que l'autre n'est pas aimable, on peut se demander plutôt ce qui a entraîné cette réponse.

La distance interpersonnelle

■ Distance intime

Moins de 45 cm : proche de l'interlocuteur.
Frôler, parler à l'oreille...

■ Distance personnelle

Entre 45 et 120 cm : celle de la conversation courante.
2 bras tendus, poignée de main. Permet de voir les mimiques et la gestuelle.

■ Distance sociale

Entre 120 et 360 cm : séparation par un guichet, un bureau.
Administration, neutralité.

■ Distance publique

Plus de 360 cm : le visage est visible mais pas les mimiques.
Adapter sa voix et l'ampleur des gestes.



La proxémie est l'étude des distances sociales définie par *Edward T. Hall*.

La distance de communication est différente selon l'image qu'on se fait de l'autre. Différentes expériences ont notamment montré qu'on se place plus loin d'une personne atteinte de handicap. De même, on se place spontanément plus loin d'une personne lorsqu'elle a été préalablement présentée comme une personne froide et inamicale comparativement à une personne préalablement décrite comme amicale et chaleureuse. Les distances d'interaction varient également selon le statut de l'interlocuteur. En effet, on se place plus loin d'un supérieur hiérarchique ou d'un subordonné que d'un pair. Ainsi, il existe une relation entre la distance sociale et la distance spatiale.

Dans une relation de soin, la particularité est que l'ambulancier va non seulement entrer dans la zone intime du patient mais aussi être amené à le toucher, pour un acte technique (prise de paramètres par exemple) ou pour apporter son soutien (aide au déplacement, à l'installation ou toucher bienveillant de réconfort).



Sauf urgence et inconscience, on ne touche pas quelqu'un sans autorisation, ni explications, quand bien même cela fait partie du travail.

Le contact physique : le toucher dans la communication

Le toucher est un sens qui est réciproque dans le sens où on ne peut pas toucher quelqu'un sans être touché également. Il faut donc se connaître soi-même et connaître ses limites pour effectuer une communication passant par le sens tactile. En effet, le sens du toucher varie selon les personnes, le vécu, l'éducation. Il provoque des réactions, des émotions qui peuvent être aussi bien négatives que positives. Le toucher atteint la distance intime, c'est pourquoi il faut l'utiliser avec prudence et de manière progressive, de manière à ne pas heurter ou envahir la personne. Il faut également prévenir et expliquer le pourquoi de ce toucher lorsqu'il est associé à un soin technique. Lors des soins, il faut toujours garder à l'esprit d'éviter le port excessif et inadapté des gants : en effet, même s'ils sont parfois obligatoirement utilisés à des fins préventives (infections ou virus), le port de gants déshumanise la relation et le patient peut le vivre comme un signe de rejet ou d'exclusion.

Sauf en cas d'urgence et d'inconscience, on ne touche pas quelqu'un sans son autorisation, sans lui expliquer ce que l'on fait.

Communication verbale/ Le choix des mots

Un même mot peut avoir plusieurs sens. Chacun peut y rattacher des connotations positives ou négatives, des souvenirs ... Sur le principe de « la madeleine de Proust », qui lui rappelle son enfance, chacun va rattacher un élément de son vécu à une odeur, une situation ou un mot.

Un mot évoque une image que l'on peut croire universelle : quand on évoque une cuillère, tout le monde comprend très bien ce qu'est une cuillère. Mais quand il s'agit de donner un médicament : s'agit-il d'une cuillère à soupe ou à café ?

La contenance n'est pas la même, le mot n'est pas suffisamment précis.

De même l'image qui vient à l'esprit, à partir d'un même mot, est différente selon le référentiel de chaque personne. Pour un podologue, une crevasse est une petite blessure. Pour un géologue, elle correspond à une immensité.

Dans l'exercice professionnel, le vocabulaire doit être spécifique afin qu'il soit partagé par tous. Ce langage commun permet de limiter les difficultés de compréhension entre les praticiens. Il peut cependant devenir un frein à la communication et même une source d'inquiétude s'il est utilisé auprès de non professionnels. « Avez-vous des acouphènes madame ? » Peu de gens sauraient répondre...

Choix des mots

- ▶ Adaptés en fonction de l'interlocuteur.
- ▶ Précis, (vocabulaire médical, quantité, description).
- ▶ En faisant attention aux réactions de l'interlocuteur (interprétation correcte du message reçu).

Communication verbale/ Le message

La communication verbale ne représente qu'une infime partie de la communication : moins de 10% passent par les mots (conscient). La majeure partie du message est inconsciente et passe par la gestuelle.

Pour évoquer la réalité, les mots et le langage lui sont nécessaires, au travers de la parole. Les mots peuvent avoir un sens dénotatif (sens donné par le dictionnaire) et connotatif (sens qui dépend du contexte, et de la signification subjective de celui qui l'émet). Le soignant doit se détacher de cette subjectivité.

Le langage répond à une commande motrice volontaire et cette fonction peut être altérée dans plusieurs pathologies. Parler ne se réduit pas à regrouper des mots pour en faire des phrases. Ce ne doit pas être une manière de combler un silence.

Le processus de communication est composé de :

■ L'intention

L'envie d'envoyer un message, une information à un interlocuteur. Il y a motif, besoin d'émettre.

■ Le message

L'information à transmettre.

■ L'émetteur

La personne qui a l'intention et qui envoie le message.

■ Le bruit

Tout ce qui perturbe la communication.

Au niveau sonore : parasites dans une communication radio, bruits de la rue.

Au niveau visuel : mauvaise impression qui empêche de bien lire un texte.

■ Les filtres

Chaque personne interprète les données à la lumière de son histoire, de son éducation, de son propre référentiel. Ces freins à la communication peuvent être physiques (par exemple un bruit), psychologiques (préjugés) ou sémantiques (le sens du message n'est pas bien compris).

■ Le récepteur

La personne qui reçoit l'information, qui lit le message ou qui l'entend.

■ Le canal

Support du message entre l'émetteur et le récepteur. Il peut être visuel, auditif ou kinesthésique (toucher bienveillant, regard, mots...)

■ Le code

Le message est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Il faut connaître le code pour comprendre le message. Si l'émetteur parle anglais il faut que le récepteur comprenne l'anglais.

■ Le décodage

Travail fourni par le récepteur pour intégrer et comprendre le message envoyé.

■ Le feedback ou rétroaction

La possibilité, pour le récepteur de répondre à l'émetteur. Le récepteur n'est plus passif mais actif, il devient à son tour émetteur : répondre au téléphone, entamer un dialogue, renvoyer un coupon réponse, remplir un formulaire sur un site web. Certaines communications ne permettent pas le feedback. Le récepteur reste passif. L'absence de feedback peut parfois entraîner la fin de la communication.

Théorie de Jakobson

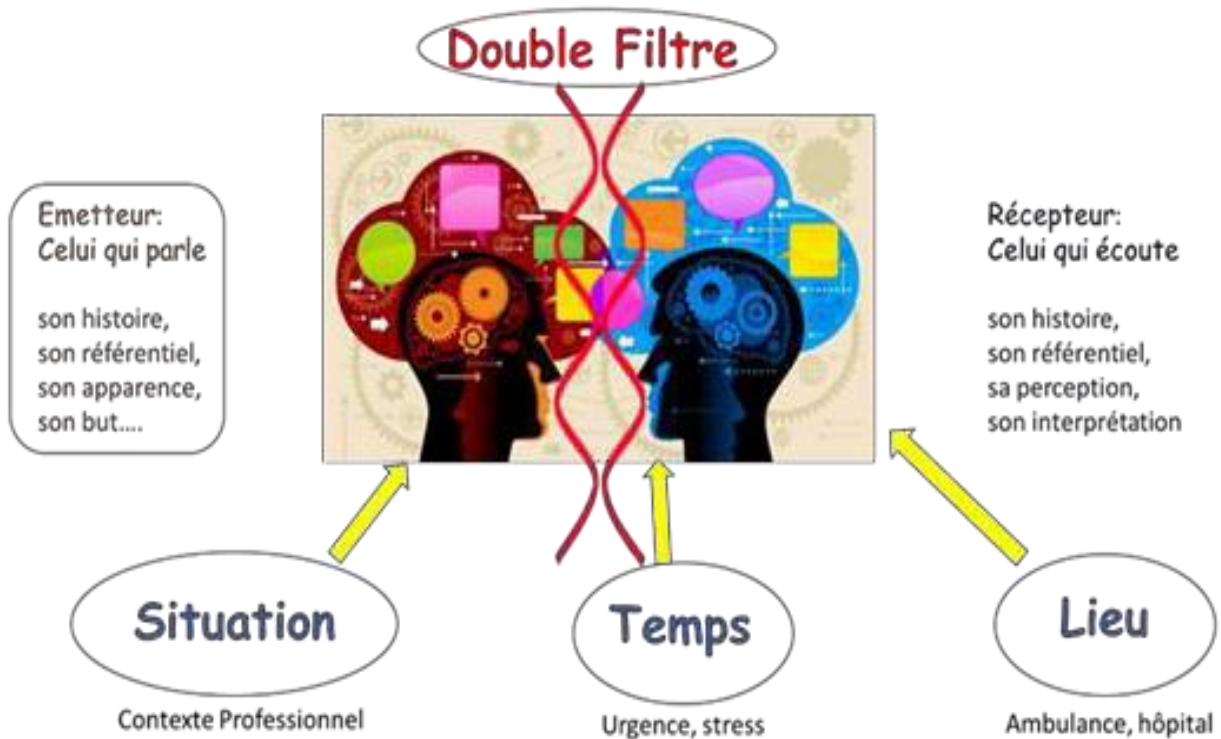
Théorie née du constat de la **différence** qui peut exister entre le message émis et le message reçu.

Le message est pensé par l'émetteur, puis codé par lui (langage et non verbal) puis exprimé.

De son côté, le récepteur reçoit le message, le décode et le comprend à sa manière. Le « message » passe par un canal. Il est perturbé par des « bruits » qui peuvent être physiques et / ou psychologiques. Si les « canaux » ne sont pas les mêmes et qu'il y a trop de « bruits », le message ne passe pas et la communication ne s'établit pas.

L'objectif de cette méthode est de s'assurer que le message reçu et interprété par le récepteur est bien similaire à ce que l'émetteur avait souhaité transmettre. On utilise pour cela la reformulation.

La communication verbale

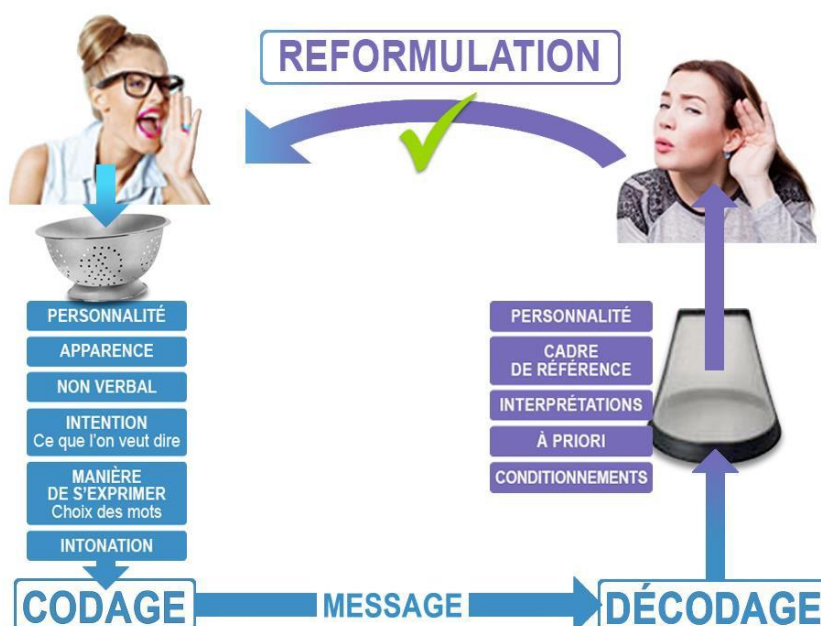


La communication est influencée par des facteurs extérieurs qui sont particuliers dans un contexte de soin :

- Le lieu : hôpital, ambulance (à la charge émotionnelle potentiellement lourde),
- La notion d'urgence qui ajoute un facteur stress,
- Le contexte professionnel qui impose distance, discrétion, respect et empathie.

LES BASES DE LA COMMUNICATION : Les outils

La reformulation



- **Reformulation Miroir** : simple répétition : reprendre les propos avec les mêmes mots ou similaires.
- **Reformulation résumé** : faire une synthèse de ce qui nous paraît être l'idée principale.
- **Reformulation clarification** : faire préciser les propos.
- **Reformulation interprétation** : dire ce qu'on pense avoir compris ou décodé.

Attention à la Reformulation abusive qui consiste à faire valider son interprétation.
Le travail de reformulation s'adapte au langage comme à l'état émotionnel

Quelques exemples

Montrer que l'on a compris et faire valider.	► « Si je vous ai bien compris, vous dites que... »
Aider à clarifier les propos de l'émetteur. Obtenir plus de précisions.	► « Qu'entendez-vous par (+ mot clé) ... »
Recentrer la discussion, l'échange.	► « Reprenons, vous m'avez bien dit que ... »
Synthétiser et faire le point conjointement.	► « Nous avons abordé les points suivants. Est-ce tout ? »
Déduire une suite logique d'un propos qui n'a pas été exprimé.	► « Si vous êtes en retard, vous avez bien conscience de l'attente en consultation... »

Les questions

Les différents types de question :

- OUVERTE : Libre choix de réponse et ouverture au dialogue
 - ▶ Exemple : *Où souffrez-vous, à quel endroit avez-vous mal ?*
- FERMEE : réponse par OUI ou par NON sans développement
 - ▶ Exemple : « *Avez-vous un rendez-vous ?* »
 - Attention cependant à ne pas induire la réponse : « *Vous avez bien un rendez-vous ?* »
- ALTERNATIVE : Choix entre 2 réponses
 - ▶ Exemple : *Préférez-vous sortir en début ou fin d'après-midi ?*
- DIRIGEE : Prise de position sur un sujet précis
 - ▶ Exemple : *Que pensez-vous de l'assistance médicalisée ?*
- CROISEE : Confirmation ou infirmation d'une question posée précédemment

*Il ne faut poser qu'une seule question à la fois. Ne pas couper la parole.
Ne pas préparer sa réponse ou une prochaine question.*

Plus l'interlocuteur a des difficultés à préciser sa pensée, plus il est souhaitable de **commencer par une question fermée**. La réponse "oui" ou "non" ne bloque pas l'échange, au contraire elle permet ensuite d'enchaîner sur une question ouverte. Quand l'interlocuteur a encore un peu de mal à répondre, on posera plutôt une **question à choix multiple** avant de revenir à une **question ouverte**.

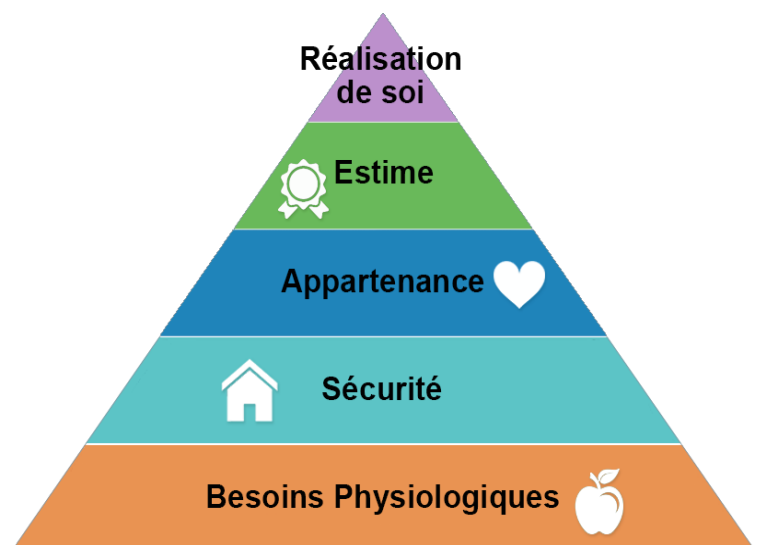
Commencer par une question ouverte n'est pas toujours un bon choix pour ouvrir la discussion.

La pyramide de Maslow vue sous un autre angle

La pyramide de Maslow peut être brièvement évoquée pour donner quelques notions de bases concernant la satisfaction des besoins.

La pyramide du Bonheur : *Abraham MASLOW* pensait que le bonheur dépendait de la satisfaction d'une série de besoins. Il les a listés par ordre de priorité. Ce qui donne une pyramide, un peu comme un escalier qu'on ne pourrait gravir que marche après marche.

En communication professionnelle, on peut s'en servir pour illustrer l'idée que tant que le patient n'aura pas satisfait son besoin premier du moment, il ne sera pas disponible pour la suite de la communication. Exemple : quelqu'un qui a mal ne rentrera pas dans un long discours.

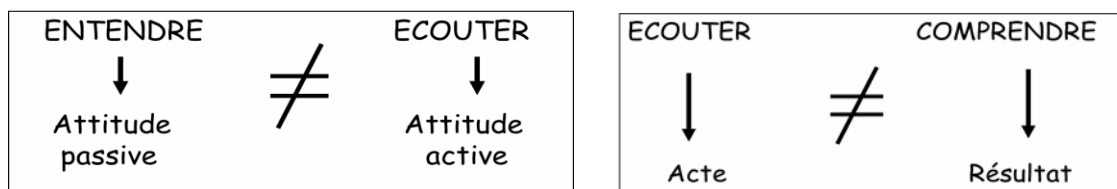


Pour illustrer de façon un peu caricaturale : imaginons un besoin impérieux d'uriner, la disponibilité pour la communication s'en trouve quelque peu altérée... De la même manière, tant que le problème angoissant pour le patient et bloquant pour la communication n'aura pas été pris en compte, les informations ne passeront pas.

Si j'ai un problème que je ne peux pas exprimer ou si l'autre a un problème non-exprimé ou non compris, il ne peut y avoir de vraie communication.

Tant que la problématique du patient n'a pas pu être exprimée, être entendue et, par ailleurs, écoutée et comprise, tant que le récepteur n'a pas signifié qu'il a reçu et compris l'information et qu'il va en tenir compte, le patient va rester focalisé sur ce qui le préoccupe vraiment et ne sera réceptif à rien d'autre. Cette non-communication, voire cette non-compréhension de l'autre peut générer des tensions et prendre de l'ampleur jusqu'à l'agressivité, le conflit et la violence.

L'écoute active



L'écoute active permet de se centrer sur les propos de l'émetteur avec attention et réceptivité

- Créez un environnement propice à l'échange (confort, éloignement des badauds, ...)
- Posture : montrez que votre corps est ouvert à la conversation, installez-vous de face, à la hauteur de votre interlocuteur.
- Se taire pour
Ecouter vraiment, sans couper la parole ni chercher à remplir les silences.
- Laissez l'autre aller jusqu'au bout de son explication ou de son raisonnement.
 - ▶ Sans geste négatif
 - ▶ Sans jugement à priori
- Acceptez que l'autre ait de fortes raisons (bonnes ou mauvaises) d'agir comme il le fait.
- Ne préparez pas en même temps votre réponse.
- Assurez-vous que la personne sait que vous écoutez.
- Gestuelle : regardez la personne, hochez la tête de temps en temps.
Ecoutez jusqu'au bout, sans fuir le regard, les yeux dans les yeux.
- Laissez des silences.
- Reformulez pour montrer votre intérêt et informer votre patient qu'il est écouté et compris.

Ecouter Vraiment c'est aussi tenir compte de ce que l'on a compris.

S'assurer que la personne sait que vous écoutez

1. Gestion du contexte

Gérer l'environnement

Gérez les premiers niveaux de la pyramide de Maslow : besoins physiologiques et de sécurité (quiétude, confort, température, douleur).

Gérer le regard des autres (témoins, famille)

Eloignez les personnes qui nuisent à la communication avec le patient. Leur présence gêne la communication et la confidentialité.

Dans certains cas, la présence d'une seule personne en particulier, dont l'avis est important pour le patient, bloque la communication. La mère d'un adolescent, par exemple : « je ne veux pas paraître faible devant mon fils ».

On existe aussi au travers du regard des autres.
Celui-ci impacte donc nos réactions.
(Besoin d'appartenance 3^e niveau de la pyramide de Maslow)

Gérer l'entourage c'est aussi lui donner un rôle à jouer

Guider la famille pour qu'elle soit aidante auprès de son proche.

Il est important de rendre utile auprès des proches. Selon le contexte, éloignez-les en leur demandant de réunir quelques affaires et documents ou, au contraire, invitez-les à rester auprès patient : « Aidez votre femme à respirer tranquillement entre deux contractions, encouragez-là quand elle pousse ». « Tenez la main de votre papa ».

« Prenez votre enfant dans vos bras, chantez-lui sa chanson préférée... »

2. Le message « JE » (quand on a un reproche à se faire)

S'attribuer les faits et ne plus faire porter à l'autre la seule responsabilité d'un problème. Nous avons une fâcheuse tendance à utiliser le message « TU » ou le message « VOUS ». Ces formulations peuvent être très mal ressenties et envenimer la situation.

Exemples : « Vous ne devez pas faire comme cela ». « Tu ne fais pas cela correctement ».

Le message efficace est celui qui dit « JE » et qui décrit à l'autre notre ressenti. L'autre n'est ainsi pas directement mis en cause et ne se sent pas agressé. Ce n'est pas lui qui a tort, mais c'est notre ressenti subjectif qui aurait préféré que les choses soient différentes.

Il n'y a ainsi **pas de jugement de valeur**.

3. Attitude positive : l'empathie

- Accepter l'autre dans l'état dans lequel il se trouve.
- Considérer qu'il a (sa) raison.
- Ne pas l'évaluer.
- Prendre en compte ses besoins.
- Essayer de se mettre à sa place, dans sa réalité et tenter d'approcher sa vision du monde.



4. Le silence

Parfois, votre simple présence est suffisante pour soutenir : une attitude non verbale comme poser une main sur le bras ou tendre un paquet de mouchoir permet de montrer votre intérêt sans être trop intrusif, en respectant les émotions du patient et en les laissant s'exprimer.

- Laisser des périodes de silence rythmer la conversation.
- Attention : penser à ce que vous allez dire ensuite n'est pas écoute.
- Le silence laisse l'émetteur réfléchir un moment.
- Contrôler « quand » vous parlez aide à éviter de remplir la conversation.

Le patient a besoin de se sentir écouté et compris pour s'apaiser.
Il ne souhaite pas que l'on trouve des solutions à tous ses problèmes

Vous pouvez l'informer (« il existe des groupes de paroles sur ce sujet » ou « une assistante sociale pourrait vous donner des informations ») mais en aucun cas vous ne devez donner votre avis personnel.

5. L'environnement

- Créez un espace accueillant pour une conversation.
- Mettez votre portable en mode discret.
- Demandez aux autres de ne pas vous déranger pendant la conversation.
- Eloignez les témoins de la conversation s'il y a trop de monde.

6. Ne pas juger

Ne pas confondre Observation et évaluation

7. La posture

- **Montrez que votre corps est ouvert à la conversation**
- Adoptez une posture « ouverte », assis ou debout.
- Inclinez-vous légèrement vers l'avant.
- Faites face à la personne qui parle.
- Hochez la tête de temps en temps.
- Regardez la personne.

8. Trouver un sujet apaisant

Parler de ce qui est important pour le patient (famille, enfants) et ne pas parler de soi.

9. Le rappel à la loi ou à la règle

Il permet de rester factuel et professionnel et ainsi d'éviter certains conflits : ce n'est pas vous qui n'êtes pas arrangeant, c'est la réglementation qui vous impose des règles à respecter.

On ne peut pas vous reprocher de respecter la loi. Cela implique de bien connaître la réglementation.

10. Faire appel à une personne ressource

Pour débloquer une situation, obtenir des informations et faciliter la communication. (Médecin du SAMU, entourage, traducteur, parent, témoin ...)

Les facteurs de réussite de communication soignant-soigné

- ➔ *Ecouter vraiment*
- ➔ *Empathie : tenter d'approcher la réalité de l'autre*
- ➔ *Considérer que l'autre a (sa) raison : ne pas Juger.*
- ➔ *Signifier qu'on a compris sa problématique et en tenir compte.*
- ➔ *Authenticité : La relation doit être honnête et franche : ne jamais Mentir, rester factuel.*
- ➔ *Respecter le silence du patient s'il le souhaite.*
- ➔ *Gérer l'environnement et les spectateurs.*
- ➔ *Ne pas parler de soi, ne pas donner son avis personnel.*

Nature du message

Eviter la rumeur / Respect du secret

La règle des « 3 passoirs de Socrate » est une notion que chacun devrait connaître et s'appliquer afin d'assainir la communication, notamment au sein d'une équipe. Elle permet d'éviter rumeurs et ragots qui ternissent un esprit d'équipe et sont contre-productives. Prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire :

- **Vérité** : l'information est-elle vérifiée ?
- **Bonté** : l'information est-elle bénéfique ?
- **Utilité** : l'information est-elle utile ?

« Si cela n'est pas le cas », conclut Socrate, « si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? ».

Bien?
Vrai?
Utile?



L'ambiance de travail entre collègues est ce que vous en faites.

Nature de la relation : professionnelle

■ Relation de civilité

- ▶ Toujours se présenter (Bonjour Mr, je suis ambulancier et je viens pour...)

■ Relation de nature fonctionnelle

- ▶ Rechercher l'information nécessaire à la prise en charge.
- ▶ Être précis et à l'écoute

■ Relation de compréhension

- ▶ Rassurer la personne, toucher relationnel possible.
- ▶ S'exprimer dans l'empathie, écouter attentivement l'autre.

■ Relation d'aide thérapeutique : les soins adaptés et dans la confiance de l'autre.

Quelques notions de PNL : Programmation Neurolinguistique

La PNL, Programmation Neurolinguistique, fonctionne par apprentissage (sorte de programmation) qui passe par le système nerveux (Neuro) et par le langage verbal et non verbal (Linguistique). La PNL est donc une technique de communication et de changement.

Le but est d'aller voir, entendre, sentir ce qui se passe chez l'autre et chez soi. Aller chercher la vérité subjective de l'autre : sortir du « qui a tort, qui a raison ». Comprendre que chacun a sa propre vérité et qu'il faut s'efforcer de fonctionner ensemble.

« Ne pas s'enfermer dans nos certitudes mais s'enrichir de la réalité de l'autre ».

Technique de PNL : la calibration.

Se servir de l'analyse du non verbal pour adapter sa propre communication.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE LORS DES STAGES

La formation comporte 245 heures de stage.

L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire.

Les stages sont réalisés dans les structures suivantes :

3 périodes de stages permettant la validation des compétences avec une souplesse laissée aux IFA dans le choix des lieux pour une période de 105 h :

- Parcours Médecine d'urgence Adulte / Enfant (Service des urgences / SAMU–SMUR) : 70H
- Entreprise Transport sanitaire 70 H
- Structures de soins de courte et longue durée, soins de suite et réadaptation, EHPAD, enfant et adulte, psychiatrie et santé mentale en fonction du projet pédagogique de l'IFA : 105h

Les objectifs de stage

Définition

Un objectif de stage est une compétence précise que l'on désire acquérir suite à une activité pédagogique. Il va sans dire que le stage est une activité qui vous permettra de développer de nombreuses compétences nouvelles, non seulement du point de vue de votre technique spécifique, mais aussi dans la perspective de votre développement personnel, que ce soit au plan des comportements, des valeurs ou de la personnalité.

Les deux catégories d'objectifs de stage

Les objectifs qui peuvent être poursuivis dans le cadre d'un stage peuvent être classés en deux catégories. Ceux reliés directement aux tâches de l'emploi et ceux reliés à l'individu et à sa personnalité. On vous demande de formuler des objectifs dans les deux catégories. Dans le but de vous assister dans cette démarche, certains exemples sont proposés. Cette liste n'est pas exhaustive. Il appartient à l'élève stagiaire d'analyser sa propre situation et de se fixer des objectifs réalistes et réalisables.

Objectifs reliés aux tâches

Ce sont des objectifs directement reliés à l'emploi, tant au niveau des connaissances acquises qu'au niveau des applications et du savoir-faire. À titre indicatif, mentionnons les exemples suivants :

- ▶ Être capable de mettre en œuvre les gestes de secours et d'urgence adaptés à la situation du patient, dans le respect des règles de sécurité et de confort.
- ▶ Identifier les signes de détresse et de douleur ;
- ▶ Utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d'hygiène et de sécurité.
- ▶ Installer le patient en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap.
- ▶ Expliquer le transport réalisé, les raisons d'un geste professionnel et apporter des conseils adaptés.
- ▶ Adapter sa conduite en respectant les règles de circulation et sécurité routière spécifiques à l'ambulance, en urgence ou non.
- ▶ Rechercher et organiser / hiérarchiser l'information concernant le patient.
- ▶ Organiser son travail au sein de l'équipe et de l'entreprise en fonction des besoins des patients pour optimiser la qualité de la prise en charge.

Objectifs reliés à l'individu

Apprendre à mieux se connaître afin de développer sa personnalité. Il faut particulièrement viser à corriger les lacunes et renforcer les points forts. À titre indicatif, mentionnons les exemples suivants :

- Améliorer sa confiance en soi ;
- Améliorer sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel ;
- Apprendre à s'intégrer à une équipe de travail.

Rôle du tuteur

- Diffuser son savoir et son expérience
- Être patient, prendre du temps pour expliquer et corriger (savoir débriefer et reformuler)
- Avoir un réel intérêt pour son métier

- Aider le stagiaire à découvrir l'entreprise et le matériel avec lequel il va travailler
- Le présenter à l'ensemble de ses collègues (faciliter l'intégration)
- Faire un point avec le stagiaire sur son parcours de formation et ainsi se positionner par rapport au savoir acquis, en cours d'acquisition ou encore qu'il n'a pas eu l'occasion de découvrir.

Le tuteur au sein d'une société privée de transport sanitaire prépare en douceur le stagiaire à sa future place d'équipier. Il lui enseigne comment adapter sa prise en charge et évaluer tous les facteurs importants :

- ▶ Être capable d'analyser les lieux à son arrivée (configuration de la maison ou de l'immeuble)
- ▶ Comment se présentent les locaux. L'accessibilité du patient à l'ambulance (plain-pied, étage, couloir étroit, marches glissantes)
- ▶ De quel matériel aura-t-on besoin ? Quel matériel est disponible sur les lieux ?
- ▶ Analyser et communiquer avec le patient pour adapter sa prise en charge en sécurité et avec le confort maximum

- Découvrir la régulation, les commandes informatiques de transport, la communication entre entreprise et SAMU (traçabilité, enregistrement)
- Communication entre la régulation et les ambulanciers
(Objectif de sécurité : pas de téléphone au volant)
- Connaître l'ensemble des outils de communication entre client et SAMU, patient et ambulancier, patient et entreprise. Traçabilité (exemple : erreur sur le type de véhicule)

Ne rien négliger !

*Au cours de ses stages, toutes les situations sont bonnes pour favoriser l'évolution des compétences
(Ex : le lavage des mains, la désinfection de l'ambulance)*

COMMUNICATION DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Devoirs des ambulanciers envers les malades

- * Absence de discrimination fondée sur la condition, la nationalité, la religion, la réputation et les sentiments inspirés.
- * Libre choix du malade pour la société de transports.
- * Respect de la volonté du malade dans la mesure du possible.
- * Informations des autorités judiciaires sur les sévices sur mineurs de moins de 15 ans et personnes vulnérables.
- * Ne pas cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale ou à la dignité du détenu.
- * Engagement personnel de soins consciencieux et dévoués.
- * Attitude correcte, attentive et courtoise.
- * Sobriété.
- * Attitude réservée et empreinte de modération.
- * Respect de la dignité du malade.
- * Explications sur l'état du patient et le transport.
- * Conseils sur le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie (propagation de maladie).
- * Devoirs de participation au service de garde de jour et de nuit.
- * Devoir de réserve et discrétion : Interdiction de s'immiscer dans les affaires de familles.
- * Facilitation de l'obtention par le malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
- * Interdiction de fraude, abus de cotation : adéquation entre honoraires perçus et actes effectués.

Devoirs des ambulanciers avec les membres des autres professions de santé

- * Respect de l'indépendance professionnelle des membres du corps sanitaire.
- * Interdiction de commérage.
- * Respect de la prescription médicale.
- * Ne pas critiquer les actes médicaux de diagnostic ou thérapeutique.
- * Respect du règlement intérieur des établissements publics ou privés.
- * Exactitude et ponctualité dans les admissions.
- * Transmission des informations sur le déroulement du transport à l'établissement d'accueil et au médecin prescripteur

L'INTERROGATOIRE DU PATIENT

Intérêt légal

L'ambulancier doit pouvoir justifier qu'aucune faute n'a été commise.

Or, un malade ou une famille peut se plaindre, parfois plusieurs années après le transport. Pour justifier de l'heure d'arrivée de l'ambulancier, de l'état du malade et des actes pratiqués, il est nécessaire de conserver le double des feuilles de transport bien remplies.

Ce double peut être saisi par l'officier de police judiciaire à des fins d'expertise, selon une procédure respectant le secret professionnel.

La prise en charge d'un malade doit être rigoureuse. Afin d'éviter des complications pendant le transport, il faut prendre un certain nombre de précautions avant, pendant et après le transport.

Tous les bilans et gestes effectués sont **consignés sur une feuille type de surveillance**. Préciser au patient les raisons de cet examen.

Intérêt pour le patient

Bilan et transmission

- ▶ Permettre au médecin régulateur de faire un **télédiagnostic** plus fin dans le but de déclencher la réponse la plus adéquate possible.
- ▶ Assurer, une fois le patient déposé au SAU, une **traçabilité synthétique** qui sera versée au dossier de soin du patient et sur lequel s'appuieront les équipes hospitalières pour assurer la **continuité des soins**.

Les paramètres à prendre en compte pour commencer une prise en charge

De qui s'agit-il?	Homme / Femme	Enfant/ Personne âgée
Personnes présentes?		
Demande (verbalisée ou non) ?	Transport/ transfert Soins Soutien psychologique	
Origine de la demande ?	Patient Centre 15 Hôpital	
Contexte ?	Urgence Chronicité Informations relatives à l'état de l'habitation (hygiène)	
Patient(e) Barrière de la langue ? Barrière culturelle ?	Si oui, de quel ordre ? (Etranger, sourd et muet) Comment y remédier ? (Interprète, ardoise magique...)	
Patient(e) A l'origine de l'appel ?	Patient(e) consentant(e) aux soins ?	
Attitude?	Agité(e), violent(e), calme, angoissé(e), coopérant(e)	
Degré d'implication	Patient, victime, impliqué	
Si victime, de quel type ?	Blessé(e), rapatrié(e), réfugié(e). Nombre ? Tri nécessaire ?	
Statut legal ?	Majeur, majeur protégé Mineur En situation régulière et libre, irrégulière et libre	
Entourage?	Familial ou personne de confiance, animal de compagnie. Personne fiable ? Ses demandes particulières ? Personne de l'entourage la plus anxiogène ?	
Est-ce une victime ou un(e) patient(e) à risques ?	Aggravation possible de l'état de santé Agression/ Passage à l'acte/ Contamination (sang, parasitose) Présence d'objets type arme, stupéfiants, valeurs	

- Examen ou évaluation clinique. L'observation vaut mieux que toutes les constantes !
 - Recherche de signes de gravité permettant d'anticiper l'engagement de pronostic vital.
 - Interrogation du patient sur les circonstances de survenue : y-a-t-il eu des prodromes ?
 - Prise des constantes utiles dans le même laps de temps, sans rompre la communication lorsqu'elle est possible avec recherche d'ATCD personnels et familiaux, interrogation sur le ou les TTT en cours.

Ceci peut et DOIT être effectué, tout en accomplissant des gestes techniques de 1^{ère} urgence lorsque la situation l'exige.

BILAN MEDICAL	
Paramètres à prendre en compte	Eléments à rechercher
Circonstances	Date et heure Contexte de survenue : activité du patient à ce moment-là Facteur(s) déclenchant(s) Signes précédents le malaise
Causes	Les causes peuvent être uniques ou multiples, associées, combinées
Signes du malaise et éléments associés	Rechercher à l'aide d'un PQRST - Répétition du malaise (1^{ère} fois ?) - Durée du malaise - Signes constatés, recherchés et/ou ressentis et leur évolution - Douleur - Nutrition : à jeun ? fréquence des repas ? - Hydratation : type de boisson ? Quantité ? - Elimination : sueur ? Urines ? Selles : diarrhée, constipation, gaz ?
Examen des fonctions vitals	- Conscience - Ventilation - Pouls - TA - Température si besoin
Antécédents médicaux et chirurgicaux	Rechercher à l'aide de MHTA - Antécédents connus personnels et familiaux - Examens, soins ou interventions chirurgicales récentes, prévues ou programmées
Traitements	Un médicament a-t-il été pris avant l'arrivée des ambulanciers ? Est-il issu d'un traitement habituel ? Quel médicament ? Posologie ? Posologie modifiée en cours de traitement ? Depuis quand ? Suivi régulier ou non ? Prescription et/ou automédication ? Sevrage, suspension ou arrêt

L'outil « Faire Dire » de l'HAS

Un outil pour améliorer la communication entre les professionnels de santé et les usagers.

Il est surtout utilisé dans les relations d'éducation thérapeutique afin de s'assurer de la bonne compréhension, par le patient, de son traitement par exemple.

Cf. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2612334/fr/faire-dire
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/brochure_fairedire_communiquer_avec_son_patient.pdf

C'est un outil de communication basé sur la reformulation par le patient de l'information donnée par le professionnel de santé. Son utilisation permet de s'assurer que les informations et les consignes reçues par le patient sont bien prises en compte et retenues. Il est utilisé en éducation thérapeutique mais peut être utilisé dans d'autres situations de soin : avant un transfert lit-brancard, une pose d'attelle etc.

L'outil comporte 3 étapes successives :



(AMALBERTI 2013)

- Expliquer lentement, à l'aide de mots simples, avec respect et empathie.
Cibler les informations à donner, ce qu'il doit retenir, les informations essentielles pour sa sécurité.
Chercher à repérer ses attentes et ses craintes.
- S'exprimer avec un ton bienveillant pour mettre le patient à l'aise
- Utiliser un langage adapté et clair en laissant au patient le temps pour bien comprendre ce qui est dit. Ne pas hésiter à répéter et à utiliser des mots différents pour dire la même chose.

Facteurs de réussite

- ▶ Faire simple
- ▶ Cibler sur les informations importantes
- ▶ Demander systématiquement une reformulation pour évaluer la compréhension

LA TRANSMISSION DU BILAN

Contenu

Fiches bilan : Traçabilité des informations relatives au patient

Lors de la transmission du bilan, faire la synthèse des informations que vous avez recueillies en mettant clairement en évidence ce qui a été compris de la situation, ce qui a été entrepris et l'évolution de la situation.

Imaginez qu'on vous donne des pièces de puzzle avec pour consigne de le reconstituer, sans vous expliquer quel est le motif final du puzzle ou en ne vous donnant pas toutes les pièces. Il devient très compliqué de terminer le puzzle.

Poser un diagnostic revient à assembler toutes les pièces du puzzle. Ce n'est pas le rôle de l'ambulancier de poser un diagnostic, mais le médecin a besoin de lui pour réunir toutes les pièces et, sans l'aide de l'ambulancier, il est possible que le médecin ne pose pas le bon diagnostic.

Le médecin du 15 n'a pas la situation sous les yeux, si vous lui donnez une multitude de paramètres et d'informations sans les classer, les organiser ni les interpréter, il devient très compliqué de comprendre la situation globale. S'il manque des informations, il se peut que le diagnostic ne soit pas posé.

Transmission du bilan

Plusieurs acronymes mnémotechniques sont utilisés : **DAR : Données, Actions, Résultats** (utilisé dans les dossiers de soins car toute action corrective doit être réévaluée.)

On appelle transmission un renseignement écrit et/ou oral donnant la possibilité au personnel soignant de connaître les informations indispensables afin de prodiguer les soins adéquats à l'état de santé d'un patient. Mais cela concerne aussi les informations détenues par le personnel soignant et délivrées à l'ambulancier.

Afin d'être efficace, les transmissions doivent être claires, concises et congruentes (correctes et adaptées).

Lorsqu'un ambulancier est intervenu auprès d'un patient, sa transmission se divise en trois parties :

Données	Actions	Résultats
Informations objectives ou subjectives concernant le patient, recueillies auprès de lui ou de son entourage.	Description des actes entrepris par l'ambulancier dans le but d'améliorer les données.	Description de la réaction du patient par rapport aux actions entreprises.
Exemple		
Lorsqu'un patient se plaint d'une douleur, chercher à la localiser et à l'évaluer.	Le patient est mis dans une position antalgique.	Atténuation de la douleur. Nouvelle évaluation

Types de transmission

L'ambulancier peut être amené à faire deux types de transmission :

■ En situation d'urgence

- ▶ Alerte face à une situation d'urgence nécessitant des moyens de renfort
- ▶ Transmission d'un bilan de l'état de santé d'un patient lors de sa prise en charge

■ Hors situation d'urgence

- ▶ Transmission consécutive à une prise en charge des éléments de surveillance

Chacune de ces transmissions se fait à la fois par oral et par écrit.

Savoir transmettre un bilan

- Bref, concis, structuré
- Clair
- Texte fluide
- Chronologique
- Sans rien oublier. Si le bilan est incomplet ou négligent, l'ambulancier ne pourra pas répondre aux questions du régulateur.

Pour la transmission du bilan, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande d'utiliser l'outil **SAED**
Situation – Antécédents – Evaluation – Demande

Outil de transmission d'un bilan : SAED

Situation – Antécédents – Evaluation – Demande

Le défaut de communication constitue une des principales causes racines des événements indésirables en milieu de soins. Les différences de personnalité, de culture, de comportement (facteurs humains), mais également les variations inter-métiers ou inter-spécialités sont des barrières à la communication entre les professionnels. Les difficultés de communication peuvent aussi être majorées lorsque la communication a lieu entre un professionnel débutant et un professionnel senior.

Cette hétérogénéité dans la communication peut amener, dans certaines situations, à une incompréhension ou une insatisfaction des interlocuteurs. La tension qui en résulte lors de la communication peut alors altérer la qualité de l'échange d'information et impacter la qualité de vie au travail.

SAED : un outil utilisé pour structurer la communication entre professionnels de santé

S	Je décris la Situation actuelle concernant le patient : Je suis : prénom, nom, fonction, service/unité Je vous appelle au sujet de : M./Mme, prénom, nom du patient, département de naissance, service/unité Car actuellement il présente : motif de l'appel Ses constantes vitales/signes cliniques sont : fréquence cardiaque, respiration, tension artérielle, température, évaluation de la douleur (EVA), etc.	
A	J'indique les antécédents utiles, liés au contexte actuel : Le patient a été admis : date et motif de l'admission Ses antécédents médicaux sont : ... Ses allergies sont : ... Il a eu pendant le séjour : explorations, investigations, etc. Les traitements en cours sont : ... Ses résultats d'examen sont : labo, radio, etc. La situation habituelle du patient est : confus, déboussé, etc. La situation actuelle a évolué depuis : minutes, heures, jours	
E	Je donne mon évaluation de l'état actuel du patient : Je pense que le problème est : ... J'ai fait : donné de l'oxygène, posé une perfusion, etc. Je ne suis pas sûr de ce qui provoque ce problème mais l'état du patient s'aggrave Je ne sais pas ce qui se passe mais je suis réellement inquiet	
D	Je formule ma demande (d'avis, de décision, etc.) : Je souhaiterais que : ... par exemple : Je souhaiterais que vous veniez voir le patient : quand ? ET Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois faire : quoi et quand ?	
RÉPONSE DE VOTRE INTERLOCUTEUR : il doit reformuler brièvement ces informations pour s'assurer de sa bonne compréhension de la situation puis conclure par sa prise de décision.		

SAED (Situation-Antécédents-Evaluation-Demande) est l'adaptation française de l'outil anglo-saxon S.B.A.R. (Situation Background Assessment Recommendation). Cet outil mnémotechnique permet à un professionnel de santé de structurer aisément sa communication orale auprès d'un autre professionnel.

Objectifs de la standardisation :

- Prévenir les événements indésirables pouvant résulter d'erreurs de compréhension lors d'une communication entre professionnels.
- Faciliter la mise en œuvre d'une communication documentée, claire et concise.
- Eviter les oublis.

1^{ère} partie : Renseignements administratifs

1^{ère} partie de la transmission : éléments du message d'alerte à destination du permanencier de régulation. En possession des informations, il peut envoyer une équipe de renfort. Sauf urgence vitale, où l'essentiel des détresses est transmis pour avoir de l'aide médicalisée, le message débute par les renseignements d'identification.

Se présenter	Préciser « ambulancier » et le nom de la société d'ambulances	
Confirmation d'adresse	Si l'appel émane du SAMU, transmettre le N° d'appel SAMU (ou N° d'intervention)	
Numéro de contre appel	N° de fixe d'où l'ambulancier appelle ou N° de portable	
Identité du patient	Avec le sexe et l'âge	
Nature du problème	Aggravation, demande de prescription de transport, demande d'avis médical	
Risques spécifiques	Victimes incarcérées, fuite de gaz, personnes bloquées	
Nombre de personnes impliquées	Victime : toute personne ayant subi un dommage dont l'existence est reconnue par autrui et dont elle n'est toujours pas consciente.	Impliquée : personne non victime mais concernée par l'événement traumatogène de façon directe ou indirecte.
Type de patient	Malade, blessé, accidenté du travail, accidenté de la route	

2^{ème} partie : Transmission du bilan

Cette partie de la transmission est destinée au médecin régulateur afin qu'il donne un avis médical. Ambulancier et médecin régulateur doivent utiliser le même vocabulaire. Un langage médical est mieux compris et surtout plus précis. Il permet une compréhension rapide.

D'où l'importance de travailler les termes médicaux tout au long du cursus.

► Par exemple : « Douleur abdominale du flanc droit. » Plutôt que « Mal au ventre en bas à droite. »

Eviter les phrases du type :

« Il a beaucoup saigné. » / « La jambe est de travers. » / « Il a mal dans la poitrine. » / trop imprécises.

Conclure en regroupant les signes révélateurs d'une détresse vitale puis agir en conséquence.

Le rôle de l'ambulancier n'est pas d'interpréter le bilan ni de trouver la maladie (diagnostic).

Conséquences du passage du bilan au centre 15

Transport	Le médecin confie le transport à l'ambulancier en lui indiquant la destination.
Médicalisation	L'état de la victime nécessite des soins médicaux d'urgence. Le centre 15 envoie une équipe pour médicaliser le patient.
Renfort	L'état de la victime permet un transport en ambulance mais l'ambulancier a besoin d'aide (matériel et/ou personnel supplémentaire) pour le conditionnement et/ou le relevage (2 ^{ème} équipe d'ambulanciers, sapeurs-pompiers...)
Soin sur place	La personne ne nécessite pas une hospitalisation. Il s'agit certainement d'une anomalie au niveau de l'alerte au 15 (plaisanterie, panique...). La personne est laissée sur place après avis médical.
Refus de transport	Le malade/ le blessé refuse les soins et/ou le transport, bien que son état le nécessite. Le médecin régulateur peut dans ce cas autoriser l'ambulance à quitter les lieux sans assurer le transport. Remplir alors une décharge de responsabilité.

Transmission pré et post transport

L'ambulancier se doit d'informer le personnel hospitalier de tout ce qu'il a pu constater dans l'évolution du patient depuis le moment de sa prise en charge jusqu'aux transmissions, notamment si cette évolution traduit une aggravation de l'état de santé du patient (alerte qu'il a préalablement passée sous forme de bilan au centre 15).

Outre les transmissions orales qui favorisent leur rapidité et donc normalement la prise en charge par les équipes soignantes, l'ambulancier se contraindra à les faire par écrit, afin d'établir une **traçabilité** à sa démarche en cas de problèmes légaux. D'où la nécessité, encore une fois, de bien remplir la feuille de surveillance ou la fiche bilan qui accompagne tout transport.

Information et droits des patients

LES DROITS DU PATIENT

Rappels réglementaires

La délivrance de l'information

La loi du 4 mars 2002 reconnaît un droit général pour toute personne d'être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. Ce droit d'être informé est identique quel que soit le professionnel qui délivre l'information, son mode, son lieu d'exercice (privé et/ou public), quelles que soient les circonstances et qu'il s'agisse de prévention ou de soins.

L'information délivrée par le professionnel de santé à la personne est destinée à l'éclairer sur son état de santé et à lui permettre, si nécessaire, de prendre, en connaissance de cause, les décisions concernant sa santé en fonction de ce qu'elle estime être son intérêt. Cette information permet notamment à la personne d'accepter ou de refuser les actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique qui lui sont proposés. Pour ce faire, l'information porte sur l'objectif, la nature et le déroulement des actes et du suivi envisagé.

L'information est un élément essentiel dans la relation de confiance réciproque entre le professionnel de santé et la personne. À ce titre, elle s'inscrit dans un dialogue.

Le contenu et les qualités de l'information

Le contenu de l'information

L'information porte sur l'état de santé de la personne. Lorsque des investigations, traitements ou actions de prévention sont envisagés, le professionnel de santé délivre à la personne, dans le cadre de ses compétences, les informations permettant à cette dernière de prendre ses décisions en connaissance de cause. Il décrit le suivi proposé et répond aux questions posées.

L'information prend en compte la situation de la personne dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle. Elle porte tant sur des éléments généraux que sur des éléments spécifiques, tenant compte des connaissances médicales avérées :

- L'état de santé de la personne et son évolution le plus souvent observée. En cas de maladie, elle porte sur ses caractéristiques et son évolution habituelle avec et sans traitement, y compris en ce qui concerne la qualité de vie.
- La description, le déroulement et l'organisation des investigations, des soins, des actes envisagés et l'existence ou non d'une alternative. Leurs objectifs, leur utilité, leur degré d'urgence. Les bénéfices escomptés. Les suites, les inconvénients, les complications et les risques fréquents ou graves habituellement prévisibles ; les conseils à la personne et les précautions qui lui sont recommandées.
- Le suivi et ses modalités en fonction des solutions envisagées.
Il est essentiel de présenter les différents choix possibles, pour permettre à la personne de se représenter les enjeux de sa décision quelle qu'elle soit : accord ou refus.

Les qualités de l'information

Qu'elle soit donnée exclusivement de façon orale ou accompagnée d'un document écrit, l'information répond aux mêmes critères de qualité :

- Être synthétique, hiérarchisée, compréhensible par la personne et personnalisée.
- Présenter, quand elles existent, les alternatives possibles.
- Présenter les bénéfices attendus des actes ou soins envisagés, ainsi que leurs inconvénients et leurs risques éventuels.

L'information porte sur les risques fréquents et, pour les risques normalement prévisibles, sur les risques graves, c'est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. L'information porte également sur les risques spécifiques à la personne et les précautions particulières à prendre pour les éviter.

Au cours de cette démarche, le professionnel de santé s'assure que la personne a compris l'information qui lui a été délivrée, par exemple en lui demandant de dire ce qu'elle a compris.

Le professionnel de santé indique la proposition qui a sa préférence, en expliquant ses raisons. Il invite la personne à s'exprimer et à poser des questions sur les informations données. Il lui propose de revenir pour un autre entretien dans le cas où elle se poserait des questions nouvelles. Il lui propose également, si nécessaire, de recourir à un second avis.

Les modalités de la délivrance de l'information

L'entretien individuel

La délivrance de l'information, qui implique un dialogue, se fait toujours dans le cadre d'un entretien individuel. Celui-ci permet d'ajouter aux informations génériques des éléments adaptés à la situation de la personne, ainsi que de répondre aux questions qu'elle se pose, et de lui permettre d'exprimer ses préférences.

La délivrance de l'information requiert du tact, du temps et de la disponibilité, ainsi qu'un environnement adapté. Elle s'inscrit dans un climat relationnel alliant écoute et prise en compte des attentes de la personne. Il est souvent nécessaire de délivrer l'information de façon progressive et en plusieurs fois. Elle est réitérée à chaque fois que cela est nécessaire et elle est régulièrement actualisée.

Lorsque la personne exprime la volonté de ne pas être informée, cette volonté est respectée par le professionnel de santé, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Dans ce dernier cas, seule la personne concernée est destinataire de l'information.

L'entretien en présence d'un accompagnant

Lorsque la personne est accompagnée, il convient de s'assurer de son souhait que l'accompagnant soit présent lorsque l'information est délivrée. Il est important de lui proposer que l'entretien soit en partie singulier, sauf si la personne s'y oppose.

Lorsque la personne est étrangère, il est recommandé de faire appel, si possible, à un interprète. De même, lorsque la personne est en situation de handicap sensoriel (surdité) ou moteur (dysarthries) en dehors de toute altération cognitive, il est recommandé de faire appel à un assistant de communication.

L'entretien en présence d'une personne de confiance

Lorsque la personne malade a désigné une personne de confiance (au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique) et a choisi de se faire assister par elle lors de l'entretien, ce dernier a lieu en présence de la personne de confiance. Il est important de proposer qu'une partie de cet entretien se fasse en tête à tête, sauf si la personne s'y oppose.

L'usage de documents écrits

L'information, qui est toujours orale, est primordiale.

En complément l'information, lorsque des documents écrits existent, il est recommandé de les remettre à la personne pour lui permettre de s'y reporter et/ou d'en discuter avec toute personne de son choix.

Ces documents ont aussi vocation à susciter des questions auxquelles le professionnel de santé répond.

Le document d'information, exclusivement destiné à donner à la personne des renseignements par écrit, n'a pas à être signé par la personne et ne contient aucune formule l'invitant à y apposer une signature.

Pour assurer la qualité de l'information contenue dans les documents écrits diffusés à la personne, cette information est :

- Hiérarchisée. Elle repose sur des données validées et présente les bénéfices attendus des actes ou des soins envisagés avant l'énoncé des inconvénients et des risques éventuels. Elle précise les risques fréquents et, pour les risques normalement prévisibles, les risques graves. Elle indique les moyens mis en œuvre pour faire face aux complications éventuelles ainsi que les signes d'alerte détectables par la personne.
- Synthétique, claire et courte.
- Compréhensible par le plus grand nombre.

Il est souhaitable que soient disponibles : des documents d'information dans les principales langues étrangères parlées en France ainsi que des supports adaptés notamment aux personnes malvoyantes ou aveugles, aux personnes souffrant de troubles envahissants du développement...

L'utilisation de supports multimédias peut éventuellement compléter l'information orale et écrite, sans s'y substituer. Des adresses de sites Internet sont communiquées à la personne qui souhaite s'y référer.

L'élaboration des documents repose sur une méthode définie et transparente associant notamment des représentants des destinataires de l'information. La date de publication des documents est précisée.

L'information en cas d'intervention de plusieurs professionnels de santé

Lorsque plusieurs professionnels de santé interviennent, chacun informe la personne des éléments relevant de son domaine de compétences en les situant dans la démarche générale de soin.

Chaque professionnel de santé n'a pas à présumer que l'information relevant de ses compétences a été donnée par d'autres. Toutefois, il s'enquiert des informations déjà délivrées et en tient compte pour celles qu'il donne.

Un référent unique, professionnel de santé, remet à la personne une synthèse des données médicales la concernant, et cela aux différentes étapes du processus de soin. Le choix du référent tient compte des souhaits exprimés par la personne.

La traçabilité de l'information

Le dossier contenant les informations de santé relatives à la personne mentionne **les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées lors de leur délivrance**. Il mentionne le cas échéant les démarches entreprises lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue française ou présente des difficultés de communication ou de compréhension. Ces mentions permettent aux autres professionnels de santé d'en prendre connaissance dans le but de favoriser la cohérence de l'information.

Parce que ces mentions suffisent à servir de moyen de preuve en cas de litige, il n'y a pas lieu de demander à la personne une confirmation signée de la délivrance de l'information.

L'information du mineur, du majeur protégé et du majeur qui n'est pas en mesure de recevoir l'information

L'information délivrée au mineur

Comme toute personne, le mineur a le droit d'être informé. Toutefois, ce droit est exercé par les titulaires de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. Le professionnel de santé leur délivre cette information.

En outre, le mineur reçoit lui-même une information adaptée à son degré de maturité. L'objectif de cette information spécifique est de l'associer à la prise de décision le concernant, sachant qu'en principe la décision est prise par les titulaires de l'autorité parentale.

Le dossier médical porte la trace de l'information donnée, tant aux titulaires de l'autorité parentale qu'au mineur.

Le mineur accompagné des deux titulaires de l'autorité parentale

Le professionnel de santé délivre l'information à ces accompagnants après avoir vérifié, en cas de doute, s'ils sont titulaires de l'autorité parentale.

Le professionnel de santé délivre également au mineur une information adaptée à son degré de maturité.

Il pourra être proposé, en fonction de l'âge de l'enfant, que l'entretien soit en partie singulier avec ce dernier.

Le mineur accompagné d'un seul titulaire de l'autorité parentale

Lorsque la personne qui accompagne le mineur est seule titulaire de l'autorité parentale (par exemple, enfant non reconnu par le père, parent décédé, enfant dont les parents sont séparés, mais pour lequel le juge a confié l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, déchéance de l'autorité parentale, etc.), le professionnel de santé délivre l'information à cette dernière.

Lorsqu'il existe deux titulaires de l'autorité parentale, dont un seul est présent, le professionnel de santé expose à celui-ci la nécessité d'informer l'autre titulaire de cette autorité, en particulier lorsque le couple est séparé. Dans certains cas, tel celui du diagnostic de maladies à pronostic grave, il propose un entretien avec les deux parents.

Si le titulaire de l'autorité parentale est accompagné d'une personne s'occupant régulièrement du mineur, l'information peut être délivrée en présence de cette dernière. Il convient cependant qu'une partie de l'entretien se fasse en présence du seul titulaire de l'autorité parentale. Si la maturité du mineur le permet, son accord sur la présence de cette personne est préalablement sollicité.

Le professionnel de santé délivre également au mineur une information adaptée à son degré de maturité.

Il pourra être proposé, en fonction de l'âge de l'enfant, que l'entretien soit en partie singulier.

Dans tous les cas, seuls ceux qui sont titulaires de l'autorité parentale prennent la décision concernant le mineur.

Le mineur accompagné d'une personne non titulaire de l'autorité parentale

Le professionnel de santé délivre au mineur une information adaptée à son degré de maturité.

Il délivre à l'accompagnant une information strictement utile et nécessaire et expose la nécessité de la compléter en présence du ou des titulaires de l'autorité parentale.

Il pourra être proposé, en fonction de l'âge de l'enfant, que l'entretien soit en partie singulier.

Le mineur non accompagné

Si la maturité du mineur et la situation clinique le permettent, le professionnel de santé délivre au mineur l'information. Si besoin, le professionnel de santé lui indique qu'il est nécessaire qu'il la réitère ou la complète en présence du ou des titulaires de l'autorité parentale.

Le mineur s'opposant à l'information des titulaires de l'autorité parentale pour garder le secret sur son état de santé

Le médecin s'efforce de convaincre le mineur de mettre les titulaires de l'autorité parentale au courant. Si le mineur refuse cette proposition, le médecin met en œuvre le traitement ou l'intervention.

Mais, il ne le peut que s'il s'agit de décisions médicales relatives aux traitements et interventions qui s'imposent pour sauvegarder la santé du mineur. Cette dérogation aux règles sur l'autorité parentale ne concerne que le seul médecin, et non tout professionnel de santé. Elle le dispense d'obtenir l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale.

Si le mineur maintient son opposition, il se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

L'information délivrée au majeur protégé ou au majeur qui n'est pas en mesure de recevoir l'information

L'information délivrée au majeur protégé

Les recommandations tiennent compte des modifications introduites par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs¹¹. La loi du 4 mars 2002 n'envisageait que la situation du majeur sous tutelle, tandis que celle du 5 mars 2007 concerne l'ensemble des personnes majeures protégées (majeurs placés sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, ou ayant rédigé un mandat de protection future).

Cette dernière loi affirme le principe d'autonomie du majeur protégé pour les décisions relatives à sa personne et donc à sa santé, quelle que soit la mesure de protection dont il bénéficie.

Le majeur protégé reçoit lui-même l'information sur son état de santé au même titre que toute autre personne. Cette information est adaptée à ses facultés de compréhension. Cependant, le juge des tutelles peut prévoir que le tuteur, le curateur, le mandataire de protection future reçoit l'information en présence du majeur protégé.

Le juge peut prévoir, dans les cas où le majeur n'est pas en état de recevoir l'information, que le tuteur la reçoit seul. Il revient au professionnel de santé de vérifier la mesure de protection prise par le juge des tutelles. Le jugement prenant cette mesure peut être demandé au majeur protégé, au protecteur du majeur, à sa famille, au greffe du tribunal d'instance du lieu de résidence.

Une personne bénéficiant d'une mesure de protection peut désigner une personne de confiance, sauf si elle est placée sous tutelle. Si avant d'être mise sous tutelle, elle avait désigné une personne de confiance, le juge des tutelles peut confirmer la mission de cette dernière ou la révoquer.

L'information délivrée au majeur qui n'est pas en mesure de recevoir l'information

Le professionnel de santé délivre à la personne une information adaptée à ses facultés de compréhension.

La personne de confiance est consultée si la personne qui l'a désignée se trouve hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

Il revient au professionnel de santé de vérifier qu'une personne de confiance a bien été désignée par la personne malade à un moment où cette dernière disposait encore de ses facultés de discernement.

En l'absence de personne de confiance, le professionnel de santé consulte les proches présents. Il indique dans le dossier médical pourquoi il s'est trouvé dans la nécessité de les consulter et le contenu de l'information donnée.

La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, formule les questions de confidentialité et du secret comme un **droit des usagers** et non plus seulement comme une obligation des professionnels.

Le secret médical s'applique aussi bien dans le secteur sanitaire que dans le secteur médico-social ; cependant, le droit en vigueur n'avait pas toujours prévu les conditions du nécessaire partage d'informations au sein des établissements et services... La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé apporte des clarifications importantes.

Il est important que les professionnels des secteurs : sanitaires, social et médico-social connaissent ces règles qui encadrent leur action quotidienne, au risque de leur responsabilité pénale.

La charge de l'information incombe au professionnel de santé

Il s'agit de démontrer que l'information a été donnée par tous les moyens disponibles ou recherchés : (recherche d'interprète en cas de barrière linguistique, fiche d'informations disponibles en plusieurs langues). La bonne foi du soignant n'est pas seulement attestée par la signature d'un document remis au patient mais aussi par la tenue rigoureuse du dossier, traçabilité, démarche de formation continue, évaluation des pratiques professionnelles (ces dernières ne sont que peu effectives chez les ambulanciers et peuvent faire l'objet d'évolutions de la profession).

L'information de la personne de confiance

Art. L1111-6/ CSP : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et recevoir l'information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ». La personne de confiance ne saurait donc se substituer au patient ni décider à sa place. Elle l'accompagne et l'assiste dans le processus de soins. »

Quelles sont les fautes médicales les plus fréquemment identifiées ?

- Le défaut d'information
- Le retard de diagnostic ou l'erreur de diagnostic
- L'erreur de dosage
- Le défaut de surveillance (hypothèse de l'autolyse d'un patient)

Droit au secret

Art. R/ CSP : les patients ont la possibilité, s'ils le demandent, d'être admis et soignés à l'hôpital sans qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence ou leur état de santé. Leur identité est CEPENDANT toujours connue des services hospitaliers et des organismes d'assurance maladie. En dehors de ces demandes de confidentialité à l'égard des tiers, il existe 2 situations permettant l'anonymat des patients au sein de l'hôpital expressément prévues par les textes.

- ▶ Les patients toxicomanes
- ▶ L'accouchement sous X

Article 326 du Code civil : « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » L'article L du Code de l'action sociale et des familles fixe les modalités d'application de ce régime d'anonymat.

Art. R/ CSP : « si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, la femme demande le bénéfice du secret de l'admission et de son identité, aucune pièce d'identité n'est demandée et aucune enquête n'est diligentée Conséquence pour l'hôpital : l'anonymat est absolu c'est-à-dire que son identité est inconnue du service hospitalier La demande d'anonymat peut même être rétroactive. »

Le secret médical

La notion de secret médical couvre l'ensemble des informations concernant un patient porté à la connaissance du professionnel de santé. Cela inclut les informations que qui sont confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de la mission du professionnel de santé.

Ainsi sont couverts par le secret médical :

- les déclarations d'un malade,
- les diagnostics,
- les dossiers,
- mais aussi les conversations surprises au domicile du patient,
- les confidences des familles...

Le secret médical partagé pour assurer la continuité des soins

Pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d'échanger des informations sur le patient qu'ils prennent en charge, et ce au-delà de la notion de secret médical. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Au-delà de ces limites, il est question de violation du secret.

Le secret professionnel

Clé de voûte de la relation patient-professionnel de santé, le secret professionnel permet d'instaurer et maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge du patient. Institué dans l'intérêt de la personne soignée, il a pour objet principal de protéger son intimité.

A juste titre considéré et ressenti comme une obligation morale, le secret professionnel est également :

- une obligation légale posée par l'article L.1110-4 du code de la santé publique (Droits de la personne) : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » ;
- une obligation déontologique énoncée par l'article R.4312-4 du même code : « Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé ».

Le secret professionnel se définit comme le devoir imposé par la loi à une catégorie de professionnels en raison de leur état, et sous peine de sanction, de conserver secrètes des informations confidentielles qui sont parvenues à leur connaissance à l'occasion de leur profession.

Selon l'article L.1110-4 précité du code de la santé publique, sauf exceptions légales « Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé ».

Le consentement du patient

Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé publique)

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.

LA BIENTRAITANCE AU QUOTIDIEN

Définition

La bientraitance relève d'une culture partagée du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de sa singularité. • Pour le professionnel, il s'agit d'une manière d'être, de dire et d'agir, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus. La bientraitance intègre le souci de maintenir un cadre institutionnel stable, avec des règles claires, connues et sécurisantes pour tous et d'un refus sans concession de toute forme de violence. • L'expression de l'usager est valorisée. La bientraitance est concrètement une démarche répondant aux droits du patient et à ses choix. • La démarche de bientraitance est un aller-retour permanent entre penser et agir. Elle exige à la fois une réflexion collective sur les pratiques des professionnels, et nécessite une mise en acte rigoureuse des mesures que la réflexion collective préconise pour les améliorer. Dans cette optique, elle induit l'adoption d'une culture de questionnement permanent. • La recherche de bientraitance est une démarche continue d'adaptation à une situation donnée. Par essence, elle est sans fin. Elle implique une réflexion et une collaboration incessantes entre tous les acteurs d'un accompagnement, à la recherche de la meilleure réponse possible à un besoin identifié, à un moment donné.

La **maltraitance** est un mauvais traitement (occasionnel, durable ou répété) infligé à une personne (ou un groupe) que l'on traite avec violence, mépris, ou indignité. La maltraitance implique un rapport de pouvoir ou domination entre l'auteur et la victime, qui est ainsi souvent dépendante et sans défense

Les différentes situations de maltraitance

- Physiques : coups, ecchymoses, gifles, manipulations brutales
- Psychiques : propos dévalorisants, humiliants, brimades, langage grossier
- Sexuelles : viol, attouchements
- Financières : vol, spoliation, rétention de pension ou de moyen de paiement, héritage anticipé
- Civiles : privations de droits, atteintes aux libertés des personnes, enfermement
- Médicales : soins inadaptés, imposés, contentions

La maltraitance n'est pas n'importe quel abus, violence ou négligence.

Il existe 3 caractéristiques inexorables :

- L'abus de pouvoir : il y a une notion de prendre avantage de sa situation d'autorité et de pouvoir.
- La dissymétrie : la personne maltraitée est plus fragile que l'autre
- La dépendance : la personne maltraitée a besoin de l'autre pour répondre à ses besoins essentiels.

Compte tenu de ces caractéristiques, on parle de **maltraitance des patients par les soignants** et non de violence vis-à-vis des soignants

Maltraitance chez les personnes âgées

On estime que 1 personne âgée sur 10 est confrontée chaque mois à la maltraitance. C'est sans doute une sous-estimation, étant donné que seulement 1 cas de maltraitance sur 24 est notifié. Les personnes âgées craignent en effet de signaler les mauvais traitements dont elles sont victimes à la famille, aux amis ou aux autorités. La maltraitance en institution recouvre le recours à la contrainte physique à l'égard des patients, le non-respect de leur dignité – par exemple en négligeant de changer leurs vêtements souillés – et de leur liberté de choix concernant la vie quotidienne, le manque intentionnel de soins (entraînant, par exemple,

l'apparition d'escarres), l'abus ou le défaut de traitement médicamenteux ainsi que la négligence et la violence morales.

La maltraitance des personnes âgées peut conduire à des traumatismes physiques – il peut s'agir d'égratignures bénignes, d'ecchymoses mais aussi de fractures des os et de traumatismes crâniens qui peuvent conduire à une incapacité permanente – et avoir des conséquences psychologiques graves, parfois durables, parmi lesquelles figurent la dépression et l'anxiété.

Facteurs de risque

Facteurs de risque liés au profil de l'aidant

L'aidant n'est pas préparé à s'occuper d'une personne malade.

- La cohabitation. L'aidant vit avec la personne âgée et s'occupe d'elle depuis longtemps. Il accepte mal cette charge de soignant et ne reçoit en contrepartie aucune gratification.
- La fragilité psychologique ou la surcharge morale et affective (burn-out) favorisent la maltraitance lorsque le seuil de tolérance de l'aidant est dépassé.
- La dépendance financière. Les problèmes sociaux ou financiers chez l'aidant renforcent le risque d'abus financier et de maltraitance de la personne âgée.
- Des relations familiales tendues. Elles peuvent s'aggraver avec le stress à mesure que la personne âgée perd son autonomie.
- L'isolement : l'aidant est seul à assumer la prise en charge de la personne âgée et n'a pas la capacité de faire face. Il peut se laisser aller plus facilement à des comportements abusifs jusqu'à la maltraitance de la personne âgée.
- Le manque de disponibilité. L'aidant travaille et ne dispose pas assez de temps libre. Les soins aux parents âgés deviennent un fardeau trop lourd, ce qui accroît le risque de violence.

Facteurs de risque liés au profil de la victime potentielle

- Une lourde dépendance ou un handicap physique. La personne âgée n'est pas en capacité d'accomplir seule les actes de la vie quotidienne. Des troubles, tels que l'incontinence, créent une surcharge de travail et peuvent entraîner des phénomènes de maltraitance : rejet, isolement, abandon.
- La cohabitation. La personne vit avec le même aidant depuis longtemps.
- La perte du contrôle de ses avoirs financiers ou de son argent au quotidien.
- L'apparition de troubles du caractère. Les cas de démence, comme la maladie d'Alzheimer, peuvent entraîner des réactions hostiles et des actes de maltraitance.
- L'isolement.

Les personnes qui prennent en charge des personnes âgées, aidants familiaux ou professionnels, ont parfois du mal à supporter leurs faiblesses.

Cas particulier : facteurs de risque au sein des institutions

- ▶ Négligence des normes de soins, laisser-aller dans les services de protection sociale et les établissements de soins pour les personnes âgées.
- ▶ Un personnel surchargé de travail, mal formé et mal rémunéré.
- ▶ Un environnement matériel défectueux. Les intérêts de l'institution étant privilégiés au détriment de ceux des pensionnaires.

Les signes d'alerte

Il est difficile de déceler la maltraitance envers les personnes âgées. Elle est en effet multiforme et certains actes de maltraitance peuvent être très insidieux. La présence cumulée des facteurs de risque suivants doit éveiller l'attention, même si elle n'est pas nécessairement synonyme de maltraitance.

Les signes repérés sur la personne âgée

La personne semble méfiante, apeurée.

- Elle présente des signes de dépression : apparence négligée, manque d'appétit, d'intérêt, insomnie...
- Elle l'air excessivement calme, apathique.
- Elle chute de manière répétée.
- Elle présente des traces de blessures, d'ecchymoses qu'elle ne peut expliquer.

Les signes repérés dans le comportement de l'aidant

- L'aidant déprécie la personne âgée dont il a la charge.
- Il se plaint de son comportement.
- Il la réprimande ou l'isole.

Que faire ?

Les données factuelles laissent à penser que les services de protection des adultes et les visites à domicile effectuées par les services de police et les travailleurs sociaux semblent avoir des conséquences négatives et entraîner une augmentation de la maltraitance à l'égard de la personne âgée.

Regarde-moi

Que vois-tu, toi qui me soignes, que vois-tu ?

Quand tu me regardes, que penses-tu ?

Une vieille femme grincheuse, un peu folle,

le regard perdu, qui bave quand elle mange et ne répond jamais

quand tu dis d'une voix forte « essayez » et qui

semble ne prêter aucune attention à ce qu'elle fait...

Qui docile ou non, te laisse faire à ta guise,

le bain et les repas pour occuper la longue journée.

C'est ça que tu penses, c'est ça que tu vois ?

Alors ouvre les yeux, ce n'est pas moi.

Je vais te dire qui je suis, assise là, tranquille,

me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux...

je suis la dernière de dix enfants, avec un père, une mère ;

des frères, des sœurs qui s'aiment entre eux...

Une jeune fille de seize ans, des ailes aux pieds,

rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé...

Déjà vingt ans, mon cœur bondit de joie

au souvenir des vœux que j'ai fait ce jour-là.

J'ai vingt-cinq ans maintenant et un enfant à moi,

qui a besoin de moi, pour lui construire une maison...

Une femme de trente ans, mon enfant grandit vite;

nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront...

Quarante ans, bientôt il ne sera plus là,

mais mon homme est à mes côtés et veille sur moi.

Cinquante ans, à nouveau jouent autour de moi des bébés.

Nous revoilà avec des enfants, moi et mon bien-aimé.

Voici les jours noirs, mon mari meurt.

Je regarde vers le futur en frémissant de peur

car mes enfants sont très occupés pour élever les leurs

et je pense aux années et à l'amour que j'ai connus.

Je suis vieille maintenant et la vie est cruelle et

elle s'amuse à faire passer la vieille pour folle.

Mon corps s'en va.

Grâce et forme m'abandonnent.

Et il y a une pierre là où jadis il y avait un cœur.

Mais dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure.

Le vieux cœur se gonfle sans relâche.

Je me souviens des joies et des peines.

Et à nouveau je revis ma vie et j'aime ...

Je repense aux années trop courtes et trop vite passées

et accepte cette réalité implacable.

Alors, ouvre les yeux, toi qui me regarde et qui me soigne.

Ce n'est pas la vieille femme grincheuse que tu vois...

Regarde mieux et tu verras...

- Une pensionnaire de maison de retraite, perçue par les employés comme une vieille dame grincheuse, a laissé cette lettre avant de mourir.

La maltraitance chez les enfants

Elle concerne les moins de 18 ans.

Des révélations tardives d'adultes maltraités pendant leur enfance suggèrent que la plupart des cas ne sont pas révélés. Peu sont signalés et ils font rarement l'objet d'une enquête par les services de protection de l'enfance ou d'une procédure judiciaire. Les raisons évoquées par les victimes sur leur silence : ils n'avaient pas conscience des actes, de leur gravité et de leur caractère condamnable. Ils craignaient ce qui arriverait s'ils en parlaient.



Il arrive parfois que des mauvais traitements soient identifiés sans que l'enfant en parle. Mais la détection de nombreux cas de maltraitance physique, de négligence et de presque tous les cas de maltraitance sexuelle dépend de ce que l'enfant en dit et des mesures prises en conséquence par les adultes de son entourage. Les professionnels, quant à eux, peuvent hésiter à signaler une maltraitance par crainte de conséquences pour eux-mêmes et leur pratique.

Prévalence

Plus de 80 % des mauvais traitements sont infligés par les parents,

Tableau 2. Évolution du nombre d'enfants signalés en danger et évolution des types de mauvais traitements signalés (entre 1998 et 2006, France métropolitaine) (5)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Enfants maltraités	19 000	18 500	18 300	18 000	18 500	18 000	19 000	20 000	19 000
Violences physiques	7 000	6 500	6 600	5 800	5 600	5 600	6 600	6 400	6 300
Violences sexuelles	5 000	4 800	5 500	5 900	5 900	5 900	5 500	4 700	4 300
Négligences lourdes	5 300	5 400	4 800	4 700	5 000	5 000	4 400	5 100	5 000
Violences psychologiques	1 700	1 800	1 400	1 600	2 000	2 000	2 500	3 800	3 400
Enfants en risque	64 000	65 000	65 500	67 500	67 500	71 000	76 000	77 000	79 000
Total des signalements d'enfants en danger	83 000	83 500	83 800	85 500	86 000	89 000	95 000	97 000	98 000

Facteurs de risques

- ▶ Le jeune âge de l'enfant.
- ▶ La prématurité.
- ▶ Le niveau socio-économique des parents
- ▶ Le très jeune âge de la mère (moins de 18 ans)
- ▶ Les antécédents personnels de violence subie par les parents dans leur propre enfance
- ▶ L'isolement social
- ▶ Les troubles du comportement et le handicap, en particulier intellectuel

Signes visibles de maltraitance chez l'enfant

Les ecchymoses

Elles représentent la manifestation la plus commune de la violence physique envers les enfants.

- L'enfant ou l'adolescent présente des ecchymoses de la forme d'une main, d'une ligature, d'un bâton, d'une marque de dents, d'un agrippement ou d'un objet.
- S'il y a des ecchymoses ou des pétéchies non causées par une maladie (trouble de la coagulation) et si l'explication de l'ecchymose n'est pas compatible.
- Les ecchymoses
 - chez un enfant qui ne se déplace pas seul,
 - multiples ou ecchymoses en grappes,
 - de forme et de taille similaire,
 - présentes ailleurs que sur une proéminence osseuse, notamment au niveau du visage incluant les yeux et les oreilles, sur les fesses,
 - au niveau du cou,
 - au niveau des chevilles et des poignets et ressemblant à des marques de ligatures.

Les brûlures intentionnelles

A distinguer les brûlures accidentelles

Il s'agit de brûlures intentionnelles de contact, provoquées par des objets ou des appareils ménagers (cigarette, fer à repasser, sèche-cheveux, radiateur). Nettement délimitées, elles gardent la forme de l'agent en cause. Les paumes de main et les doigts sont épargnés. Elles sont souvent multiples.

Les lésions viscérales

Tous les organes du corps peuvent être atteints. Les lésions thoraciques sont plus fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans. Les enfants ayant des lésions abdominales par maltraitance sont plus jeunes que les enfants accidentés. 80 % des cas des lésions abdominales ne présentent pas d'ecchymose.

Douleurs abdominales chroniques

Fractures

Sont signalées des fractures, au niveau du squelette dans toutes les localisations, plus souvent chez des nourrissons ou des enfants qui commencent à marcher (< 18 mois). Les fractures multiples sont plus fréquentes en cas de maltraitance. En l'absence de cause traumatique confirmée (accident de voiture ou traumatisme violent), il y a une très forte probabilité que des fractures de côtes soient le résultat d'une maltraitance.

Etat émotionnel et comportement

On remarque un changement de l'enfant ou l'adolescent dans son comportement. Son état émotionnel s'écarte de celui attendu pour son âge chronologique et son âge développemental. Il montre de la crainte, un repli sur soi et une faible estime de soi. Ces changements constatés n'ont pas de cause médicale (trouble neuro- développemental).

Négligence différente de maltraitance

Selon le CDC (2008), la négligence est une défaillance à subvenir aux besoins de l'enfant

- Besoins physiques (alimentation, hygiène, abri, vêtements)
- Besoins émotionnels
- Soins médicaux (omission de soins, refus de traitement)
- Education
- Sécurité – protection de l'enfant d'un danger ou d'un danger potentiel – (surveillance inadéquate de ses activités, exposition à un environnement violent à domicile ou dans le voisinage).

Il est possible d'envisager une négligence si un enfant, lorsqu'on est en présence :

D'infestations sévères et persistantes (telles que la gale ou des poux)
De vêtements ou chaussures constamment inadaptés (par exemple à la météo ou à sa taille)
D'un enfant continuellement sale ou qui sent mauvais.

Si on observe de manière répétée ou si est rapporté :

- Un manque d'hygiène qui affecte la santé des enfants
- Une alimentation inadéquate
- Un environnement dangereux par rapport au développement de l'enfant

ATTENTION : Il peut être difficile de distinguer négligence de pauvreté.

Conséquences

Des conséquences somatiques, parfois gravissimes, notamment dans les traumatismes craniocérébraux, au premier rang desquels ceux causés par le syndrome du bébé secoué, peuvent entraver le déroulement de la scolarité et le processus de socialisation normale de l'enfant.

Quand suspecter une maltraitance infantile ?

Le National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) a défini **une explication « inappropriée » d'une blessure comme étant une explication non plausible, inadéquate ou incohérente**, en tenant compte : de l'apparence de l'enfant ou de l'adolescent, de ses activités normales, de son état de santé, de son âge chronologique ou développemental, de l'explication qu'il donne comparée à celle des personnes qui s'occupent de lui.

Des informations recueillies auprès des parents (antécédents, environnement, règles familiales, pratiques culturelles...).

Annexe 1. Aspects législatifs et réglementaires

Annexe 1.1. Article 375 du Code civil

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du Code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. »

Annexe 1.2. Cadre juridique du signalement par un professionnel de santé **de maltraitance à enfant** La violation du secret professionnel est punie par l'article 226-13 du Code pénal. Toutefois, des dérogations à cet article permettent à des professionnels de santé de signaler les privations et sévices qu'ils ont constatés.

L'article 226-14 du code pénal permet la révélation d'une information à caractère secret :

1° « À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° « Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. »

L'article L. 226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que : « [...] les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du Code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code [...] »

Cette information transmise doit être strictement limitée « à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance [...] » article L. 226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles). En vertu de l'article 226-14 du Code pénal, un professionnel de santé n'encourt d'ailleurs aucune sanction pénale disciplinaire, sur le fondement de la révélation d'une information couverte par le secret professionnel, si le signalement a été fait dans les conditions prévues par cet article.

Par ailleurs, les articles 43 et 44 du code de déontologie médicale prévoient que :

- le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage (art. 43) ;

- lorsqu'un médecin constate qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, « il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience » (art. 44).

Enfin, un professionnel de santé a une obligation de porter assistance à personne en danger

Comment lancer une procédure de signalement

Le signalement consiste à porter connaissance d'équipes de professionnels une situation potentielle de danger. Le signalement vise à protéger la victime, en évitant que les faits ne se reproduisent, dans l'objectif de l'aider. Il vise aussi à protéger l'auteur des faits, pour lui éviter d'aller vers des actes plus graves faute d'avoir réagi assez tôt.

Le principe est d'alerter l'autorité judiciaire ou administrative en vue d'une intervention institutionnelle : c'est un écrit objectif comprenant une évaluation de la situation du patient présumé en danger ou en risque de danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire

L'auteur du signalement possède une dérogation au secret professionnel. Toute personne non tenue au secret professionnel doit alerter les autorités lorsqu'elle a connaissance d'une situation de maltraitance.

Pour les professionnels tenus au secret professionnel, l'article 226-14 du code pénal établit en ce domaine une dérogation au secret. Il prévoit que tout professionnel qui porte à la connaissance des autorités administratives, médicales ou judiciaires, en cas de maltraitance n'encourt aucune sanction civile, pénale ou disciplinaire pour violation du secret professionnel. Ainsi, tout professionnel qui informe les autorités compétentes dans les conditions prévues à cet article n'encourt aucune sanction, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

A l'inverse, l'absence d'intervention sont répréhensibles notamment lorsque les professionnels de santé ont acquis la certitude des sévices ou mauvais traitements. La non-dénonciation d'une maltraitance peut être punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-3 du code pénal).

Le signalement des faits n'est pas la dénonciation d'un coupable.

Les soignants ne sont donc tenus de signaler que les faits constatés, c'est-à-dire seulement les constatations qu'ils ont été amenés à faire. Selon la nature, la gravité des faits et le degré d'urgence, l'alerte sera adressée aux autorités administratives et /ou judiciaires (procureur de la république)

L'accord de la victime est souhaitable, mais pas nécessaire lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique.

Situation de maltraitance ordinaire :

En lien avec des attitudes et des propos inadéquats ou des organisations non respectueuses des personnes : attentes - manque d'explications – oublis.

Réfléchir sur sa façon de travailler en veillant à ne pas travailler de façons inadaptées et répétées

Que faire ?

La maltraitance ordinaire se prend en charge dans la promotion de la bientraitance, la formation et le professionnalisme, le respect des droits des usagers.

Face à une suspicion de maltraitance :

- ▶ Prendre en compte ce que dit le patient et/ou son entourage, le collègue.
- ▶ Tracer les faits de manière précise : date, lieu, ce que dit la personne et/ou la famille, ce que vous avez constaté.
- ▶ En parler avec d'autres : le responsable d'exploitation, les collègues de travail.

Relation et communication au patient, à l'entourage et aux aidants

DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE

Comprendre d'où proviennent les comportements de chacun

Les relations au sein de la société : qu'est-ce que la psychologie sociale

Le terme **psychologie** provient de 2 mots grecs : « psyché » qui signifie « âme » et « logia » qui veut dire « science ».

La **psychologie sociale** s'intéresse aux comportements des individus en général et dans la société en particulier. Il s'agit de comprendre les rapports et les relations des individus les uns avec les autres, en fonction des conditions sociales précises (choix d'une place dans un restaurant, comportement dans la foule, rôle de la hiérarchie dans une entreprise, réactions face à une situation difficile...).

La **psychologie sociale** est le domaine d'étude qui analyse la façon dont les **comportements, cognitions (pensées) et affects (émotions ou sentiments) de l'individu** sont **influencés** par le comportement et les caractéristiques **des autres**, les caractéristiques de **la situation** dans laquelle l'individu est inséré ainsi que par **ses propres caractéristiques** psychologiques et sociales.

L'influence sociale renvoie au fait qu'une personne amène une autre personne à modifier son comportement, que ce soit au niveau des actes, pensées ou sentiments. On peut distinguer différentes formes d'influence sociale : le conformisme, la conversion minoritaire, l'obéissance, la persuasion, etc.

Les relations entre 2 personnes : l'analyse transactionnelle

L'analyse transactionnelle étudie les transactions, c'est-à-dire les échanges entre 2 individus : ce que quelqu'un exprime de manière verbale, non verbale et paraverbale ainsi que la manière dont l'interlocuteur va répondre sur ces trois plans. L'analyse transactionnelle propose des schémas d'analyse de ces transactions pour mieux comprendre ce qui est en jeu.

Éric BERNE, psychothérapeute américain a développé l'analyse transactionnelle. Son idée est que si ses patients prennent conscience des mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour se saboter, alors ils seront les premiers acteurs de leur guérison. Il a donc créé un certain nombre de concepts pour expliquer ces mécanismes à ses patients. Puis, ces concepts étant très éclairants, ils sont sortis du contexte de la psychothérapie pour être utilisés en clinique (thérapeutique, accompagnement, coaching...), éducation (formation, gestion de groupe), management (organisation pour développer le potentiel de chacun) et développement personnel.

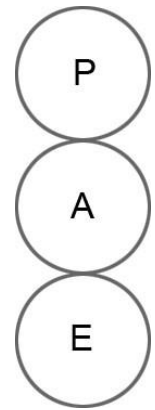
Analyse transactionnelle : Les Etats du MOI

Éric Berne s'est aperçu qu'il y a une corrélation entre le comportement d'une personne, ce qu'elle dit, et l'émotion qu'elle transmet à un moment donné. Et que bien souvent ce même ensemble de manifestations se reproduit de la même façon face une situation identique. **Il a ainsi fait le lien entre émotion, pensée et comportement.** Il s'est ensuite rendu compte, en s'appuyant sur les travaux du psychanalyste *Paul FEDERN*, qu'il était possible de regrouper ces « *corpus* » de manifestations en trois ensembles distincts. Parfois, la personne se comporte (voix, postures, mimiques...) comme l'un de **ses** parents (pas n'importe quels parents), à d'autres moments elle reprend des attitudes ou une façon de parler qu'elle a eu quand elle était petite, et enfin à d'autres moments encore elle agit comme un adulte dans le langage courant : il appellera ces trois façons d'être les États du moi.

A chaque instant, nous abordons la réalité avec trois possibilités :

- Plaquer des modèles (« être dans le **Parent** »).
- Reproduire des vécus personnels d'autrefois (« être dans l'**Enfant** »).
- Ou prendre la réalité telle qu'elle est – et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit avec ce que nous sommes et non ce que nous avons été ou ce que nous voudrions être (« être dans l'**Adulte** »).

La manifestation de ces États du moi est **observable**, c'est-à-dire qu'à chacun de ces États du moi correspondent un comportement (ton, volume de la voix, mimiques, gestuelles, postures...) et un vocabulaire spécifique.



Comment identifier les états du moi d'une personne ?

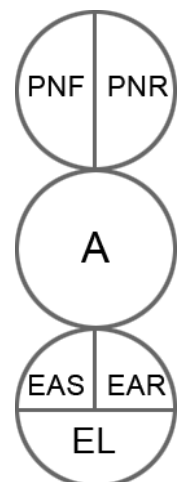
- **Il suffit de regarder et d'écouter.** C'est la voix, son débit, son rythme, sa hauteur qui indiquent le mieux quelle partie de la personne est aux commandes. Les mots comptent aussi, leur choix, les structures de phrases, ainsi que les postures, les mimiques. C'est le paraverbal et le non-verbal, bien plus que le discours, qui indiquent dans quel état du moi nous sommes.
 - C'est ainsi que l'**état du moi Enfant** se manifeste par des gestes spontanés et vifs, des comportements comme on en voit dans les cours de récréation : bisous, bousculades, grimaces, gestes de défi, regards en dessous ou humbles, parfois provoquants, nuque fléchie devant l'adulte grondeur.
 - L'**état du moi Parent** se manifeste par des ordres, des directives, un ton sentencieux, des jugements, des généralités, la référence à ce qui est nécessaire, utile, ce qu'il faut faire. Le doigt pointé, le fait de s'écouter parler, les gestes de menace, les moues de désapprobation. Dans l'état du moi Parent on trouve aussi les comportements de sollicitude, les gestes enveloppants, le parler « bébé » à l'adresse des enfants et des animaux.
 - L'**état du moi Adulte** se manifeste dans l'activité, la réflexion, le traitement de l'information. Le niveau paraverbal est neutre. Les mots sont précis et l'accent est mis sur l'exercice de la pensée et sur la conscience de ce qui se passe.
- Une autre manière de diagnostiquer un état du moi est le **diagnostic social**. Il consiste à examiner l'effet produit sur l'autre par l'intervention d'une personne : quand une personne se sent dans l'Enfant, il y a des chances pour que son interlocuteur ait mobilisé son Parent. Par contre quand l'Adulte est mobilisé, l'Adulte du partenaire se mobilise plus facilement.

Il n'y a pas de « bons » ou de « mauvais » États du moi.

Ils ont tous une fonction différente essentielle et complémentaire.

Les fonctions des États du moi

- **Parent Normatif** : fonction de protection et de transmission de valeurs
- **Parent Nourricier** : fonction de permission et d'encouragement
- **Adulte** : fonction d'exploration de l'environnement
- **Enfant Adapté Rebelle** : fonction d'opposition légitime
- **Enfant Adapté Soumis** : fonction d'adaptation à l'environnement
- **Enfant Libre** : fonction d'expression des besoins et des émotions de base



Exemples

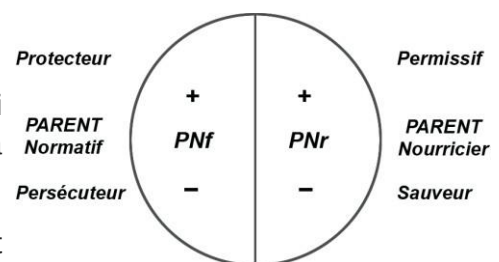
- **Parent Normatif.** Un enfant veut traverser la route alors qu'une voiture arrive.
Un passant lui dit vivement : « Recule-toi ! », éventuellement en accompagnant le geste à la parole.
- **Parent Nourricier.** Sur un ton chaleureux, à un collègue qui vient de se voir confier une nouvelle mission délicate : « Tu vas y arriver, le patron a raison, tu es notre meilleure ressource pour ce projet ! ».
- **Adulte.** Chez un concessionnaire, sur un ton neutre : « Combien coûte cette voiture ? ».
- **Enfant Adapté Rebelle.** Quelqu'un me parle avec un ton que je n'accepte pas.
Je lui dis avec vigueur : « Tu me parles sur un autre ton s'il te plaît ».
- **Enfant Adapté Soumis.** Sans raisons apparentes, un policier m'arrête et me demande mes papiers. Je les lui donne, sans poser de questions.
- **Enfant Libre.** En pleine réunion de travail, un collègue qui a soif propose une pause, sur un ton cordial et dynamique : « Allez hop, pause-café ! ». Sur un ton cordial et dynamique.

Le Parent est divisé en :

- ▶ **Parent Normatif (PNF)** qui gère la loi, la règle
- ▶ **Parent Nourricier (PNR)** qui gère le lien, la relation

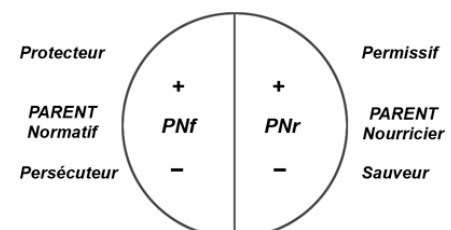
Ces deux états peuvent se subdiviser à nouveau selon que le parent sera aidant ou non, sauveur ou persécuteur (comme décrit plus loin dans le triangle dramatique de KARPMAN) :

- Le Parent Protecteur, ou Donnant, parent positif qui protège, soutient ou encourage.
- Le Parent Critique, Persécuteur ou Sauveur, parent négatif qui dévalorise, donne les lois et les normes ou maintient dans la dépendance.



La transmission des valeurs peut être faite, soit par le Parent Normatif avec justesse, soit par le Parent Normatif Persécuteur de manière autoritaire.

L'Adulte n'est pas divisé : C'est « l'état du moi, dans lequel la personne examine objectivement son environnement, en calcule les possibilités et probabilités sur la base de l'expérience passée »



L'État du moi Enfant est scindé en deux parties :

- **Enfant Adapté** : l'enfant s'adapte à son environnement en l'acceptant ou en le rejetant (Enfant Adapté Soumis (EAS) ou Enfant Adapté Rebelle (EAR)).
- **Enfant Libre (EL)** : l'enfant qui agit selon ses émotions sans chercher à plaire ou déplaire.
Il est créatif, indépendant et spontané.

« Tout être humain porte en soi un petit garçon ou une petite fille qui pense, agit, parle, s'émeut et réagit exactement de la même façon que lorsqu'il était un enfant. ».

(Eric BERNE, What do you say after you say hello, p. 31).

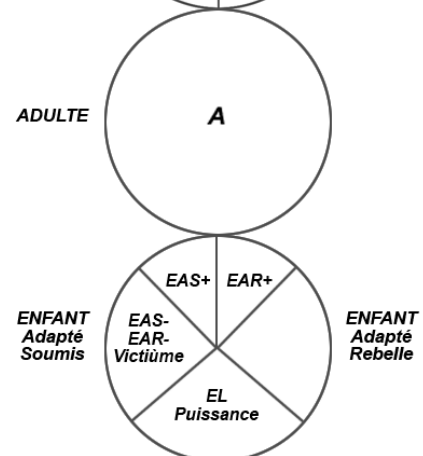


Schéma récapitulatif des états fonctionnels du Moi selon Eric Berne

En revanche, **l'utilisation d'une manière excessive d'un État du moi, sans nécessité par rapport à la situation, conduit à rendre in-opérationnel l'usage de sa fonction** : si une personne parle régulièrement vivement à son enfant, celui-ci ne saura plus faire le distinguo entre l'avertissement face à un danger avéré et une situation banale, si quelqu'un fait systématiquement ce qu'on lui dit, il ne fera plus la différence entre l'adaptation adéquate et ce que l'on nomme la sur-adaptation, c'est-à-dire l'adaptation au détriment de ses propres besoins, ou si un collègue interrompt une réunion toutes les deux minutes parce qu'il a soif, il est probable qu'au bout d'un moment il n'aura plus voix au chapitre.

Les contaminations

L'Adulte est toujours plus ou moins contaminé par le Parent et/ou par l'Enfant. Il y a contamination de l'Adulte par le Parent lorsque la personne tient pour Adulte, c'est-à-dire actuelle et vérifiée, une information erronée provenant du Parent. Une telle contamination constitue un « **préjugé** ».

Par exemple :

- « Les femmes ne savent pas conduire.
D'ailleurs, combien de femmes pilotes de F1 connaissez-vous ? »
- « De nos jours, les diplômés ne préparent pas les jeunes à la vie active.
La preuve en est qu'ils finissent presque tous au chômage. »

Il y a contamination de l'Adulte par l'Enfant lorsque la personne tient pour une information Adulte une information provenant en réalité de l'Enfant. Il s'agit généralement d'une sensation imprécise à forte charge émotive. Une telle contamination constitue une « **illusion** ».

Par exemple :

- « Aujourd'hui, c'est mon jour de chance, rien ne peut m'arriver. »
- « Ce n'est pas possible, tout le monde m'en veut ! »
- « Dans cette association, je suis indispensable. Rien ne peut se faire sans moi. »

Les exclusions

Il y a exclusion d'un état du moi lorsque celui-ci n'est jamais ou presque jamais investi ou utilisé par une personne. Parfois deux états du moi peuvent être exclus, ce qui fait qu'une personne ne fonctionne plus qu'à partir :

- ▶ De son Parent (Critique et/ou Nourricier et qui sermonne en permanence)
- ▶ De son Enfant (personne complètement déconnectée de la réalité)
- ▶ De son Adulte (personne qui n'est qu'un « ordinateur »)

Une personne utilise de façon optimum ses trois états du moi lorsqu'elle met l'Adulte au contrôle.

En résumé

- Lorsque nous nous exprimons, nous investissons un « ETAT DU MOI »
- Une interaction entre 2 états du moi s'appelle une TRANSACTION
- L'analyse des transactions permet de mieux comprendre le positionnement de chacun en communication.

Analyse transactionnelle : les scénarios de vie

Le scénario de vie est l'ensemble des conclusions que nous avons tirées de ce qui nous est arrivé et des décisions prises dans l'enfance sur ce que devrait être notre vie dans différents domaines (couple, famille, travail...).

Certains scénarios sont gagnants, les décisions prises sont aidantes. Dans les scénarios perdants, les décisions prises entraînent des croyances limitantes (drivers, jeux psychologiques).

Par exemple : croire qu'on a toujours été incompetent dans un domaine donné et que par conséquent, on ne réussira jamais. On se met alors des barrières psychologiques et on n'essaye même plus. Mais aucune situation n'est figée, on évolue. En s'y remettant, on pourrait y arriver.

Repérer les drivers et jeux psychologiques

Les drivers : pilotes, programmes automatiques qui font réagir de manière réflexe en reproduisant des comportements qui nous ont aidés par le passé. Attention, ce qui était aidant à un moment peut devenir contraignant.

Analyse transactionnelle : les jeux psychologiques

Les jeux psychologiques : comportements que nous adoptons pour attirer l'attention d'autrui de la manière que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire en nous mettant dans des situations douloureuses, conflictuelles ou perdantes. Les jeux psychologiques correspondent donc à des comportements inconscients de sabotage dans le but d'attirer l'attention autour de 3 rôles :

SAUVETEUR, VICTIME, PERSECUTEUR (moyen mnémotechnique : SVP).

Apprendre à repérer ce « triangle dramatique » (décrit par KARPMAN), c'est pouvoir en sortir.

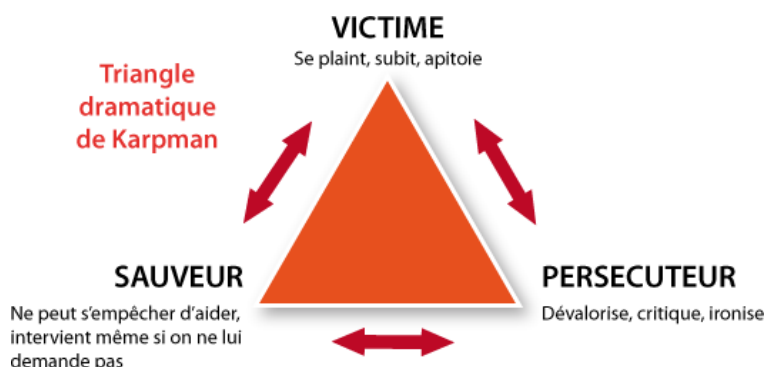
Pour cela, on élabore des situations qui se répètent et où l'on peut jouer tour à tour chacun des 3 rôles. L'inconvénient principal des jeux psychologiques est que, même si chacun des rôles peut être gratifiant pendant un court moment, **tous les participants en sortent perdants**.

Au niveau individuel, le **persécuteur** est souvent celui qui a besoin de contrôler. Il peut trop exiger des autres car lui-même s'applique des exigences draconiennes.

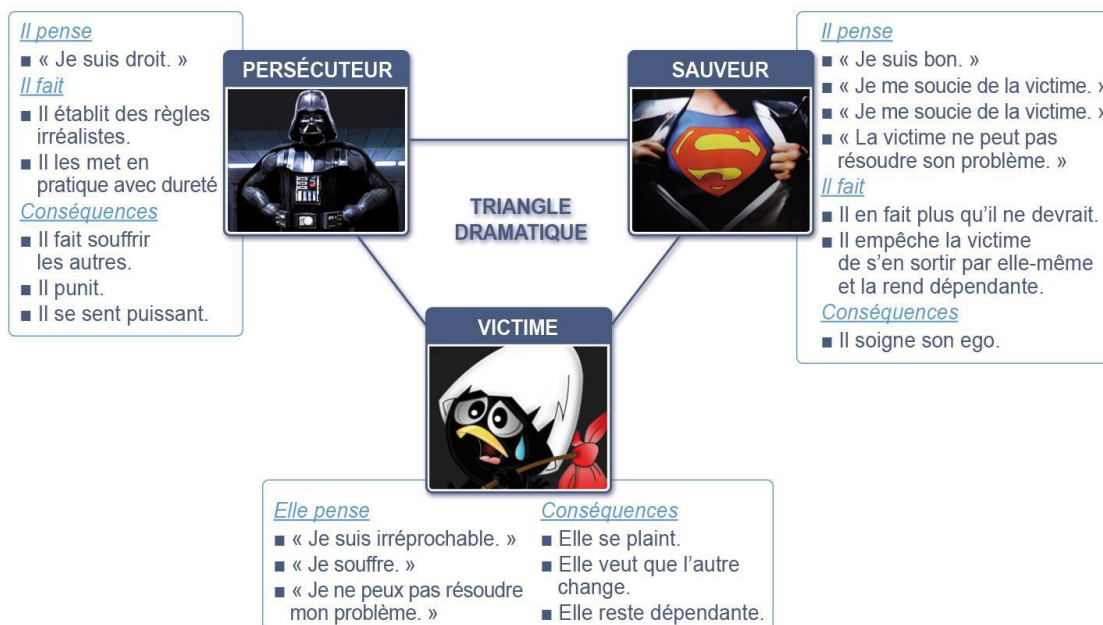
Le persécuteur culpabilise. Il ordonne. Il est frustré et irascible.

La **victime** prend la posture de celui ou celle qui veut attirer l'attention. Son rôle consiste à être pur, innocent et réduit à l'impuissance. La victime pousse les autres à jouer le rôle soit de sauveur, soit de persécuteur. C'est une personne plaintive, malheureuse et passive. Son objectif : inspirer pitié et compassion pour être pris en charge mais aussi rendre l'autre responsable de ses souffrances.

Le **sauveur**, quant à lui, se sent irremplaçable. Il est toujours prêt à défendre les causes perdues. Mais son côté protecteur infantilise et sert à créer une dépendance car il a secrètement peur d'être abandonné. Il anticipe les demandes de la victime. Il en fait trop, quitte à perdre de l'argent, du temps, sa dignité. Sauver l'autre est sa raison d'être, il n'existe que comme ça. En réalité, il soigne son égo.



Le Triangle dramatique : Jeu psychologique malsain qui aboutit inévitablement à un conflit



C'est *Stéphane KARPMAN*, un psychologue américain, qui a imaginé le triangle dramatique.

D'après lui, lorsque nos relations commencent à être déséquilibrées ou malsaines, c'est que nous sommes rentrés dans l'un des trois rôles principaux du triangle.

Pour en sortir, il faut :

- Apprendre à repérer son propre rôle dans le triangle dramatique afin d'en sortir et de prendre sa vraie place dans la relation.
- Apprendre à repérer le fonctionnement des autres interlocuteurs afin d'éviter de rentrer dans leur jeu.
- S'entraîner à repérer ces jeux de postures dans tous les types de conflits, qu'ils soient ouverts ou larvés, ou qu'il s'agisse d'actes manqués.
- Trouver des méthodes pour évoluer de **Sauveur** à **Aidant**, de **Persécuteur** à **Protecteur** ou de **Victime** vers **Puissant**.

Passer de Sauveur à Aidant

- **Le sauveur** devance et anticipe les demandes des autres. Pour devenir **Aidant**, il lui faut vérifier qu'il a une légitimité d'intervention ou que la victime a explicitement sollicité de l'aide.
- Maintenir un équilibre entre donner et recevoir dans la relation d'aide. Le sauveur doit se respecter, ne pas s'oublier. Il procure l'aide cette fois mais peut en bénéficier dans une autre situation.
- Dans le mode d'intervention, il doit accompagner la victime vers l'autonomie afin de ne pas la maintenir dans une situation de dépendance (expliquer, accompagner, donner des clés, des ressources).

Passer de Persécuteur à Protecteur

- **Le Persécuteur** peut être autoritaire, cinglant, critique, cruel et éventuellement violent verbalement ou physiquement. Parfois il peut prendre des allures de protecteur. Il semble alors laisser de l'autonomie, confier des missions. Il fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Sa principale technique est l'intimidation. Il fait peur, on hésite à le contrarier.
- **Le Protecteur** donne du sens à ses attentes, les explique clairement et précisément. Il fixe des priorités en guidant. Il respecte la différence : une autre vision du monde peut avoir autant de valeur que la sienne. Le protecteur donne des occasions de réussite.

Passer de Victime à Puissant

La Victime est souvent passive et malheureuse. Elle rend les autres responsables de ses malheurs. Formuler clairement la demande de soutien, être proactif (anticiper ou parer les problèmes) et apprendre à se respecter permet de passer à un statut **Puissant** et responsable.

SOI : Prise de conscience - autonomie - responsabilité

Nous n'avons pas de pouvoir sur les autres : il faut arrêter de vouloir changer ce qui ne peut pas l'être.

Ce cours aborde ce sur quoi nous pouvons travailler, ce qu'on peut faire évoluer : nous-mêmes.

- Identifier quels aspects du MOI sont les plus développés, et comprendre leurs origines.
- Comprendre les scénarios de vie prédéfinis et vérifier qu'ils le sont de manière constructive.
- Apprendre à repérer les jeux psychologiques afin de ne plus y entrer.
- Renoncer aux stratégies inefficaces. Les stratégies mises en œuvre n'apportent pas le résultat recherché. Il convient d'explorer d'autres façons de procéder, d'autres manières de se comporter.
- Développer **son autonomie** en prenant conscience des mécanismes qu'on met en œuvre et qui amènent à vivre ce que l'on vit (passivité face aux scénarios de vie perdants par exemple). Devenir proactif, se positionner en adulte autonome.
- Prendre pleinement **ses responsabilités** : assumer ses choix. Prendre ses décisions en fonction de ses propres critères et non en fonction des autres : pas de « je n'y peux rien », « ce n'est pas ma faute ». Mais « qu'est-ce que je fais pour en arriver là » et « que puis-je faire pour changer les choses ».

Après une première phase d'analyse et de compréhension de ce qui le fait réagir, il est important que l'apprenant prenne conscience de l'effet qu'il produit sur les autres, par son comportement et son attitude.

Il est important d'être conscient que, dans une relation de communication entre deux personnes ou au sein d'un groupe, la responsabilité est **partagée** et que nos propres attitudes et réactions induisent les réponses de l'autre.

On en arrive à la notion d'interdépendance et de **respect** : tenir compte de l'autre car l'autre a autant le droit que moi d'exister.

« Je dépends en partie de l'autre et l'autre dépend en partie de moi », du moins en ce qui concerne l'échange que nous avons dans l'instant. « L'autre a ses raisons qui ne sont pas les miennes mais qui sont respectables ».



« Prendre conscience de ce que vit l'autre et ne plus être centré uniquement sur ce que moi je vis. ». Seulement après cette prise de conscience, nous pourrions aborder la notion de communication et d'échange avec l'autre dans une vraie relation d'empathie.

Comment progresser en communication ?

Bien connaître et analyser notre propre personnalité, s'entraîner à analyser nos propres réactions, puis s'entraîner à comprendre les réactions des autres.

Quand on comprend, on sait comment réagir, comment communiquer, apaiser, désamorcer un conflit...



Image de soi : façon dont nous croyons que les autres nous voient. Prendre objectivement conscience de l'impression que nous donnons aux autres.



La singularité : Chacun parle en fonction de qui il est.

La maîtrise des situations de communication dépend tout autant d'un savoir-faire (technique) que d'un « savoir-être » (aisance et confiance en soi). Chacun de ces points peut s'améliorer grâce à un entraînement régulier, un travail sur soi, une maîtrise des pratiques professionnelles et de son environnement professionnel.

SITUATIONS DE COMMUNICATION ALTEREE

Gériatrie

Cf. Référence APHP - Certification interne des compétences « Relation de soin en situation de communication altérée »

Dans de nombreuses pathologies, la communication verbale peut être altérée, qualitativement ou quantitativement et même devenir impossible. En effet, pour que la communication verbale puisse avoir lieu, des étapes sont nécessaires : élaboration d'un langage cohérent au niveau cérébral (aires du langage), production au niveau oral. Les pathologies qui vont toucher, soit les commandes motrices, zones cérébrales du langage et cortex frontal, soit l'appareil phonique, cordes vocales et oropharynx, vont entraver la possibilité du patient de communiquer.

Prodiguer les soins nécessaires au patient en créant une occasion de communication

Expliquer chaque soin au patient

- Vérifier le niveau de compréhension du patient de sa situation et de son devenir
- Détailler et expliquer chaque geste, en prévenant le patient
- Au besoin, anticiper sur le soin suivant pour ne pas le prendre de court
- Lui parler, même s'il ne semble pas en état de comprendre
- Utiliser une stratégie de diversion (poser une question qui oblige à se représenter mentalement une image, utiliser l'humour...) pour accompagner un soin douloureux

Utiliser des gestes signifiants pour le patient

- Donner des consignes simples, en les accompagnant d'un geste (souligner le discours par le geste).
Exemple : « venez par ici, s'il vous plaît. »

Respecter le rituel du patient

- Favoriser l'initiative, l'autonomie et stimuler le patient.
- Associer le patient à la toilette ou au soin.
- L'inciter à faire seul.
- Lui faire choisir sa tenue vestimentaire

Analyser les signaux non verbaux

- Prendre le temps d'observer le patient pour comprendre les signaux non-verbaux.
- Analyser les mimiques faciales, le sourire le regard, les changements de tonicité musculaire, les modifications de posture.

Interpréter la signification d'un mot ou d'une vocalisation

- Décoder les différents sens que peut avoir un même mot, employé dans des situations variées (problème de l'aphasie).
- Interpréter les différentes significations d'un cri ou d'un pleur.

Utiliser les canaux de communication les plus adaptés

- Utiliser des aides visuelles dont le mime.
- Utiliser des phrases simples.
- Utiliser des phrases-types écrites en phonétique pour communiquer avec un patient étranger.
- Choisir un thème facilitant l'échange (l'ancien métier, un événement particulier, les voyages, la musique).
- Evoquer des sujets d'actualité, des événements récents, ou des activités communes.

Utiliser la communication tactile

- Utiliser un geste apaisant pour calmer le patient / résident
- Accepter ou donner un geste de tendresse, sans franchir les limites de l'équivoque.

Désamorcer une situation d'agressivité ou de défense

- Eviter les gestes brusques, ou les mouvements trop rapides
- Limiter les possibilités de geste agressif du patient, sans l'immobiliser (contenir le bras dans sa main en U plutôt que de le maintenir)
- Détourner l'attention du patient.
- Se mettre à hauteur du patient.
- Bien sentir le moment où il est important de se mettre en sécurité.

Le patient atteint d'Alzheimer

- Préparer l'**environnement** : écarter les distractions.
- Obtenir l'**attention**.
- Etablir un **contact** visuel, en se plaçant au même niveau.
- Toucher le bras ou la main de la personne avec douceur.
- **Parler clairement**, faire des phrases courtes, mentionner une idée à la fois.
- Surveiller le non verbal. Réagir aux **émotions**.
- Répéter avec les mêmes mots.
- Laisser le temps à la personne de comprendre et de répondre.
- **Poser des questions fermées** auxquelles il peut répondre par oui/non/ peut-être / je ne sais pas.
« Aimeriez-vous regarder la télévision ? Voulez-vous un café ? »
Adaptez vos questions aux capacités du patient, éviter les questions ouvertes qui demandent une réponse explicative : « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Voulez-vous quelque chose à boire ? »
- **Parler du passé**, d'expériences heureuses. Utiliser des points de repère (photos, de la musique).
- Utilisez des **indices visuels**.

En cas d'incompréhension

- ▶ Montrer que l'on reconnaît les faits : « Je comprends que c'est frustrant pour Vous. »
- ▶ Rassurer la personne, toucher son bras, exprimer de l'empathie.
- ▶ Utiliser la **diversion** (changer de sujet, de pièce ou d'activité, faire passer le temps avec quelque chose que le patient aime).
- ▶ Utiliser la **validation** (valider les sentiments, répéter la phrase et vérifier sa compréhension, rassurer, vérifier les sentiments exprimés).

La crise suicidaire

Définir la crise suicidaire

Un « suicidaire » est un individu qui, par son comportement ou ses dires, exprime une velléité suicidaire. Ce concept doit être bien distingué de ceux de "suicidant" (personne qui a commis une tentative de suicide) et de "suicidé" (personne qui s'est donnée la mort). La crise suicidaire marque un moment de déséquilibre, de vulnérabilité et de grande souffrance chez un patient.

Avoir des pensées liées à la mort signifie rarement une réelle envie de mourir. Il s'agit, dans la grande majorité des cas, d'une recherche de solution. Les difficultés sont ressenties durement, avec un sentiment d'emprisonnement. La recherche de la mort est plus à comprendre comme la recherche d'une solution, qui jusque-là semble faire défaut.

Prodromes suicidaires

- Expression d'idées et d'intentions suicidaires directes (« je veux mourir ») ou indirectes (« je n'en peux plus, je voudrais partir, fermer les yeux et que tout s'arrête »).
- Manifestations de crise psychique : fatigue, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, sentiment d'échec, d'inutilité, expression tournée vers l'autodépréciation... Sont autant de signes cliniques qu'il faut repérer.
- Contexte de vulnérabilité

De façon générale, des changements d'attitude, de comportement, d'activité constituent autant de signes qui peuvent précipiter le patient dans une situation de « crise suicidaire ». Les situations de repli, avec l'expression d'un certain désespoir, d'un cynisme et d'une perte des valeurs sont à haut risque. De façon générale, toute verbalisation de pensée suicidaire est à prendre au sérieux, même si le soignant ne note pas un accent de sincérité et pense à une tentative de manipulation. Dans tous les cas, ce type de verbalisation n'est pas anodin et dénote une grande souffrance psychique.

Communiquer avec le patient suicidaire

Ne jamais banaliser un signe ou une parole pouvant faire penser à une « crise suicidaire ».

Tenter de dissuader un patient de se suicider ne sert à rien : il s'agit de la partie émergée de l'iceberg, la partie immergée est la souffrance qu'il ressent dans une situation perçue comme insurmontable, quel qu'en soit le motif (deuil, douleur chronique ingérable, impression de ne jamais pouvoir sortir de son sentiment de détresse...). Les techniques de communication consistent, dans un 1^{er} temps, à questionner le patient, à tenter de comprendre la situation qui le fait souffrir. Le relationnel doit être le plus empathique possible. Enfin, il s'agit d'amener le patient à envisager des solutions inédites pour lui.

Les patients psychiatriques engagent un mode relationnel particulier, qui nécessite plus de prudence que pour toute autre pathologie. Les pratiques d'empathie ou de congruence sont difficiles à obtenir dans un 1^{er} temps. Il est préférable de miser sur des techniques de communication simples, non impliquantes afin, dans un 2nd temps, de passer à un mode relationnel plus personnel. Pour autant, un climat de confiance avec des repères bien visibles doit toujours être établi. Les modalités de communication doivent être souples et adaptées à des patients aux processus psychiques rigides et inadaptés.

- ▶ Ne pas laisser la personne confrontée à l'agressivité éventuelle et/ou au rejet de l'entourage, qui peut entraver la verbalisation du mal-être
- ▶ Ne pas tomber dans le piège de la banalisation, voire du déni, tant du côté du suicidant que du côté de sa famille. Ne pas faire comme si le suicide (ou son intention) n'avait pas existé, puisqu'il n'a pas réussi (ou n'est pas encore réalisé), donnant ainsi au suicidant l'impression de ne pas être entendu ni reconnu dans son acte.

- ▶ Ne pas avoir une attitude d'évitement de toute verbalisation concernant la tentative de suicide elle-même. Donner l'impression de ne pas vouloir aborder le sujet pourrait être mal perçue par le suicidant.
- ▶ Ne pas se laisser aller à des prises de positions moralisantes, en s'identifiant aux parents par exemple. L'ambulancier doit rester à sa place, il peut au mieux conseiller mais pas moraliser.
- ▶ Ne pas se laisser prendre au piège de la provocation et du rejet, ce que cherche souvent à induire un jeune qui éprouve des sentiments de honte, de culpabilité, d'infériorité, d'indignité ou de dépression. L'ambulancier n'est pas un exutoire. L'ambulancier n'est pas là non plus pour recevoir l'agressivité qui ne lui est pas destinée.
- ▶ Ne pas établir une alliance « totale », trop proche du suicidant, au point de ne plus pouvoir évaluer objectivement les éléments orientant vers une nouvelle pathologie ou permettant d'apprécier le risque de récurrence. L'ambulancier n'est pas un copain.
- ▶ Ne pas compromettre une alliance fragile construite avec le suicidant, en livrant par exemple aux parents le contenu de l'entretien avec le jeune sans lui préserver un espace de confidentialité ou sans lui avoir demandé la permission de le faire. Ou sans l'avoir averti que l'on était obligé, dans certaines circonstances, d'en parler. L'ambulancier est tenu au secret professionnel, quand bien même ce qu'il détient provient d'un mineur.

Une fois le contact établi, l'ambulancier doit évaluer la potentialité du passage à l'acte et du degré d'urgence à intervenir qui peut en découler. Pour cela, 6 items sont à explorer lors du bilan.

1° Le niveau de souffrance

- Désarroi ou désespoir
- Repli sur soi, isolement relationnel
- Sentiment de dévalorisation ou d'impuissance
- Sentiment de culpabilité

2° Le degré d'intentionnalité

- Idées envahissantes, rumination (tenir compte des messages verbaux et non verbaux)
- Recherche ou non d'aide, attitude par rapport à des propositions de soins

3° Les éléments d'impulsivité

- Tension psychique, instabilité comportementale
- Agitation motrice (liée éventuellement à la prise d'alcool ou de toxiques), état de panique
- Antécédent de passage à l'acte, de fugue ou d'actes violents

4° Un éventuel élément précipitant

Conflit, échec, rupture, perte...

5° La présence de moyens létaux à disposition

Evaluer s'il s'agit de moyens mortels à coup sûr (armes), s'ils sont accessibles ou disponibles (médicaments)

6° La qualité du soutien de l'entourage proche

Capacité de soutien ou inversement, renforcement du risque dans le cas de familles « au climat malsain, ambigu », qui suscite un sentiment de mal-être palpable, pouvant être préjudiciable au suicidant.

LA PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE

Les compétences de l'enfant : les Stades de développement cognitif

Le stade sensorimoteur : naissance à 2 ans

L'enfant utilise ses sens et ses capacités motrices pour explorer l'environnement et se développer cognitivement.

Des réflexes à l'intentionnalité : naissance à 9 mois

Durant les neuf premiers mois de sa vie, le bébé va exercer les réflexes innés dont il dispose (suction, préhension). Il va tenter de prendre contrôle de ses activités réflexes, notamment grâce à des mouvements stéréotypés et répétitifs (ouvrir - fermer la main). Il va observer qu'une même action provoque une même conséquence.

De l'intentionnalité à la représentation : 9 mois à 24 mois

Les mouvements deviennent coordonnés et de plus en plus complexes. Les actions prennent un caractère « intentionnel » (soulever le drap qui cache le jouet). L'enfant découvre de nouvelles façons d'atteindre ses buts (tirer la nappe pour avoir son jouet). A la fin de ce stade, l'enfant dispose d'un système de représentation, il arrive à se souvenir mentalement des séquences d'action ou de résolution de problèmes. Il arrive à reproduire un comportement observé auparavant (imitation reportée).

Parmi ses principales limites :

Un enfant à ce stade n'a pas la conscience de la permanence de l'objet. Il n'a pas la compréhension que les objets continuent d'exister même lorsqu'on ne peut plus les voir, les entendre ou les sentir. [Le stade préopératoire : 2 à 7 ans : Maîtrise du langage et acquisition de la pensée symbolique.](#)

La pensée symbolique : 2 à 4 ans

Les débuts de la communication verbale permettent la venue des raisonnements symboliques : autrement dit la possibilité de se représenter un objet ou une action sans que celui-ci soit présent, grâce au langage.

Apparition du jeu symbolique (« faire semblant », jeu imaginaire), du dessin et de l'image mentale.

La pensée préopératoire : 4 à 7 ans

La parole devient plus sociale. L'enfant acquiert intuitivement certains des concepts logiques. Cependant, il toujours tendance à concentrer son attention sur un aspect d'un objet tout en ignorant les autres. Les concepts formés sont bruts et irréversibles.

Parmi les limites de ce stade :

L'incapacité de l'enfant à effectuer des « opérations réversibles ou de conservation ». Persistance d'une pensée égocentrique (incapacité de tenir compte du point de vue de l'autre) et d'une pensée animiste (croyance que tous les objets sont vivants).

Le langage

- ▶ Les enfants « comprennent » le langage verbal avant de pouvoir s'en servir eux-mêmes.

Avant que l'enfant ne prononce ses premiers mots, il émet une série de cris et de sons. C'est d'ailleurs en criant que qu'il a fait son entrée dans le monde.

- ▶ Après le 1^{er} mois, les cris se différencient en fonction de leurs causes. Les parents proches de leur enfant commencent à différencier les pleurs et les cris (la faim, les coliques, le sommeil, l'angoisse...).

- ▶ Stade pré-linguistique, de 0 à 1 ans

Vers 6 semaines, l'enfant émet ce que l'on appelle des roucoulements (gargouillements, cris aigus), véritable expression orale de ses besoins et de ses émotions.

► Vers 3-4 mois

Gazouillis et babillages se font entendre, il « parle » (émissions vocales nombreuses). Il commence à avoir des sons préférés qu'il lui arrive de répéter (la-la-la...ma-ma-ma...bi-bi-bi...). On appelle ce phénomène la « lallation ».

► Entre 9-10 mois, l'enfant semble imiter les sons produits par les autres même s'il ne les comprend pas. « L'écholalie » est donc une sorte de dialogue entre l'enfant et les parents.

► Stade linguistique, à partir de 1 an

L'enfant commence à faire des mots-phrases : il prononce un mot, équivalent pour lui à une phrase.

Exemples : [mia = donne-moi ça] [da = fais ça à nouveau] [ah = c'est beau]

Vers 18 mois, au mot-phrase succède la pré-phrase, c'est-à-dire 2 ou plusieurs mots alignés selon l'importance affective que leur donne l'enfant (sorte de langage télégraphique).

Exemples : « A-pu bonbon » (il n'y a plus de bonbon). Moi pa-ti (Je veux partir).

A la période de la pré-phrase, l'enfant entre dans le premier âge questionneur où la question du type « Ça c'est quoi ? » correspond à un besoin d'extension de son vocabulaire.

L'accès au langage se poursuit à partir de 2 ans 1/2- 3 ans.

Cette évolution s'observe notamment dans l'intérêt croissant que l'enfant porte à la parole de l'adulte, son goût pour les histoires qu'on lui raconte, la découverte du dialogue avec l'adulte, l'utilisation pertinente de questions "où ? quand ? comment ? pourquoi ?" exprimant son intense désir de connaître. Vers 2 ans 1/2- 3 ans, le « pourquoi ? » exprime une protestation à une contrainte : « mange ta soupe ! » « Pourquoi ? ». A 3 ans, époque du 2^{ème} âge questionneur (1^{er} vers 18 mois), le pourquoi signifie « à quoi cela sert-il ? ». C'est donc entre deux et trois ans que l'enrichissement du vocabulaire est le plus important. En moyenne, le nombre de mots passe de 100-200 à 2 ans à 1000-1200 mots à 3 ans.

L'enfant entend le langage parlé par les personnes de son entourage de manière globale. Il en résulte parfois de nombreuses déformations (date pour regarde/ yateau pour bateau/ apapé pour attraper...). Ces déformations disparaissent tout naturellement entre 4 et 7 ans, pour autant que les adultes ne se mettent pas à « parler bébé ».

Le temps

L'enfant de 2 ans n'a conscience que du temps immédiat, les longues durées ne lui disent rien. Quand la mère part après avoir amené son enfant à la crèche et que ce dernier pleure, c'est que pour lui toute séparation avec sa mère est une séparation définitive. Si on lui dit « tu verras ta maman ce soir », cette affirmation ne le rassure guère, car « ce soir » est pour lui une échéance indéfinie.

L'enfant de 3 ans sait ce que veut dire « avant » et « après », mais pas ce que signifie « hier » ou « demain ».

Vers l'âge de 5 ans, l'enfant comprend que le temps s'écoule en phases successives qui aboutissent à des changements d'état : le jour, la nuit, la semaine, le mois, l'année. Cependant, sa perception du temps est différente de celle de l'adulte. Elle n'est pas linéaire, mais plutôt organisée autour de points de référence significatifs associés à un événement : congé d'école, Noël, Pâques, anniversaire, visite d'une personne.

L'espace

La prise de conscience progressive de l'espace, se fait en parallèle de l'assimilation de la notion de « temps ».

L'enfant de 4 ans perçoit l'espace immédiat : il est capable depuis longtemps de mémoriser les itinéraires dans un espace familier, comme la maison, l'école. Mais il ne saisit pas les distances.

A 5 ans l'enfant peut situer : gauche/ droite, devant/ derrière, en haut/ en bas.

Le stade des opérations concrètes : de 7 à 11-12 ans

A ce stade, on observe d'importantes habiletés intellectuelles. L'enfant est désormais capable d'appliquer des opérations aux objets concrets.

Acquisition de deux concepts importants

- La réversibilité : capacité à pouvoir renverser l'effet d'une action ou d'une opération mentale.
Exemple : transvaser de l'eau d'un verre à l'autre et vice versa.
- La conservation : capacité de reconnaître qu'une quantité, un poids ou un volume donné demeure constant malgré un changement de forme, de longueur ou de position.

Communication avec l'enfant

Savoir communiquer est une compétence indispensable : Le postulat est que l'aptitude à la communication n'est pas innée (ceux qui savent communiquer et ceux qui ne savent pas), mais qu'elle s'acquiert grâce à des techniques, de la réflexion et de la formation. Ce cours aborde l'enfant au travers des particularités de ses besoins en communication.

- Pourquoi parler à l'enfant ?
- Que comprennent les enfants ?
- Informer : une obligation
- Comment se comporter avec l'enfant ?
- Comment communiquer avec les parents ?
- Comment évaluer la douleur d'un enfant ?
- Le rôle du jeu ?

Pourquoi parler à l'enfant ?

La connaissance partagée

Les enfants pensent généralement que leurs parents et ceux qui les soignent perçoivent ce qu'ils ressentent.

La communication permet :

- De faire comprendre à l'enfant que l'on n'est pas dans son corps et qu'il n'y a que lui qui peut dire où il a mal et avec quelle intensité.
- D'établir une relation de confiance avec lui
 - ▶ Parler à un enfant, même nouveau-né.

Plus l'enfant est jeune, plus la douleur est pour lui une agression incompréhensible. Parler à un nouveau-né permet d'être en relation avec lui.

S'occuper d'un enfant douloureux ou lors d'un soin nécessite cependant cohérence et prudence :

- ▶ Voix calme et douce,
- ▶ Gestes lents et doux, mains accueillantes.

Plus l'enfant est algique, plus il faut l'aborder avec lenteur.

Répondre aux besoins relationnels de l'enfant : rassurer et expliquer

Quel que soit son âge, l'enfant est dépendant de ses parents et des soignants qui s'occupent de lui. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'explications.

Il peut être d'autant plus impressionné devant une tenue professionnelle, une ambulance, des intervenants

multiples qui lui sont étrangers. La relation va s'établir doucement. Le premier contact doit être doux, patient et chaleureux. Se présenter par son prénom, expliquer qui on est, le pourquoi on est là. Comme pour toute situation de communication, il faut se mettre à la hauteur de l'enfant. Le tutoiement permet de ne pas ajouter de distance verbale. Il est propice à la création du lien.

S'intéresser à ses objets familiers son doudou, sa poupée ou son héros préféré peut contribuer à détendre l'atmosphère.

- ▶ Favoriser son expression verbale par des questions précises,
- ▶ Prendre le temps de l'écouter,
- ▶ L'informer sur ce qui se passe et/ou sur ce qui va se passer,
- ▶ Ensuite seulement réaliser le soin ou le transport.
- ▶ Détendre l'atmosphère en s'intéressant à l'univers de l'enfant, lui parler de ce qui lui est familier va lui permettre de garder des repères et contribuer à le rassurer.

Parler à l'enfant favorise la relation au cours des soins ou du transport. Lors d'un geste technique, le risque est de s'enfermer dans une approche uniquement opérationnelle et de laisser de côté l'aspect relationnel du soin.

Que comprennent les enfants ?

Communiquer avec l'enfant permet d'allier, au cours du soin, aspects techniques et prise en charge relationnelle.

Attention : un enfant « affolé » et douloureux perd ses capacités de compréhension.

L'enfant, de 0 à 1 an

A la naissance, la dimension de la tête est proportionnellement beaucoup plus grande que la taille du corps.

Le tonus musculaire du bébé est différent de celui de l'adulte : hypertonicité des muscles fléchisseurs avec absence d'inhibition de la contraction musculaire (exemple : le réflexe de la marche).

Le nourrisson présente une hypotonie axiale : il ne peut pas se tenir assis.

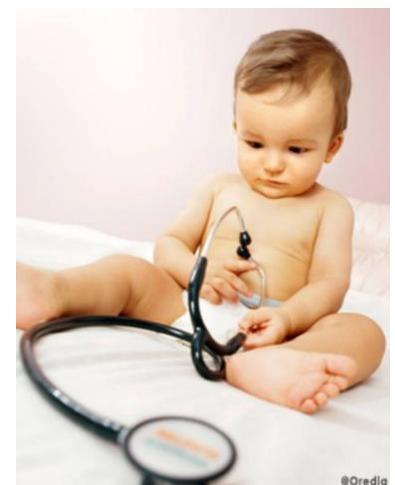
Le bébé possède dès sa naissance un riche héritage fœtal qui structure son fonctionnement.

On y retrouve l'ensemble des réflexes archaïques, dont certains qui ont une fonction adaptative essentielle comme la succion et la déglutition.

Le nourrisson possède les récepteurs et les systèmes de transmission de la douleur. Mais ses mécanismes physiologiques de contrôle de la douleur sont immatures et ses fonctions cognitives sont insuffisantes pour lui permettre d'analyser la douleur. Il est donc très démuni face à la douleur. Malgré et à cause de ces « insuffisances », communiquer avec lui est primordial.

Même si le nouveau-né ne parle pas, il est très important de lui parler, il est en effet sensible aux intonations de la voix, au rythme des mots, à une mélodie...

Privilégier la communication non verbale (le toucher, le regard). Une posture enveloppante, maternante, un retour vers la position fœtale ont un effet apaisant.



L'enfant de 1 à 3 ans

- Acquiert un répertoire de 150 mots.



- Commence à désigner où il a mal.
- N'a pas la notion du temps.
- Ne sait pas se projeter dans l'avenir.
- Ne comprend qu'une consigne à la fois.

L'enfant entre 3 et 6 ans

- Acquiert un répertoire de 1 500 mots.
- Peut se plaindre spontanément mais a besoin d'aide pour décrire sa douleur.
- N'a pas la notion du temps.
- Est centré sur son point de vue, ne peut envisager le point de vue des autres.
- Attribue la cause de sa douleur à des personnes ou des événements extérieurs objectivables.
- La douleur est souvent vécue comme une punition.
- A des peurs diffuses et importantes même pour des petites blessures.
- A besoin d'être rassuré sur son intégrité corporelle en cas d'effraction de son corps.
Exemple : il pense qu'une piqûre peut endommager son corps.
- A besoin qu'on lui explique la notion de cicatrisation.

L'enfant entre 6 et 12 ans

- Peut décrire sa douleur.
- Acquiert la notion du temps.
- Peut faire le lien entre la douleur et sa cause.
- Est à l'âge des acquisitions de connaissances : il aime les explications.

L'adolescent

Sa compréhension peut être similaire à celle d'un adulte. Il faut par conséquent respecter son droit à l'information sans l'infantiliser mais en s'assurant de sa compréhension.

L'adolescent vit des transformations corporelles et acquiert son autonomie, ce qui pour lui est parfois difficile à vivre et assumer. Le rapport au corps est donc particulier et les gestes tactiles de communication sont à effectuer à bon escient, lorsqu'une bonne communication est établie et sans aucune possibilité d'ambiguïté, particulièrement en cas de sexe opposé à celui du professionnel. Il faut pour ces mêmes raisons éviter d'être seul, sans témoin, avec l'enfant ou l'adolescent.

L'adolescent a besoin de conformisme. Il éprouve souvent un sentiment d'injustice ou entre en rébellion. Trouver ce qui lui tient à cœur peut être une porte d'entrée vers la communication et un réel échange.

Informé : une obligation

- ▶ L'information est un droit du malade. Nous sommes dans l'obligation légale de délivrer une information simple, accessible, intelligible, loyale, appropriée à nos patients sans distinction d'âge.
- ▶ **Art. 35 du code de déontologie médicale** (décret 95-1000 du 6 sept. 1995) :
 - « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
- ▶ Le code de déontologie précise également que : « le médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou leur substitut et d'obtenir leur consentement. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli (...), le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible. »
- ▶ **La charte de l'enfant hospitalisé** précise : « les enfants doivent être informés des actes et examens nécessaires à leur état de santé en fonction de leur âge et de leur faculté de compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable information de leurs représentants légaux. »
- ▶ La circulaire de la DGS du 23/11/98, relative au régime de visite des enfants hospitalisés en pédiatrie, précise que « le consentement de l'enfant hospitalisé, lorsqu'il peut l'exprimer, doit être recherché pour tous les examens et actes médicaux pratiqués. »
- ▶ Le plan triennal d'action contre la douleur (circulaire DGS du 22/09/98) demande que soit délivré à tout patient entrant à l'hôpital un « carnet douleur » qui doit être remis avec le livret d'accueil dès l'arrivée. L'objectif est d'informer des possibilités de prise en charge de la douleur.
Une version pédiatrique est disponible.

Comment se comporter avec l'enfant ?

Établir une relation de confiance avec l'enfant

- Se présenter à l'enfant. Expliquer qui on est et pourquoi on est là.
- Favoriser son expression :
- Poser des questions précises et lui laisser le temps de répondre.
- Se mettre à son niveau.
- Parler de lui, de ce qu'il aime faire.
- Observer l'enfant.
- S'il ne parle pas, solliciter d'autres moyens d'expression et observer son comportement.

Recueillir les informations concernant l'enfant

- Signifier à l'enfant que l'on sait qu'il a mal et que l'on a besoin de son aide pour mieux comprendre ce qu'il ressent.
- S'enquérir du passé douloureux de l'enfant et de ses propres moyens pour soulager la douleur.
« Que veux-tu qu'on fasse pour toi quand tu as mal ? »
- S'enquérir de son environnement social et familial dont les perturbations peuvent influencer la perception de la douleur.

Obtenir sa participation

- Expliquer ce qu'on va lui faire.
- Obtenir sa participation : ne pas lui demander son accord lorsqu'il n'a pas le choix mais lui laisser une marge de négociation.
Exemple : "Veux-tu rester debout ou assis ?"
Faire préciser ce qu'il a compris.

Comment examiner un enfant algique

L'examen clinique d'un enfant douloureux requiert de la patience et beaucoup de précaution. Il faut établir une relation de confiance, un climat de respect, de « reconnaissance » mutuelle et d'acceptation de l'autre. S'aider d'un jouet attractif permet d'instaurer une relation peu médicalisée, moins anxiogène.

L'observation du petit enfant est facilitée lorsqu'il se trouve dans les bras d'un des parents. Proposer un jeu (type ballon) interactif ou une comptine qui mobilise tout le corps (par exemple « Bateau sur l'eau », en faisant participer le parent). Le jeu permet d'observer son intérêt, ses réactions, ses plaintes, ses grimaces, ses facultés de communication, ses possibilités de bouger, les postures antalgiques, les raideurs et les signes d'atonie psychomotrice.

L'examen clinique du petit enfant peut être réalisé dans les bras du parent.

Tout en parlant à l'enfant, l'examiner plan par plan :

- ▶ Débuter en effleurant le corps avec un jouet en peluche.
- ▶ Palper ensuite progressivement la peau, les tissus sous-cutanés, les muscles, les os, les articulations, les viscères, en veillant à observer le visage de l'enfant, ses réactions et ses mimiques (plaintes, raideurs, grimaces, blocages respiratoires).

Les phrases à ne pas dire

On ne se rend pas toujours compte de la portée de certaines de nos phrases.

- Ne pas mentir. Eviter de dire :
« C'est juste une petite piqûre », « C'est juste une piqûre de moustique », « Ça ne fait pas mal, c'est fini »
▶ Dire plutôt : « malgré la crème anesthésiante, il est possible que tu aies un peu mal, dis-le-moi »

- Ne pas banaliser ni dramatiser
- Ne pas encourager les attitudes héroïques. Eviter de dire :
« Chut ! Tais-toi », « Sois sage », « Soit gentil », « Sois courageux, tu es grand, tu es un homme »,
▶ Dire plutôt : « Tu as le droit de pleurer, même si tu es grand »
- Ne pas menacer. Eviter :
« Tu étais sage quand maman n'était pas là », « Si tu pleures, je fais sortir ta mère »,
« Il fait marcher sa mère »
▶ Dire plutôt "Ne t'inquiète pas, maman reste là"

Le déroulement d'un geste douloureux

L'approche de l'enfant doit être progressive et lente, en diminuant au maximum les sources d'anxiété.

Eviter au maximum les moyens de contention qui augmentent l'agitation de l'enfant et entraînent le plus souvent une escalade thérapeutique.

Favoriser le confort. Selon les contraintes du soin et l'âge de l'enfant, opter pour la position choisie par l'enfant lui-même.

Respecter les stratégies d'adaptation de l'enfant face à la douleur :

- Certains enfants seront demandeurs d'informations, d'autres non.
- Certains enfants voudront participer au geste, s'impliquer dans ce qui se passe.
- D'autres préféreront se distraire et ne pas penser à ce qui se passe.
- D'autres enfin auront besoin de se concentrer sur le geste.
- Favoriser la présence des parents.

Les points clés

Pour établir une relation de confiance, il faut toujours :

- Se présenter à l'enfant.
- S'intéresser à sa perception des événements.
- Lui faire comprendre que l'on prend en compte sa douleur.
- L'informer, parler vrai.
- Favoriser sa participation aux soins.
- Les paroles doivent être justes et sans jugement de valeur.

Evaluer la douleur

Tous les enfants ne réagissent pas de la même manière face à la douleur. Pour traiter la douleur, il faut d'abord l'évaluer. Grâce à l'évaluation, on peut vérifier l'efficacité des traitements. Les enfants ne savent pas toujours dire « où », décrire « comment » et « combien » ils ont mal. Selon l'âge de l'enfant et ses capacités à communiquer, on utilise différentes méthodes.

L'échelle verbale simple (EVS)

On demande à l'enfant de dire s'il a mal « un peu », « moyen », « beaucoup » ou « très fort ».

- ▶ Utilisable à partir de 3 ou 4 ans

La réglette des visages

6 visages représentent 6 intensités de douleur.

On demande à l'enfant de montrer le visage qui a mal comme lui.

- ▶ Utilisable à partir de 4 ans

L'échelle visuelle analogique (EVA)

Cette réglette comprend un curseur que l'enfant doit placer « aussi haut que sa douleur est grande ».

► Utilisable à partir de 6 ans

L'échelle numérique (EN)

On demande à l'enfant de donner une note à sa douleur, entre 0 et 10.

► Utilisable à partir de 8 ans

Le « dessin du bonhomme »

Cette méthode aide l'enfant à préciser où il a mal. Il choisit **4 couleurs** pour désigner 4 intensités de douleur (légère, moyenne, forte, très forte) puis il colorie l'endroit où il a mal sur **2 schémas** qui représentent un corps vu de face et de dos.

Prévenir la douleur

L'enfant ressentira moins la douleur s'il est bien entouré, s'il a confiance et s'il comprend ce qui se passe : quand on a moins peur, on a moins mal.

Dans tous les cas, il est important de faire part à l'enfant de la décision médicale et de lui expliquer le déroulement des soins afin de favoriser sa participation. Lui permettre, par exemple, d'enlever lui-même un pansement, de tenir le masque...

Le rôle des parents est essentiel. Ce sont eux qui connaissent le mieux l'enfant, son comportement habituel et la façon dont il exprime la douleur. Leur présence à côté de lui, en particulier lors des soins douloureux, est un soutien pour l'enfant surtout lorsqu'il est petit. Ils peuvent le rassurer, le distraire, l'encourager, le consoler.

Les freins à l'évaluation de la douleur

Plus l'enfant est jeune, moins il comprend pourquoi il a mal ou pourquoi « on lui fait mal, pour le soigner ». Tous les enfants ressentent la douleur, même les nouveau-nés et les bébés.

Dire que l'on a mal n'est pas un signe de faiblesse. Certains enfants n'osent exprimer leur douleur, pour ne pas inquiéter leurs parents, par peur d'avoir une piqûre ou de rester à l'hôpital.

Pourquoi distraire l'enfant pendant un soin ?

La perception de la douleur, provoquée lors d'un soin, d'un examen ou d'une chirurgie, est largement influencée par le contexte dans lequel un enfant est placé.

Même un soin ou un examen considéré comme a priori non douloureux (examen radiologique, examen des oreilles ou de la gorge...), peut devenir problématique si l'enfant est très anxieux.

Peur et douleur sont intimement liées et, pour soulager un enfant, les moyens médicamenteux ne suffisent pas toujours. Il faut agir, non seulement sur la **composante sensorielle** (médicaments, anesthésie...), mais aussi sur la **composante émotionnelle** (anxiété, peur) et **cognitive** (souvenirs d'expériences antérieures, compréhension de la raison du geste) de la douleur.

La distraction est un moyen non pharmacologique de lutte contre la douleur, dont l'efficacité est scientifiquement prouvée, en complément des moyens pharmacologiques. On parle d'un « co-analgésique ».

Prévenir la douleur chez l'enfant est un enjeu à court et long terme.

Cette approche complémentaire est nécessaire à double titre :

- Pour s'assurer que les premiers soins se passent bien, pour éviter des phobies ultérieures.
- Pour rassurer les enfants inquiets ou refusant des soins, pour conserver ou renouer avec leur confiance.

De la même manière qu'une équipe prévoit l'utilisation de moyens médicamenteux adaptés au type de soin (crème anesthésiante, antalgique, solutions sucrées, MEOPA, anesthésie locale), elle peut prévoir à l'avance et de façon systématique un moyen de distraction.

Seule une systématisation, qui concrétise la « philosophie » du soin garantit que tous les enfants pourront en bénéficier, que le soin soit long ou court, exceptionnel ou répétitif, programmé ou réalisé en urgence.

L'enjeu est de réaliser le soin dans un contexte le plus serein possible et bénéfique à tous : enfant, parents et soignants. De prévenir ou de limiter au maximum la contention de l'enfant et d'éviter une mémorisation négative du soin qui risquerait de compromettre la réalisation des prochains.

Articles et études sur le sujet : site du Centre National de Ressources contre la Douleur (CNRD).

Comment distraire l'enfant pendant un soin ?

Chanter ou raconter une histoire est une façon de distraire un enfant mais ce n'est pas toujours suffisant... Distraire c'est être dans un état d'esprit particulier et anticipé, de vouloir arriver à capter, à détourner l'attention de l'enfant pour l'attirer vers quelque chose de positif, alors que l'on pratique sur lui un geste impressionnant, pénible ou douloureux.

Différents canaux pour capter l'attention de l'enfant

Chaque enfant est sensible aux stimuli visuels, auditifs, kinesthésiques (le toucher), olfactifs ou gustatifs. Pour simplifier ou s'en souvenir, on dit aussi « le VAKOG ».

Selon sa personnalité, son âge, les expériences de sa vie, l'enfant privilégie l'un ou l'autre canal sensoriel. Stimuler ce canal sera plus efficace au moment du soin. Pour le repérer, on propose un ensemble de jeux et de propositions qui permette à l'enfant d'indiquer aux soignants celui qu'il préfère. Associer plusieurs canaux sensoriels peut renforcer l'efficacité de la captation de son attention.

Des stratégies de diversion

- Surprendre agréablement les enfants avec un objet, un jeu intrigant, une activité qu'ils ne connaissent pas. Ce qui est nouveau est toujours très attractif !
- Certains enfants ou adolescents peuvent apprécier qu'on leur lance un défi.
« Je parie que j'aurai fini le soin avant que tu aies trouvé les 7 différences sur l'illustration ! »
On peut également leur proposer un concours qui fait participer les différentes personnes présentes : « Qui saura mieux dessiner une tour Eiffel sur le tableau ? », « Qui connaît la blague la plus bête ? ».
- Faire exprès de se tromper pour faire réagir l'enfant : en expliquant quelque chose, en comptant une série de chiffres, en transformant les paroles d'une chanson connue. Ou prévenir l'enfant que l'on va se tromper ou modifier des paroles et qu'il doit repérer l'erreur ou le changement.
- Faire semblant de se contredire, de se chamailler entre collègues.
- Détourner le rôle du matériel médical (l'écran du cardioscope fait des vagues ou des montagnes, le masque d'anesthésie devient celui de l'aviateur).

Eviter des remarques censées rassurer l'enfant, telles que : « Rassure-toi, ça ne va pas faire mal ». Elles peuvent être contre-productives, l'enfant risquant de ne retenir que le mot « mal » et pas la négation.

- Proposer un jeu avant le soin. Occuper l'enfant, le faire patienter avant de commencer le soin en proposant un jouet, un jeu, une activité.

Les moyens de distraction sont très nombreux et variés, par exemple : écouter une histoire, de la musique, regarder des images, la télévision, des objets ludiques, des mobiles, des animations visuelles, jouer à des jeux vidéo, se faire masser, se relaxer, chanter, compter, dessiner, souffler des bulles, respirer des odeurs, manipuler des objets ludiques, détourner l'utilisation du matériel médical.

- Faire bien en sorte que l'enfant garde avec lui ce qui le rassure, en particulier son objet transitionnel, « son doudou », s'il en a un.
- Proposer une méthode de distraction dans le cadre de la relation soignant-soigné.

Proposer un outil de distraction sans le placer dans le cadre d'une bonne relation peut réduire considérablement l'efficacité de la méthode, voire l'annuler.

Le rôle des parents

La présence des parents soutient et réconforte l'enfant pendant les soins. Ils ont cependant besoin d'être guidés. Les encourager à maintenir un contact chaleureux, distrayant et rassurant (prendre la main, caresser l'enfant, raconter une histoire).

Il est déconseillé de faire participer les parents à la contention de l'enfant.

Les parents supportent mal de ne pouvoir empêcher la souffrance de leur enfant. Qu'ils soient présents lors du soin et, à plus forte raison, s'ils sont absents, il est important de ne pas les culpabiliser.

Leur proposer d'être présents auprès de leur enfant pendant un geste douloureux mais ne jamais les obliger.

La présence des parents atténue souvent la détresse de l'ensemble des personnes (enfant, parents, mais aussi soignant). Le climat relationnel est meilleur lorsqu'on leur permet de rester auprès de leur enfant.

Ce que les parents peuvent faire

Prévenir d'éventuels antécédents difficiles. Garder un contact physique, visuel ou auditif avec leur enfant. Raconter des blagues, évoquer des souvenirs ou des sujets appréciés. Si l'enfant est jeune et que le soin le permet, le garder sur les genoux ou dans les bras. Lui tenir la main, le caresser, le masser, l'encourager, le féliciter et le réconforter.

Ce que les parents doivent éviter

Mentir. Participer à la contention si l'enfant est agité.

Le plaindre pendant le soin au risque d'augmenter sa détresse.

Les points clés pour établir une relation de confiance avec les parents

- Tenir compte des informations sur l'enfant fournies par les parents.
- Les informer des moyens utilisés pour prendre en charge la douleur de leur enfant.
- Les inviter à aider l'enfant pendant les soins.
- Apprécier leur anxiété.
- Ne pas les culpabiliser.
- Les considérer comme des partenaires.

Comment communiquer avec les parents ?

Être à l'écoute

Apprécier l'anxiété et l'inquiétude des parents. Des gestes qui peuvent apparaître simples et banals pour les soignants ne le sont pas toujours pour les parents. Il est inutile d'accuser les parents de transmettre leur anxiété à l'enfant. Prendre en charge la douleur de l'enfant rassure les parents.

Que perçoivent-ils de la douleur de l'enfant ? La plupart des parents sont capables de très bien décrire les changements dans le comportement de l'enfant.

S'enquérir du passé douloureux de l'enfant, des signes de douleur et des moyens habituels pour la soulager (câlin, tétine, doudou). Les informer honnêtement et simplement.

S'aider éventuellement du « Carnet douleur » et du livret SPARADRAP « Aïe j'ai mal ».

Établir une relation de confiance et d'échange avec eux. Apprécier la difficulté du geste et la possibilité pour eux de participer ou d'aider.

Plus on dispose de moyens antalgiques, plus la communication avec les parents est facile.

La participation des parents aux soins

La circulaire DH/EO 3 n° 98-688 du 23 novembre 1998 relative au régime de visite des enfants hospitalisés précise : (...) « L'hospitalisation d'un enfant, quel qu'en soit le motif médical, est une source d'angoisse pour lui-même et pour sa famille. Il est particulièrement important de limiter cette angoisse et de lui éviter en outre une séparation injustifiée de son entourage immédiat. »

(...) « La mère, le père ou toute autre personne qui s'occupe habituellement de l'enfant doit pouvoir accéder au service de pédiatrie quelle que soit l'heure et rester auprès de son enfant aussi longtemps que ce dernier le souhaite, y compris la nuit. »

(...) « Le personnel soignant doit être particulièrement attentif aux remarques formulées par l'entourage de l'enfant hospitalisé, notamment en ce qui concerne le comportement de l'enfant et toute attitude de sa part qui pourrait traduire une douleur physique. (...) »

Les craintes des soignants

La présence des parents pendant les soins suscite souvent de l'anxiété pour le personnel soignant :

- Peur d'être jugé.
- Peur de mal faire le geste sous le regard des parents.
- Perte de la maîtrise de la situation.

Autant de craintes réelles qui peuvent s'amoinrir avec le temps et l'expérience.

Faire participer les parents aux soins est une attitude récente qui vient quelque peu bouleverser les pratiques, et pourtant...

- ▶ Plusieurs études ont évalué les conséquences et la pertinence de la présence des parents auprès de leur enfant lors d'un geste agressif aux urgences (prélèvement sanguin, sutures).
- ▶ La présence des parents n'a pas nui pas à la performance du geste. Le pourcentage de ponctions veineuses réalisées à la première tentative était le même, que les parents soient présents ou absents.
- ▶ L'anxiété des parents, évaluée par EVA, était plus importante dans le groupe des parents absents.
- ▶ Globalement, 70 % des parents pensent que les parents et/ou les enfants doivent participer à la décision de la présence ou de l'absence des parents lors d'un geste agressif.

Question posée à l'Assemblée nationale sur le transport d'un mineur non accompagné

<http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/14/QE/2382>

Charte de l'enfant hospitalisé

Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental, particulièrement pour les enfants – UNESCO

1. L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.
2. Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état.
3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n'entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. On informera les parents sur les règles de vie et les modalités de fonctionnement propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de leur enfant.
4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. On essaiera de réduire au minimum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.
5. Les enfants et les parents ont le droit d'être informés pour participer à toutes les décisions concernant la santé et les soins. On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable.
6. Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge.
7. L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité.
8. L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.
9. L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant.
10. L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toute circonstance.

Charte Européenne des Droits de l'Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986.
Circulaire du Secrétariat d'Etat à la Santé de 1999 préconise son application.



CHARTRE DE L'ENFANT HOSPITALISÉ

Charte Européenne des Droits de l'Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986.

1 L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

3 On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles. On informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de leur enfant.

On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable. On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.

6 Les enfants doivent être réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives, adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge.

8 L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

10 L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toute circonstance.

2 Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état.

4 Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.

7 L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité.

9 L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant.



Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille

VIOLENCE, BURN OUT, SYNDROME STRESS POST TRAUMATIQUE ET GESTION DE CONFLIT

Contexte de violence

La violence à l'égard du personnel est toujours inadmissible. Nous n'aborderons ici que la violence exercée par les patients ou leurs accompagnants, tout en gardant à l'esprit que les soignants peuvent également faire l'objet de violence de la part de leurs collègues de travail ou de leur encadrement.

L'insécurité dans la chaîne hospitalière, et aux urgences en particulier, est un phénomène réel même s'il est difficile à mesurer. Elle a des conséquences majeures sur la qualité et l'accès aux soins pour les patients, et sur les conditions de travail et la motivation des personnels. La politique de prise en charge de l'insécurité aux urgences, mais aussi en préhospitalier se doit d'être ambitieuse. Elle doit s'intégrer dans un projet qualité qui vise à améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients, et à assurer des conditions de travail satisfaisantes et d'épanouissement professionnel pour les personnels.

La violence envers le monde de l'ambulance est encore peu référencée dans la bibliographie. Un climat de sécurité doit être restauré. Pour cela, l'organisation de l'entreprise doit être adaptée, les délais d'attente diminués, la qualité de l'accueil renforcée lors d'une prise en charge à domicile, et l'information des patients et des accompagnants garantie, ce qui passe par une information pertinente entre la régulation – ambulancier- service de soins.

Les équipes doivent prévenir les situations de conflit, gérer l'agressivité et diminuer la fréquence des dysfonctionnements organisationnels. Les incivilités et la violence sont les marqueurs de cette insécurité. L'objectif est de créer ou restaurer des conditions de sérénité et d'empathie permettant d'offrir les meilleurs soins possibles et la prise en charge médicale et sociale la plus adaptée à chaque patient.

Etude de OMS, La violence en chiffre

Selon une étude de 2002 par OMS, la violence à l'encontre du personnel soignant menace les services de santé, indique que partout la violence incite les agents de santé à abandonner leur profession et l'offre en soins de qualité s'en ressent. Reconnue comme un problème sérieux dans de nombreux pays industrialisés, la violence à l'encontre du personnel soignant est en fait un phénomène mondial, selon la nouvelle étude.

Au-delà des frontières, des cultures, des conditions de travail et des groupes professionnels, la violence dans les services de santé est une épidémie qui touche toutes les sociétés, y compris celles des pays en développement. Elle* montre que **plus de la moitié du personnel de santé interrogé a été victime au moins une fois de violence physique ou psychologique au cours de l'année précédente.**

En Afrique du Sud, la proportion atteint 61 %. En Thaïlande, 54 %. L'enquête a également été menée au Portugal où 60 % des 212 personnes interrogées travaillant dans un grand centre urbain de santé ont indiqué avoir été victimes d'au moins un épisode de violence au cours des 12 derniers mois.

L'étude a été mandatée par un programme commun portant sur la violence au travail dans le secteur de la santé, sous l'égide de l'Organisation internationale du Travail (OIT), du Conseil international des Infirmières

(CII), de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l'Internationale des Services publics (ISP). Ce programme a pour objectif de donner des orientations pour l'élaboration et la mise en œuvre de directives ou de politiques nationales et locales pour lutter contre la violence au travail dans les services de santé.

Quelques points essentiels dans cette étude

Dans de nombreux pays, ce programme conjoint de recherche sur la violence a donné la première occasion d'évaluer la prévalence et la nature de la violence au travail dans le secteur de la santé**.

Les résultats, présentés lors d'une consultation technique organisée récemment à Genève, montrent que le phénomène est universel, bien que les caractéristiques locales puissent varier. Les données établissent la trop grande fréquence de la violence, ainsi que la nécessité d'intervenir d'urgence et de prendre des mesures préventives. La consultation a abouti à la conclusion **que la violence psychologique avait une forte prévalence** (en plus de la violence physique très répandue). De nombreux agents de soins signalent que la violence des rues déborde dans les hôpitaux. En outre, **le stress inhérent à la restructuration de nombreux systèmes de santé est un facteur majeur qui contribue à la violence dans ce milieu.**

Personnel exposé

La violence touche l'ensemble du personnel soignant, qu'il s'agisse des femmes ou des hommes, même si le risque est variable. Dans tous les pays étudiés, **le personnel ambulancier est particulièrement exposé.** Médecins et infirmières sont également fortement concernés, comme l'indiquent toutes les enquêtes.

Conséquences

La consultation a souligné les conséquences négatives d'une violence aussi fréquente sur l'offre dans le secteur de la santé avec, entre autres, la dégradation de la qualité des soins et l'abandon des professions de santé par le personnel. Avec le risque d'une diminution de l'offre au public et d'une augmentation des coûts. Dans les pays en développement notamment, l'accès généralisé aux soins est menacé si le risque de violence conduit le personnel, déjà en quantité insuffisante, à abandonner le secteur de la santé.

Autres résultats

Dans la plupart des pays étudiés, il n'y avait pas de directives spécifiques aux lieux de travail pour éviter ou réagir à la violence. Cette situation entraîne une notification inférieure au nombre des incidents, un suivi insuffisant de ceux qui sont signalé, l'absence de sanction pour leurs auteurs et le mécontentement des victimes.

Les travaux mettent également en lumière **la relation fondamentale entre le stress et la violence.** En Afrique du Sud, un grand nombre de **victimes signalent des symptômes en relation avec l'état de stress post- traumatique après avoir vécu un incident.** Être victime d'actes de violence dans le secteur de la santé provoque un stress important, mais peut conduire également à des comportements violents. Les données confirment en outre que les témoins d'un acte de violence ne sont pas indemnes.

La consultation a confirmé l'universalité des définitions utilisées pour caractériser la violence au travail. Les données montrent que, dans ce domaine, **le secteur de la santé se trouve en première ligne.** Cette étude inédite a dégagé une perspective unique sur les situations et les professions fortement exposées et elle permettra de concevoir des interventions ciblées.

Contexte de violence

Les difficultés rencontrées quotidiennement par les professionnels de santé dans l'exercice de leurs fonctions font régulièrement l'objet de dossiers de presse. Les phénomènes de violence au sein de l'hôpital, et plus généralement au sein des établissements de santé, y sont particulièrement mis en avant. L'hôpital, institution ouverte à tous au nom du principe d'égalité, ouverte à tout moment au nom du principe de continuité, confronte notre service public de santé à toutes les formes de violence dont souffre notre société.

Les manifestations d'agressivité, rendues plus visibles au travers des politiques de prévention et de gestion des violences déployées par le ministère de la Santé depuis plusieurs années, remettent en cause les modes de fonctionnement des établissements et interrogent sur les organisations en place. D'autant plus

qu'elles induisent un risque psychosocial pour les professionnels touchés et influent directement sur la qualité de l'accueil et des soins dispensés.

Aujourd'hui, s'il apparaît évident que l'hôpital doit assurer dans son enceinte la sécurité des biens et des personnes. Il doit également intervenir lorsque son personnel se trouve en position de vulnérabilité certaine (injures, menaces) ou lorsqu'il est exposé à une dangerosité exprimée (violences physiques ou matérielles), quel que soit l'auteur de ces actes.

L'insécurité pour un ambulancier, aux urgences en particulier, est un phénomène réel, même s'il est difficile à mesurer. Ses conséquences sont majeures sur la qualité de la prise en charge et l'accès aux soins pour les patients ainsi que sur les conditions de travail et la motivation des personnels. L'ambulancier doit toujours s'adapter à son patient/victime.

Définitions et types de violences

Définition de OMS

La violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès.

Les différents types de violence

Un acte de violence recouvre tout événement, agression, parole, comportement blessant qui porte atteinte :

- ▶ A l'intégrité physique et/ou psychique des personnels,
- ▶ Aux biens des personnels et/ou au bon
- ▶ Au bon fonctionnement des services.

Si la violence la plus marquante est celle qui atteint l'intégrité physique, il ne faut pas occulter pour autant la violence psychologique, de mieux en mieux reconnue, notamment par les textes.

1° Violence au travail

Incidents au cours desquels la personne est victime d'un comportement abusif, est menacée ou agressée physiquement dans des circonstances liées à son travail, y compris sur le trajet entre le domicile et le lieu du travail et impliquant une remise en cause implicite ou explicite de sa sécurité, de son bien-être ou de sa santé.

2° Violence physique

Recours à la force physique contre une personne ou un groupe entraînant des préjudices physiques, sexuels ou psychologiques. Elle comprend les coups (coups de pied, de poing, gifles, etc.), l'utilisation des armes blanches, des armes à feu, le fait de bousculer les victimes, les morsures, les pinçages, etc.

3° Violence psychologique (sévices émotionnels)

Exercice intentionnel d'un pouvoir, avec éventuellement menace du recours à la force physique, à l'encontre d'une personne ou d'un groupe, portant préjudice à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Le terme recouvre les agressions verbales, les tracasseries, les brimades, le harcèlement et les menaces.

Définitions des termes relatifs à la violence

■ Agression/Attaque

Comportement destiné à nuire physiquement à une autre personne. Les agressions sexuelles (les viols) en font partie.

■ Comportement abusif

Comportement qui humilie, dégrade un être humain ou indique de toute autre manière un manque de respect de sa dignité ou de sa valeur.

■ Brimades

Comportement agressif, répétitif et prolongé, qui consiste à tenter de manière vindicative, cruelle et malintentionnée d'humilier ou d'affaiblir un individu ou un groupe d'employés.

■ Harcèlement

Toute conduite indésirable, unilatérale, fondée sur l'âge, l'incapacité, le statut par rapport au VIH, la situation domestique, le sexe, l'orientation sexuelle, la transsexualité, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l'appartenance à un syndicat, les opinions, les croyances, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité, la propriété, la naissance ou tout autre état, et affectant la dignité des hommes et des femmes dans leur travail.

■ Harcèlement sexuel

Tout comportement indésirable, unilatéral et déplacé de nature sexuelle offensant la personne concernée et constituant pour elle une menace, une humiliation ou une gêne.

■ Harcèlement de nature raciale

Toute conduite menaçante, unilatérale, indésirable, fondée sur la race, la couleur, la langue, l'origine nationale, l'appartenance à une minorité, la naissance ou tout autre état, et affectant la dignité des hommes et des femmes dans leur travail.

■ Menace

Promesse du recours à la force physique ou à l'exercice d'un pouvoir (psychologique par exemple) induisant, pour la personne ou le groupe visé, la peur de préjudices physiques, sexuels ou psychologiques ou d'autres conséquences négatives.

Éléments accentuant les facteurs déclenchant d'un événement violent

Consommation d'alcool

L'alcool désinhibe et fait souvent ressortir son mauvais côté d'une personne. L'alcoolisation, occasionnelle ou chronique, provoque un changement du comportement, entraîne souvent un état d'euphorie et une perte des repères (moraux et physiques). Dans cet état, la victime n'accepte pas l'action du secouriste. Tout ce qui l'empêche de « s'amuser » est perçu comme antipathique.

Consommation de substances illicites

La consommation de substances illicites (drogues) peut provoquer des effets similaires ou plus violents chez la victime : hallucinations (visuelles et auditives), augmentation de la résistance physique. La présence, autour de la victime, d'autres personnes elles-mêmes alcoolisées peut envenimer une situation et engendrer un conflit avant l'arrivée de l'équipage.

Pathologies psychiatriques

La déformation de la réalité, liée à la maladie, est très fréquente. Une paranoïa entraîne des dérèglements

de la pensée, incluant un délire de persécution dans lequel l'ambulancier représentera un danger. De nombreuses autres pathologies entraînent des situations conflictuelles et demandent une attitude professionnelle et surtout une bonne maîtrise de sa communication.

Cas particulier : la schizophrénie

La schizophrénie est une maladie psychiatrique dont les causes sont encore mal connues et qui se manifeste notamment par des difficultés à exprimer ses émotions et à établir des **relations sociales**. Chez les patients schizophrènes, le **langage corporel est perturbé**.

► Laisser de l'espace (la distance interpersonnelle peut être modifiée).

■ **Les symptômes positifs** sont les plus impressionnants :

- **Sentiment de persécution** (paranoïa),
- **Mégalomanie**
- **Idées délirantes** bizarres, invraisemblables et excentriques,
- **Hallucinations sensorielles**, le plus souvent auditives, avec une ou plusieurs voix qui interpellent le patient. Les hallucinations peuvent être aussi visuelles, olfactives, tactiles ou gustatives.

■ **Les symptômes négatifs** correspondent à un **appauvrissement affectif et émotionnel** avec une mise en retrait par rapport à la famille et la société. Les cliniciens parlent souvent « d'émoussement » de l'émotivité, de la communication et de la volonté. Les patients s'isolent, présentent une perte d'intérêt, une difficulté à entreprendre des actions et paraissent insensibles au monde extérieur.

■ On relève par ailleurs une **désorganisation** de la pensée, des paroles, des émotions et des comportements. Le patient montre des **sentiments contradictoires** dans une même discussion et tient un **discours incohérent**. A ces symptômes s'ajoutent souvent une baisse de l'attention, de la concentration, de la mémoire ou encore de la compréhension. Cela se traduit notamment par une **incapacité à planifier des tâches simples** (faire son travail ou des courses), source d'un handicap majeur dans la vie quotidienne.

Démences des patients

Les changements cognitifs peuvent causer des réactions et des comportements émotionnels qui demandent un effort spécial à gérer. Une personne atteinte de démence peut faire preuve de comportements agressifs, comme pousser, frapper ou crier. Les comportements agressifs peuvent rendre la communication extrêmement difficile pour un soignant.

Contexte d'intervention d'un ambulancier

A la différence des équipes hospitalières, les ambulanciers interviennent dans l'intimité des cercles familiaux. L'ambulancier peut être témoin de conflits, sources de dérapages verbaux.

Raisons d'une violence spécifique envers l'ambulancier

- Le retard (indépendant de la volonté de l'ambulancier) est souvent la cause de nombreux conflits. Le ton peut vite monter et devenir agressif envers l'ambulancier. Garder son calme et se dire que c'est l'image de la profession qui est visée et non sa propre personne.
- Les facilités de passage d'une ambulance : la présence d'une ambulance en urgence sur la route peut provoquer une volée de mots (et de gestes) désagréables. C'est la loi de la route ! La seule chose à faire, continuer sa route sans se retourner et se concentrer sur son itinéraire. Il ne faut pas oublier que la priorité reste le patient installé dans la cellule.

Victime de violence : que faire ?

Si un membre du personnel est victime de coups de la part d'un patient ou d'un accompagnant, il s'agit d'un **accident du travail**, puisque c'est une blessure subie sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et à l'occasion du travail. Si des séquelles sont possibles (elles peuvent être très retardées, notamment sur le plan psychologique) ou si des soins sont nécessaires, une déclaration d'accident du travail doit être faite rapidement, car les délais sont très courts : la victime doit déclarer l'accident dans les 24 heures à son employeur, en indiquant le lieu où il s'est produit, les circonstances et les coordonnées d'éventuels témoins. L'employeur doit alors remettre au salarié la feuille d'accident. Selon les articles L. 471-1 et R. 471-3 du Code de la sécurité sociale, les employeurs qui ont négligé de procéder à la déclaration des accidents à la CPAM dans les 48 heures, ou de délivrer à la victime la feuille d'accident, sont punis d'une amende. Par la suite, un examen de la victime est réalisé afin de fixer la date de consolidation et d'évaluer le dommage. Selon son importance, une invalidité pourra être reconnue, et les prestations correspondantes versées.

L'acte violent doit également faire l'objet d'un **dépôt de plainte**, ou au minimum d'une main courante, afin que son auteur soit poursuivi et que les autorités de police et de gendarmerie soient alertées de l'existence d'agressions à l'hôpital ou à la clinique. L'alcoolisation ou une pathologie psychiatrique de l'agresseur ne doivent pas empêcher ce dépôt de plainte ; il appartiendra ensuite à la juridiction saisie de se prononcer sur l'éventuelle irresponsabilité pénale de l'auteur des violences. Si aucune action n'est engagée, il restera impuni et risque alors de récidiver, dans le service ou dans un autre. Dans les services d'urgences, où il existe nécessairement des rapports avec la police et la gendarmerie qui y accompagnent souvent des patients, les dépôts de plainte peuvent se trouver facilités.

Le préjudice peut être

- ▶ Physique ou psychique (blessure et, de manière générale, toute atteinte à la santé, à l'intégrité physique ou mentale d'une personne),
- ▶ Moral (préjudice non économique et non matériel subi par la victime)
- ▶ Matériel (dégât et dégradation matériels, véhicule brûlé, vêtement déchiré, lunette détériorée...)

Lorsqu'un agent est victime dans son exercice professionnel, sa prise en charge se fait à plusieurs niveaux : clinique, psychologique et social, administratif, juridique.

Clinique

La prise en charge est physique et rapide, voire médicalisée, en vue de l'orientation de la victime selon son état de santé et son choix d'établissement. Un examen médico-légal est alors demandé, les renseignements utiles recueillis, les éléments de preuve conservés, les traces et les indices préservés.

Psychologique et sociale

La prise en charge est immédiate et systématique, selon la procédure formalisée par l'établissement.

Administrative

La prise en charge s'effectue en plusieurs étapes :

- ▶ Remplir la fiche d'événement indésirable ou d'incident et rédiger un rapport circonstancié.
- ▶ Constituer un dossier d'accident du travail.
- ▶ Informer la victime sur ses droits (possibilité de prendre contact avec le défenseur des droits).
- ▶ Constituer un dossier sinistre par l'établissement.

Juridique

La prise en charge porte sur l'assistance de l'administration pour le dépôt de plainte, voire sur l'assistance et la protection juridiques avec mise à disposition d'un avocat et sa prise en charge financière par l'entreprise. Se renseigner auprès de son employeur.

Drame face à un patient violent

<http://www.ouest-france.fr/les-ambulanciers-souvent-livres-eux-memes-126794>

Les ambulanciers souvent livrés à eux-mêmes

Selon le Pr Millet, « les ambulanciers ne sont absolument pas habilités à attacher un patient. Ils ne peuvent ni l'attacher ni lui donner un médicament ». Joël Le Gall

« C'est un drame exceptionnel, mais il est révélateur de ce qui se passe dans les transferts de patients sous contrainte, estime Bruno Millet, psychiatre chef de service au centre hospitalier spécialisé Guillaume-Régner (Rennes). Je m'étonne que ce ne soit pas déjà arrivé plusieurs fois. »

Samedi, un homme âgé de 27 ans, qui a failli se suicider en voulant se jeter d'un pont, est transféré de l'hôpital de Saint-Brieuc à l'hôpital psychiatrique de Bégard. Hospitalisation à la demande de sa famille. À la hauteur de Plérin, sur la RN12, il se jette sur l'un des deux ambulanciers. La porte s'ouvre, tous deux chutent sur la voie. L'homme se relève, enjambe le rail de sécurité, s'élance dans la circulation. Il est renversé et ne pourra être réanimé. Hier, le jeune ambulancier, Cyril Haquevaux, 24 ans, est décédé à son tour. Dimanche, il avait été transféré à l'hôpital Pontchaillou, à Rennes, en état de mort cérébrale.

« Trop souvent livrés à nous-mêmes. »

Comment ce drame a-t-il pu avoir lieu ? **« Contrairement aux hospitalisations d'office (sur décision du préfet), il n'y a pas de règle particulière pour le transport d'un patient hospitalisé à la demande d'un tiers (par exemple, un parent) »,** indique Bernard Pelletier, président du Syndicat national des ambulanciers privés. **« Les médecins peuvent choisir de médicaliser le patient (lui administrer un sédatif), signaler qu'il est agité, explique-t-il. Le médecin peut également demander à un infirmier d'embarquer dans l'ambulance. Rien n'oblige à attacher les patients. C'est très dévalorisant pour eux et souvent mal perçu par les équipes médicales.**

On reprochera à l'ambulancier de ne pas avoir bien préparé psychologiquement le patient. En fait, nous sommes trop souvent livrés à nous-mêmes. »

Les transferts d'un hôpital à un autre de patients présentant des troubles du comportement ne sont pas rares. Soit pour un passage d'un établissement « classique » à un établissement psychiatrique, soit pour subir des examens médicaux.

« Rien qu'en Bretagne, je dirais vingt à trente par jour », dit le professeur Millet.

Pas le droit d'attacher

« Les ambulanciers ne sont absolument pas habilités à attacher un patient, précise-t-il. Ils ne peuvent ni l'attacher ni lui donner un médicament. S'il y a contention ou sédation, ce doit être fait avant. Les ambulanciers n'ont théoriquement le droit d'intervenir d'aucune façon. Dans un transport de ce type, à mon avis, il faut un soignant (médecin ou infirmier) dès qu'il y a le moindre doute. Il est essentiel qu'il y ait une bonne évaluation médicale du risque de passage à l'acte. Trop souvent, les médecins laissent les infirmiers se débrouiller. »

Recueilli par Philippe RICHARD.

Attitudes face à une situation violente

Que faire en cas de comportements agressifs ?

■ Restez calme.

- Maintenez une respiration lente et ample
- Mettez de la distance : accordez un l'espace d'environ 5 m à la personne pour qu'elle se calme.
La distance vous préserve également de tout geste violent (gifle).
- Eloignez les témoins (entourage, badauds) de la scène en changeant de pièce ou en les faisant sortir.
- Accordez du temps (si possible), lors d'un conflit avec un collègue par exemple. Attendez d'être apaisé pour en reparler plus calmement, sans témoin.
- Utilisez un ton calme et rassurant. Élever la voix pourrait aggraver la situation.
- Gardez un rythme lent
- Utilisez une gestuelle d'apaisement (paume vers le sol, pour faire redescendre la pression)
- Par mimétisme le patient calque son comportement et sa respiration sur les vôtres.
- Si la colère est très intense, commencez par des questions courtes, simples et fermées. La personne en colère frappe lorsqu'elle n'a plus de mots, lorsqu'elle est à court d'arguments. A ce stade de colère, elle ne peut faire que des réponses courtes.
- Puis, lorsque la pression est moins forte, demandez à la personne ce qui la trouble afin de pouvoir déterminer la cause de son émotion et de son comportement : « **Je suis en colère parce que** je veux aller dans la cuisine, mais je suis bloquée ici, dans la salle de séjour ».
- Taisez-vous.
- **Écoutez** vraiment : le silence est aussi une forme de communication.
- Ne rentrez pas dans la confrontation
- Reformulez ce que vous avez compris de la situation pour bien signifier au patient que vous l'écoutez, que vous le comprenez et que vous tenez compte de son problème. Alors il pourra s'apaiser.
 - Ne banalisez pas : « mais non, ce n'est rien » - « ce n'est pas grave » - « il n'y a pas de quoi s'énerver ».Ces phrases NE SONT PAS apaisantes, elles nient la souffrance ou l'inquiétude du patient.
- Rassurez-le plutôt : « Je vois que vous êtes en colère, contrarié (selon le niveau de conflit). L'équipe est là pour vous, comment pouvons-nous vous aider ? »
- Tentez d'accepter ou de fournir une explication : « J'ai remarqué que tu viens de prendre tes médicaments. Peut-être n'ont-ils pas eu encore le temps de faire effet... As-tu besoin d'aide ? ».
- Si votre sécurité est en jeu, quittez la pièce et revenez quelques minutes plus tard.
N'oubliez pas qu'il y a généralement un déclencheur aux comportements agressifs : la maladie, un besoin non satisfait ou encore la présence d'un élément perturbateur dans l'environnement de la personne.
- Ne vous sentez pas visé personnellement
- Recueillez les renseignements nécessaires et établissez un plan qui contribuera à gérer le comportement.

Dans ce contexte, il est important de bien « sentir » le moment où il faut demander de l'aide, pour intervenir avant que la situation ne dégénère.

Dire « Mais enfin calmez-vous !!! » n'a jamais calmé personne, surtout si c'est dit en haussant le ton.

Lorsque la communication est établie et la tension un peu redescendue, tentez de détourner l'attention de la personne pour lui faire oublier le problème qui l'a rendue agressive. (Occupez son esprit à autre chose, ne revenez pas sur le problème réglé.)

Syndrome Stress Post-Traumatique

Syndrome stress post-traumatique

À divers moments, tout le monde et notamment l'ambulancier, peut vivre des situations effrayantes. Chacun réagit de façon différente, par exemple ressentir de la nervosité, avoir du mal à bien dormir ou se remémorer une situation angoissante. Ce sont des réactions normales. Elles diminuent généralement au fil du temps et les personnes concernées reprennent peu à peu leur vie quotidienne. Le trouble de stress post-traumatique, en revanche, dure beaucoup plus longtemps et peut perturber gravement.

Qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique ?

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) résulte souvent de l'exposition à un événement traumatisant lié à la mort, à des menaces de mort ou à des blessures graves. Le TSPT peut également être lié à un traumatisme émotionnel continu, comme la violence dans le cadre d'une relation.

Un événement traumatisant effraie, accable et cause beaucoup de détresse. Cet événement est souvent inattendu, brutal et de nombreuses personnes affirment s'être senties impuissantes à l'arrêter ou à le transformer. Les événements traumatisants peuvent être des actes criminels, des catastrophes naturelles, des accidents, des guerres ou des conflits, des violences sexuelles ou d'autres menaces pour la vie et la sécurité. Il peut être vécu personnellement ou toucher d'autres personnes, y compris les proches.

Le TSPT **entraîne des symptômes envahissants**, parmi lesquels des souvenirs qui font revivre la scène en permanence. De nombreuses personnes ont des cauchemars frappants, des retours en arrière ou des pensées au sujet de l'événement qui semblent surgir de nulle part. Elles évitent souvent tout ce qui leur rappelle l'événement : ne plus conduire après avoir été témoin d'un accident de la route.

Le TSPT peut rendre les gens très nerveux ou les garder « sur le qui-vive » en permanence. Beaucoup se sentent effrayés très facilement, ont du mal à se concentrer, se sentent irritables ou rencontrent des difficultés pour dormir. Ils gardent l'impression qu'un événement horrible est sur le point de se produire, même lorsqu'ils sont en sécurité.

Certains emplois ou certaines professions placent les gens dans des situations dangereuses.

Le personnel militaire, les équipes d'intervention de première ligne (police, services d'incendie et **personnel paramédical intervenant dans les secours pré hospitaliers**), les médecins et les infirmières affichent des taux plus élevés de TSPT que ceux d'autres professions.

Que faire ?

De nombreuses personnes ressentent beaucoup de culpabilité ou de honte au sujet du SSPT, parce qu'on leur conseille simplement de surmonter les expériences difficiles. D'autres peuvent se sentir gênées d'en parler. Certaines croient même que c'est de leur faute. Le traumatisme est blessant. Si vous vivez des problèmes liés à un traumatisme, il est important de prendre vos sentiments au sérieux et d'en parler à un professionnel de la santé.

Ces professionnels sont disponibles pour aider dans des circonstances difficiles et pour passer le cap. Suite à cette prise en charge, les symptômes comme la reviviscence de l'événement, le stress et l'hyper vigilance vont progressivement s'estomper permettant de passer cette étape et de l'intégrer dans sa vie et non plus de lutter contre, par des phénomènes d'évitement.

Burn out : syndrome d'épuisement professionnel

Le sociologue J-C BARBIER (2004) souligne que le burn-out concerne plus particulièrement les soignants parce qu'ils sont les témoins directs de la souffrance, la misère, le malheur, la maladie et la mort. L'analyse des facteurs favorisant l'épuisement professionnel a permis de constater que ce syndrome est principalement lié à un stress chronique, dont l'origine peut provenir d'agents stressants individuels ou institutionnels.

Selon C. MASLACH (1998), six facteurs peuvent mener une personne au burn-out : la charge de travail, le sentiment de contrôle, la reconnaissance, la communauté, la justice, le respect ainsi que les valeurs.

Causes du burnout

Six grandes causes sont reconnues comme contribuant au développement du syndrome :

- La surcharge de travail et la complexité des tâches
- L'absence de contrôle et la non-maîtrise sur ses activités
- Le manque de récompense et de reconnaissance pour les efforts fournis
- L'absence de soutien social et de cohésion d'équipe
- Le décalage entre les valeurs de l'individu et celles de l'entreprise
- Le sentiment d'injustice ou de non-équité entre salariés

Les 4 phases de développement du burnout

Le syndrome de la souffrance du soignant, désignée par le terme de « burnout » comporte plusieurs niveaux d'intensité et progresse dans le temps, souvent en s'aggravant. Parmi les nombreuses descriptions des symptômes du burnout, celle d'EDELWICH et BRODSKY a le mérite d'être simple.

1° L'enthousiasme : le soignant est d'abord porté par un enthousiasme débordant qui lui fait tout voir en rose et lui donne le sentiment qu'il va faire de grandes choses. Il se dépense sans compter pour les patients et s'en trouve profondément gratifié.

2° La stagnation : quelques obstacles commencent à freiner cet enthousiasme. Le soignant est déçu par certains patients et fatigué de devoir se battre face à l'administration. Il compense ce déficit de plaisir par un surinvestissement qui s'avère contreproductif : sa santé s'altère, il dort mal, crée des tensions au sein de sa famille, néglige sa vie intime.

3° La désillusion, la frustration : le soignant commence à douter du sens de son travail, de ses jugements et de ses compétences. Les patients lui apparaissent ingrats et pénibles, les collègues irrespectueux ou indifférents. Il se sent déconsidéré et devient irritable pour ses proches. Sa santé se dégrade. Il a recours à des médicaments qu'il s'auto-administre et/ou se met à abuser de l'alcool, ce qui ne fait qu'accélérer le processus d'aliénation.

4° L'apathie, la démoralisation : le soignant est dans l'impasse, il n'a plus aucune considération ni pour lui-même, ni pour les patients qui l'indiffèrent ou qu'il méprise. Son travail n'est plus qu'alimentaire et il s'y soumet avec un cynisme qui se retourne contre lui : il songe à tout arrêter, voire à se suicider. La dépression est grave et l'issue passe par des soins spécialisés.

Burn out : que faire ?

- ▶ Être vigilant sur les signes d'alerte car le mécanisme décrit est très insidieux : le professionnel supporte, encaisse un certain nombre de choses... Jusqu'à la goutte d'eau qui fait déborder le vase : un ordinateur en panne, le décès d'un patient...
- ▶ Ne pas rester seul dans son coin. En parler à son conjoint, à des confrères avec qui on se sent en confiance. Les soignants concernés décrivent souvent un sentiment de honte et de culpabilité qui les empêche de se confier. Cependant, rester isolé renforce le cercle vicieux de la dépréciation de soi.
- ▶ Bien souvent, ce sont les conditions d'exercice qui posent problème. Les soignants ayant une certaine expérience conseillent à ceux qui s'installent de mettre des garde-fous dès le début.

Comment réagir face à un conflit

Qu'est-ce qu'un conflit ?

Le conflit :

- le combat, la lutte (exemple du conflit armé)
- la rencontre d'éléments qui s'opposent (la raison et la passion), de positions antagonistes
- renvoie à une relation de tension et d'opposition entre personnes.

Le conflit désigne donc **une situation relationnelle structurée autour d'un antagonisme, d'une opposition.**

On assiste ainsi à la présence simultanée de forces opposées, à un désaccord (valeurs, opinions, positions) à une rivalité lorsque des acteurs sont en compétition pour atteindre le même but ou posséder le même objet (physique ou symbolique), ou à une inimitié (hostilité) affective (animosité, haine)

Les origines d'un conflit

Les conflits d'intérêts

Intérêts divergents ou convergents (recherche de son avantage personnel, source de tension et de dissension)

Les conflits de pouvoir

Il découle du conflit d'intérêt, chacun veut influencer l'autre dans le sens de ses intérêts. Les conflits sont souvent sous tendus par un rapport de force, la hiérarchie et l'inégalité des statuts sont sources de lutte pour obtenir la soumission de l'autre (dominant) ou s'émanciper des contraintes imposées (dominé)

Les conflits identitaires

Quête de reconnaissance, recherche d'une place dans le groupe : je veux être reconnu par l'autre mais l'autre a le pouvoir d'infirmer, de rejeter mon identité par le déni ou le rejet (menace de mon intégrité)

Les conflits territoriaux

L'homme s'approprie son territoire physique (bureau) et symbolique : sa place dans l'organisation. On observe bien souvent la tendance à vouloir défendre son territoire.

Existence d'un espace personnel dont la pénétration est ressentie comme intrusion
S'applique aux objets (bureau, courrier, stylo) et ce qui nous appartient
Conflits naissant de violations territoriales effectives, supposées ou redoutés

Les conflits de relation

Une relation harmonieuse implique un consensus entre les acteurs sur la définition de la relation (appelée contrat de communication). Un désaccord est source de conflit.

Les conflits cognitifs

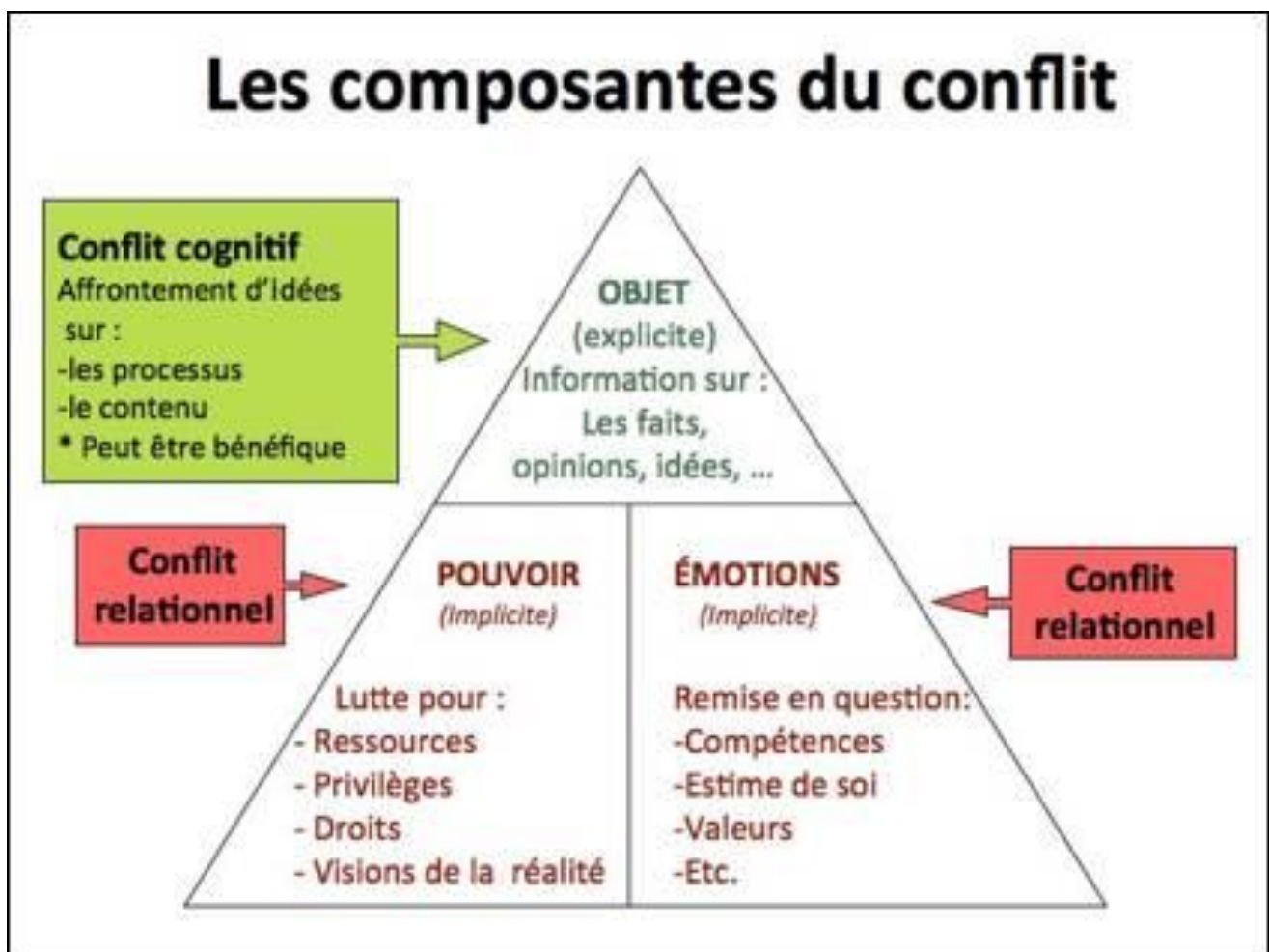
Chacun a sa propre vision du monde et veut imposer sa vérité (opinions, valeurs, idéologiques, religieux).
Liens très forts entre nos convictions, valeurs et notre identité (si elle est remise en cause alors c'est mon être tout entier qui est remis en cause)

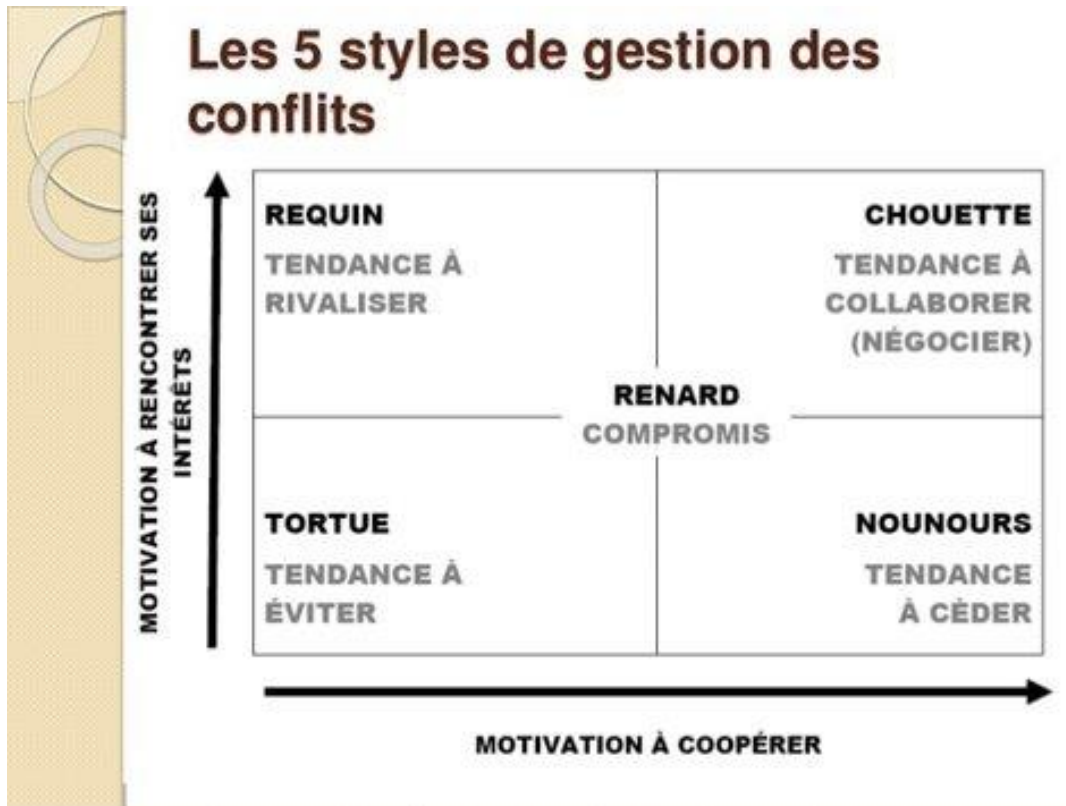
Les conflits affectifs

Conflit qui naît d'un sentiment (la peur, l'envie, l'amour, la haine) et qui provoque des rivalités violentes entre les acteurs

Les conflits culturels

Opposition entre deux cultures qui peut être à l'origine d'incompréhensions (Exemple : la culture latine et la culture germanique : niveaux de familiarité différents)





L'attitude du perdant :

Face aux conflits, les individus peuvent adopter une attitude de l'évitement (j'ignore le conflit, je fais semblant qu'il n'existe pas) ou de la dénégation (je nie les faits) ou encore de la fuite (je démissionne, je me tais, je laisse l'autre gagner, j'obtiens la paix). Ces attitudes de repli ne résolvent pas le conflit et génèrent des effets pervers (ressentiment, mauvaise humeur, plaintes non justifiées...).

L'attitude du gagnant/perdant :

Dans une situation conflictuelle, mettant en scène une équipe de travail, la méthode du gagnant consiste à imposer aux autres sa solution, sans prendre en considération les besoins des autres. Cette méthode autoritaire est basée sur la confrontation (j'impose mes idées), grâce à la position hiérarchique d'un individu, du pouvoir qu'il détient dans l'organisation. Une autre attitude développée peut être la manipulation (je tente de séduire ou de faire culpabiliser l'autre).

L'attitude du gagnant/gagnant :

L'attitude du gagnant-gagnant est celle du compromis ou de la collaboration (je veux résoudre le problème) qui permet à chaque partie d'en sortir la tête haute.

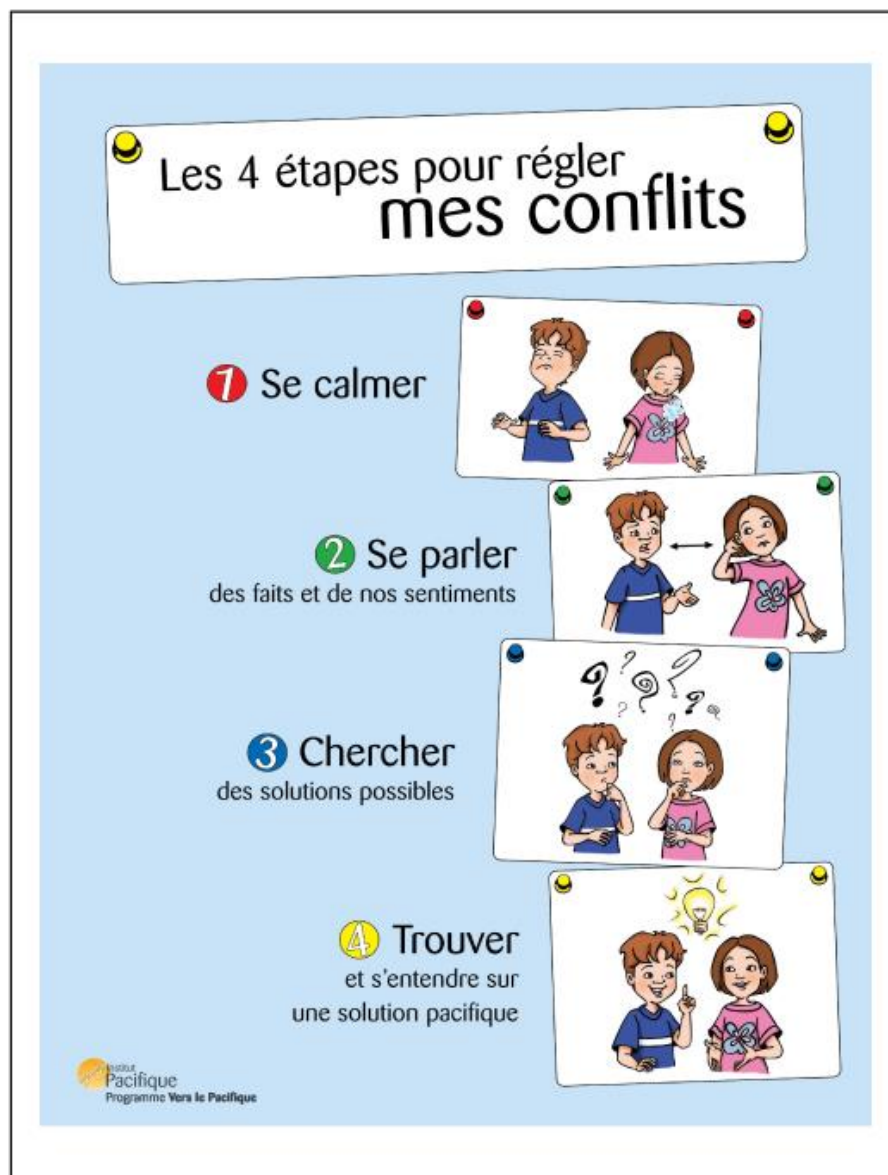
Pourquoi certains évitent le conflit ?

« Ce n'est pas beau de se disputer » : éducation des enfants à ne pas rentrer en conflit, à préférer la négociation à la bagarre.

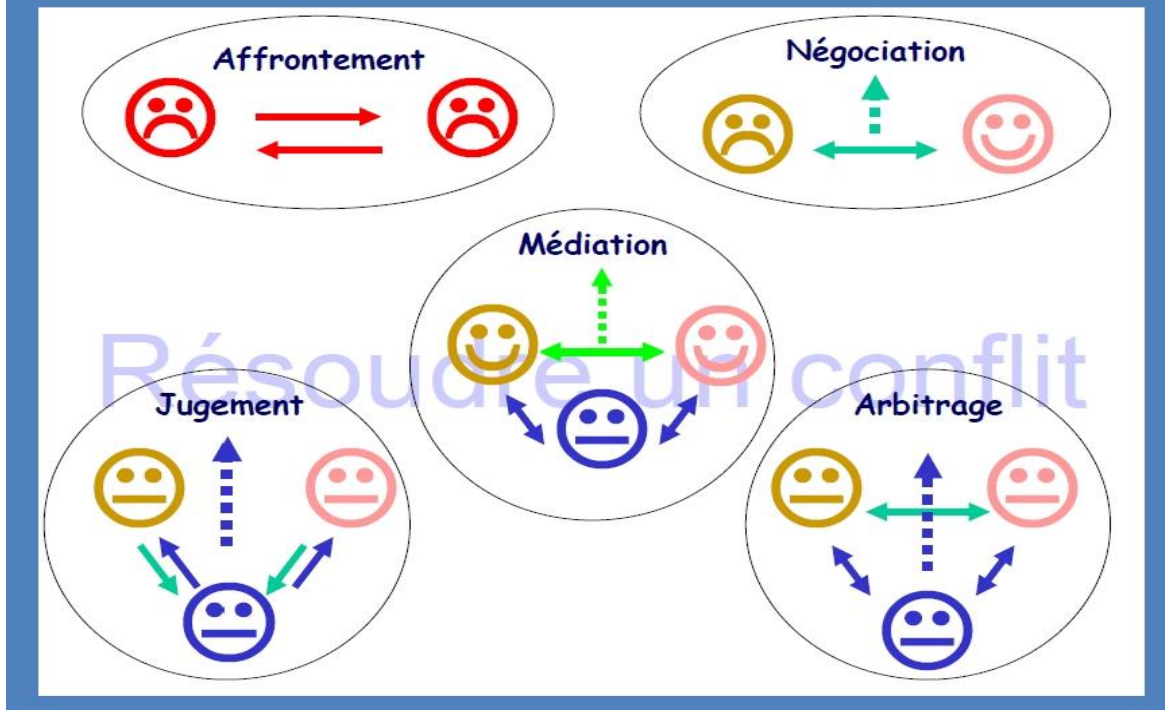
Le conflit fait peur : fuite devant le conflit (« restons-en là » ; « on fait comme tu veux et on n'en parle plus » ; « j'ai eu tort » ; « je n'aurais pas du ») parce qu'il génère des sentiments négatifs, suscite des angoisses (crainte du rejet, de l'abandon)

En fuyant le conflit, on se préserve de ses effets immédiats mais on n'élimine pas ses causes. Un conflit qui n'éclate pas reste latent, et remplit la relation d'affects négatifs (griefs, tension, rancœur, agressivité à fleur de peau, interprétation négative)

La résolution de conflit



Les différents modes de résolution de conflit



En cas de conflit, il faut garder son calme !

Respirez !

Le souffle, pourquoi ?

- Pour développer la puissance verbale pour être entendu(e)
- Respecter le rythme imposé par les phrases
- Oxygéner le cerveau qui a besoin d'air frais
- Décoincer le plexus solaire, siège de l'émotivité
- Dominer son tract
- Faire respirer son interlocuteur

Le souffle permet l'inspiration, c'est-à-dire l'entrée d'air et d'idées neuves.

En cas de conflit, il faut comprendre la situation en permettant à son interlocuteur de s'exprimer

Pratiquer l'écoute active : montrer son attention par le biais de techniques verbales et non verbales

- Faire clarifier des points (« que voulez-vous dire par... », « Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par... »)
- Reformuler afin de s'assurer de l'interprétation partagée
- Répondre aux sentiments en récapitulant ce que dit la personne dans le domaine émotionnel
- Démontrer de l'intérêt : montrer que ce que la personne vous dit vous intéresse

Les questions – réponses permettent :

- De recueillir les faits
- D'analyser et éclaircir une situation
- D'analyser les sentiments et émotions d'une personne
- D'encourager la personne à prendre une décision

Utiliser le « QQQQCP » :

- Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? Combien ? Où ? Pourquoi ?

En conclusion

La violence existe dans la société et nous y sommes confrontés dans l'exercice de notre profession de personnel de santé.

Savoir détecter et gérer un conflit facilite les prises en charge de tous les patients et permet de diminuer l'impact stress sur la vie de l'ambulancier.

LA FIN DE VIE/ CONCEPT DE MORT

Soins palliatifs et accompagnement

Travail de groupe puis mise en commun de l'étude de la Brochure INPES « Soins palliatifs et accompagnement » et fiche CISS sur la fin de vie.

En France, depuis 2005, les situations de fin de vie sont encadrées par la loi Léonetti. Cette dernière interdit l'acharnement thérapeutique, mais condamne l'euthanasie active.

L'**euthanasie**, du grec ancien « eu » (bon) et « thanatos » (mort), désigne l'**acte médical** consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales considérées comme insupportables, soit en agissant à cette fin, soit en s'abstenant d'agir.

On distingue communément à cet égard l'euthanasie active de l'euthanasie passive. L'euthanasie doit enfin être distinguée du « **suicide médicalement assisté** » qui consiste, pour le corps médical, à donner au patient les moyens de mettre lui-même fin à sa vie.

La loi Léonetti établit les points suivants :

- **L'obstination déraisonnable** du corps médical et la « prolongation artificielle de la vie » du patient (articles 1 et 9) sont proscrites, y compris lorsque ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d'abrégé la vie du patient en lui administrant la dose de soins palliatifs qu'il juge nécessaire à son confort, à condition d'en informer le patient, éventuellement la personne de confiance ou un proche (article 2).
- **La décision de cesser l'administration d'un traitement**, lorsque le prolonger semble relever de « l'obstination déraisonnable » doit être collégiale et ne peut être prise qu'après consultation de la « personne de confiance », de la famille, ou à défaut d'un de ses proches et des « directives anticipées » du patient (articles 1 à 9).
- **La volonté du patient** de limiter ou de cesser un traitement doit être respectée (articles 5 à 9). Le patient doit être informé des conséquences de sa décision.
- **L'avis de la « personne de confiance »**, choisie par le patient pour l'accompagner dans ses démarches et, si le patient le souhaite, dans ses entretiens médicaux, doit être consulté (articles 2, 5, 8 et 9).

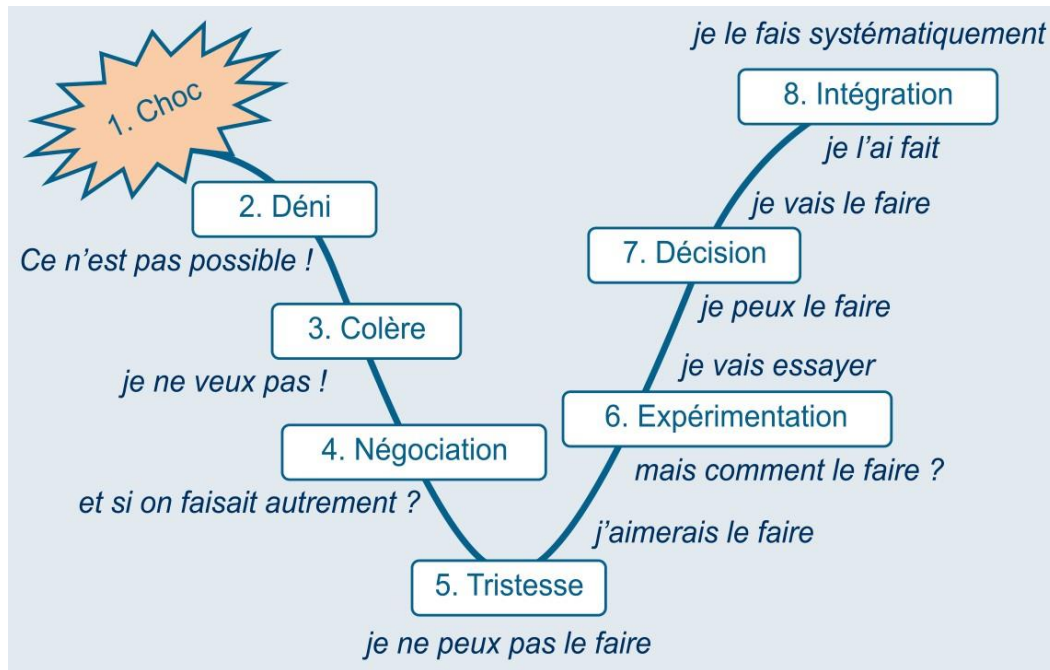
Les directives anticipées

Elles doivent figurer sur un document écrit, daté et signé sur lequel leur auteur doit porter son nom, son lieu et sa date de naissance.

Lorsque ce dernier est en incapacité d'écrire mais néanmoins apte à exprimer sa volonté, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance, d'écrire le document, en attestant qu'il est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Les directives anticipées sont inscrites dans le dossier médical du patient. Elles sont modifiables à tout moment et valides pendant trois ans au terme desquels l'auteur doit seulement confirmer leur validité par écrit sur le même document.

La désignation d'une personne de confiance doit se faire par écrit et peut être révoquée à tout moment.

La courbe du deuil



La courbe du deuil

Les réactions face à un événement difficile sont les mêmes, quel que soit le degré d'intensité de la souffrance. Qu'on parle d'affronter le décès d'un être cher ou d'échec à l'un des modules du DEA, les phases de réaction sont les mêmes.

On constate une phase descendante négative tournée vers le passé et le refus puis une phase ascendante de résilience tournée vers l'acceptation, le futur et le positif. Ces phases durent plus ou moins longtemps selon les capacités de résilience de chacun, c'est-à-dire la capacité à accepter un fait et à trouver des solutions pour rebondir.

Les 7 étapes du deuil

1° Choc et déni

Au premier stade, vient le choc à l'annonce de la perte.

Le choc est une étape légitime de défense de l'esprit pour une situation que la personne pense ne pas pouvoir gérer. La réaction est souvent la négation des faits qui se sont réellement produits.

La personne en deuil pense qu'elle rêve et refuse d'accepter la situation à l'origine de l'insupportable douleur. La durée de cette étape ne peut pas être déterminée.

Même les tâches les plus simples et les décisions de bases ne peuvent plus être effectuées par une personne en état de choc.

2° Douleur et culpabilité

A ce stade, la personne endeuillée prend conscience que la perte est bien réelle.

C'est l'étape la plus chaotique. La douleur pousse parfois la personne endeuillée à se sentir coupable et à considérer comme responsable de la perte.

Certains compensent avec de l'alcool et des médicaments.

3° Colère

A ce stade du deuil, la personne ressent de la colère en réaction au sentiment d'injustice.

Elle peut inconsciemment dévier cette colère sur une personne désignée comme responsable de la perte.

Une bonne gestion de la colère est indispensable à ce stade du deuil.

4° Marchandage

La personne se sent frustrée et commence à blâmer les autres pour la perte subie.

Sa réaction est injuste, mais la personne en souffrance n'est pas en état de le comprendre et d'accepter la réalité.

Elle entre alors dans une phase dans laquelle elle cherche les moyens d'inverser la situation et de la compenser. Cette étape est appelée la négociation.

5° Dépression et douleur

La personne accepte la perte, mais n'est pas en mesure d'y faire face.

Dépression, perte de moral, la personne en deuil est au désespoir et se comporte passivement.

Elle ne voit pas comment atténuer cette immense souffrance et n'arrive plus à vivre normalement.

Malheureusement, certaines personnes s'arrêtent à ce stade...

6° Reconstruction

Il s'agit de la phase de test pendant laquelle la personne commence à s'ouvrir à nouveau aux autres et recommence des activités afin d'échapper à la douleur.

Commence alors le processus de reconstruction : la personne en deuil cherche des solutions et des moyens pour sortir de sa peine.

C'est l'amorce de la prochaine et dernière étape : l'acceptation.

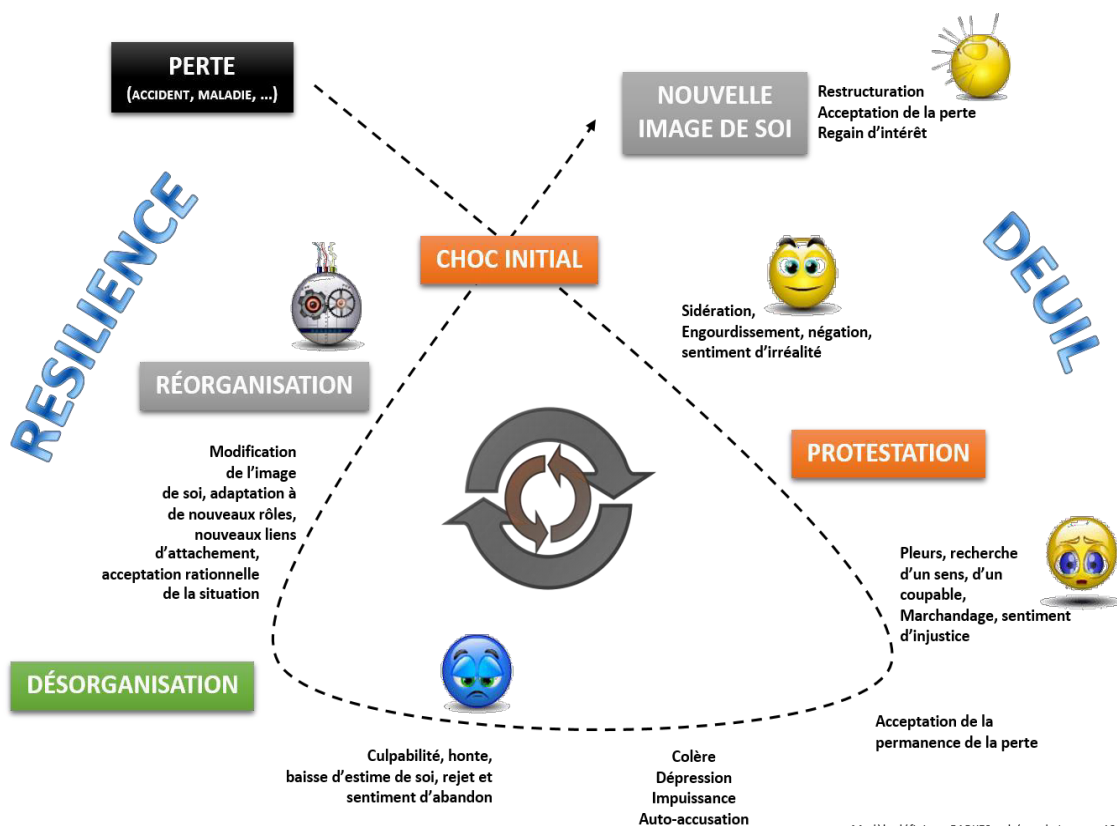
7° Acceptation

Stade où la personne endeuillée accepte la réalité.

La personne accepte ce qui ne peut être changé et recommence à croire en elle-même.

La réalité enfin acceptée, elle reprend le cours de sa vie.

La personne commence à se comporter normalement et que son travail professionnel s'améliore.



SITUATIONS DE HANDICAP

Définitions

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a défini, dans son article 114, la notion de handicap :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Plus d'un milliard de personnes soit environ 15% de la population mondiale, présentent une forme de handicap. La fréquence du handicap augmente en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques.

Classification des handicaps

La classification des handicaps est établie en fonction de 5 catégories

Le handicap moteur

Limitation pour un individu de se déplacer, de réaliser des gestes, ou de bouger certains membres.

L'atteinte de la motricité est partielle ou totale. Exemples : Paralysies, paraplégie, tétraplégie, amputations, infirmité motrice cérébrale, spina bifida, myopathie.

Le handicap sensoriel

Il fait référence aux difficultés liées aux organes sensoriels.

■ Le handicap visuel

■ Le handicap auditif : qui désigne une perte partielle (mal entendant) ou totale de l'audition

Le handicap psychique :

Pathologie mentale entraînant des troubles mentaux, affectifs et émotionnels. Perturbation de la personnalité, sans conséquences sur les fonctions intellectuelles. Exemples : schizophrène, bipolaires, Hypochondrie.

Le handicap mental

Déficience des fonctions mentales et intellectuelles, entraînant des difficultés de réflexion, de compréhension et de conceptualisation. La déficience provoque des problèmes d'expression et de communication.

Exemples : Autisme, Trisomie 21, Polyhandicap...

Les maladies invalidantes

Ces maladies évolutives génèrent un handicap. Exemples : Epilepsie, Sclérose en plaque, Parkinson...

Communication avec un patient handicapé

Handicap mental

Pour les personnes handicapées mentales, la difficulté de communication se traduit par un problème de compréhension et de prise de parole. Certaines utilisent un vocabulaire restreint ; pour d'autres c'est la construction des phrases qui reste complexe.

On parle de retard mental léger à profond. Il est important de se renseigner avant la prise de contact sur les capacités de communication du patient ainsi que sur ses habitudes et rituels (musique fétiche à passer pendant le transport, par exemple).

- Rester naturel, ne pas parler trop vite, sans pour autant infantiliser la personne.
- Utiliser le vouvoiement.
- S'adresser directement à la personne (même si elle est accompagnée).
- Utiliser des mots simples et des phrases courtes, formuler des idées et des réponses claires.
- Proposer de l'aide, mais ne pas faire à la place de la personne.

Le handicap mental ne se guérit pas. L'objectif est d'en réduire les conséquences
Laisser la plus grande autonomie possible

Handicap moteur

Les personnes atteintes d'un handicap moteur ou d'une déficience physique ont des possibilités limitées pour se déplacer, exécuter des tâches manuelles ou participer à certaines activités. Ces altérations n'entraînent **pas de spécificités** dans l'acte de communiquer sauf dans les cas où d'autres troubles sont associés.

- **Communiquer en face à face.**
- Si la personne est en fauteuil roulant et que l'échange direct dure un certain temps, **se mettre à sa hauteur ou s'asseoir.**
- Ne pas oublier le fauteuil roulant, la canne ou le déambulateur lors des transports sanitaires.

Handicap psychique (psychiatrique)

Le handicap psychique n'affecte pas les capacités intellectuelles, mais plutôt leur mise en œuvre. Le handicap psychique va s'illustrer par le retentissement personnel et social des troubles psychiques sur les capacités d'autonomie et d'adaptation des personnes.

Ce handicap n'est pas systématiquement visible. Les personnes qui en souffrent

éprouvent parfois des incapacités intellectuelles d'abstraction, de mémorisation, de concentration et donc de communication. Du fait de ses troubles attentionnels, la personne présentant un handicap psychique peut être confrontée à l'incompréhension des autres dans la vie sociale ou professionnelle.

Quelques conseils pour une bonne communication

- Eviter les ambiguïtés, les allusions, les doubles négations.
- Eviter le second degré, l'ironie, les métaphores et autres figures de style parfois un peu complexes.
- Être clair, précis dans ses propos, s'exprimer sans emportement.
- Tenir compte des spécificités de la pathologie

Handicap auditif

La surdité est un handicap de la communication qui ne se voit pas, ce qui entraîne souvent gêne et agacement chez les entendants. Le patient être autonome pour communiquer (lecture labiale et verbalisation possibles) ou souffrir d'une surdité totale précoce et ne pas verbaliser du tout (muet).

- Attirer, capter l'attention avant de démarrer le dialogue. Garder le contact visuel.
- Se placer face à la personne (suffisamment éclairé) pour permettre la lecture labiale.
- Ne pas tourner la tête ou cacher sa bouche avec un document.
- Parler lentement et distinctement (sans exagérer), en respectant des temps de pause pour vérifier si la personne a compris.
- Ne pas crier. Au besoin, se rapprocher.
- Parler du côté de l'oreille valide pour les patients malentendants de façon unilatérale.
- Faire des phrases courtes et simples.
- Faire quelques gestes pour renforcer le message verbal (mimer).
- Utiliser une personne ressource (langage des signes).
- Passer éventuellement par un support écrit (papier-crayon, téléphone portable en mode prise de notes...)
- Si le patient est appareillé, emmener, pour une hospitalisation longue, les appareils auditifs et accessoires (pile de rechange, matériel d'entretien, boîte, etc.).

Apprenez en souriant comment parler à un sourd ou malentendant...



*Ne soyez pas à contre-jour.
Veillez à ce que la lumière
ne l'éblouisse pas.*



*Placez-vous en face de lui,
à sa hauteur si possible.
Veillez à ce que vos lèvres soient visibles.*



*Ne lui parlez pas depuis une
autre pièce, ni en lui tournant le dos.*



*Ne cachez pas votre bouche.
Ne baissez pas votre tête.
Ne fumez pastrop.*



*Attirez doucement l'attention
de la personne avant de lui parler.*



*Réduisez les bruits de fond.
Parlez à voix égale et naturelle.*



*Ne vous énervez pas.
Ne criez pas : cela déforme l'articulation
et stressse votre interlocuteur.*



*Ne répétez pas dix fois les mêmes mots :
n'oubliez pas qu'il doit faire un effort
quand il est fatigué. Écrivez si c'est difficile.*



*Et souvenez-vous :
vos mains, votre visage, vos gestes,
tout votre corps parle.*

Handicap visuel

Les personnes malvoyantes et non-voyantes ne rencontrent pas de difficulté particulière en termes de communication verbale.

- Manifester une présence : présentation nom, fonction, prévenir oralement qu'on va serrer la main...
- Laisser lui toucher les objets utiles pour qu'elle se repère. Décrire les lieux, objets, personnes. L'accompagner en lui proposant le bras.
- Lui dire quand on la quitte, utiliser un vocabulaire très précis (notions spatiales précises telles que droite, gauche, position du brancard ...)
- Eviter de lui parler devant des sources sonores. Regarder son interlocuteur quand on parle, ne pas mettre ses mains devant sa bouche (attention aux bruits environnants).
- S'adresser directement à la personne déficiente visuelle et non à son entourage.
- Eviter les informations trop vagues du type « là-bas, par ici ».
- Ne pas toucher la personne déficiente visuelle sans la prévenir.

Parler lors des déplacements jusqu'au véhicule et décrire le véhicule pour valoriser le patient dans son autonomie lors du transport.

Difficultés d'élocution verbale

Se renseigner sur les codes de communications utilisés habituellement.

Pour un patient muet, habitué à gérer son handicap, utiliser la méthode qu'il utilise habituellement.

- Utiliser une personne ressource (langage des signes)
- Passer éventuellement par un support écrit (papier-crayon, tableau Velléda, téléphone portable en mode prise de notes...)

Dans des situations particulières de communication très altérée, s'adapter aux habitudes du patient ou faire preuve d'imagination.

- Exemple : patient tétraplégique non communiquant
 - ▶ Code avec clignement des paupières (1 pour OUI, 2 pour NON)
 - ▶ A l'aide d'un stylo placé dans la bouche, le patient pointe sur un tableau.
 - ▶ Tableau (ligne 1/ clignement de paupière, colonne 3/ clignement de paupière etc.)
- Exemple : patiente muette incarcérée de nuit ▶ signaux lumineux (1 pour OUI, 2 pour NON).